

منصة كلامي

الوثيقة التنفيذية الموحدة الكاملة للتصميم والبرمجة

نسخة المصدر الوحيد للحقيقة التنفيذية — جاهزة للتقديم إلى كلود وفريق البرمجة

الإصدار: 1.0 — 8 يوليو 2026

الحالة: معتمدة بعد دمج النسخة التنفيذية ذات 125 نقطة مع 33 تصحيحًا حاكمًا نهائيًا.

1. صفة الوثيقة وقاعدة الأولوية

هذه الوثيقة هي المرجع التنفيذي الأعلى لمنصة كلامي. يجب على كلود والمصمم والمبرمج ومهندس قاعدة البيانات ومختبر الجودة تنفيذها كوحدة واحدة لا يجوز اختيار نص قديم عند وجود تعارض، ولا يجوز اختراع منطق علاجي غير منصوص عليه.

- ترتيب الأولوية: آخر قرار صريح معتمد من مالك البرنامج – القواعد الحاكمة المدمجة في هذه الوثيقة – النسخة المعتمدة ذات 125 نقطة – الوثائق الأقدم – المقترحات غير المعتمدة.
- أي نص قديم يتعارض مع قاعدة حاكمة في هذه النسخة يُعد ملغى تلقائيًا.
- لا يجوز فتح مستوى لاحق أو تغيير المسار أو إصدار حكم سريري بواسطة النظام أو الذكاء الاصطناعي دون الصلاحية البشرية المعتمدة.
- المحتوى العلاجي، قوالب العينات، التعليمات، الأجزاء الإلزامية والاختيارية، والرسائل يجب أن تكون قابلة للإدارة من لوحة التحكم دون تعديل الكود.

2. الأمر التنفيذي الجاهز لكلود

أنت تعمل كمحلل نظم، ومهندس برمجيات، ومهندس قاعدة بيانات، وخبير تجربة مستخدم عربية RTL، وخبير جودة وأمن، تحت إشراف مالك المحتوى العلاجي. المطلوب هو تحليل التطبيق القائم ثم إصلاحه أو إعادة هندسة الأجزاء اللازمة بما يطابق هذه الوثيقة حرفيًا. ابدأ بتدقيق الكود وقاعدة البيانات والبنية الحالية، ثم قَدِّم خطة تنفيذ مرحلية لا تحذف بيانات أو تُغيّر قاعدة البيانات أو تعيد بناء مكوّن رئيسي قبل إنشاء نسخة احتياطية وتوثيق الأثر لا تختصر المنطق العلاجي، ولا تفتح المستويات آليًا، ولا تستخدم الذكاء الاصطناعي بدل القرار السريري البشري. عند وجود غموض حقيقي، أوقف تنفيذ النقطة وحدد السؤال المطلوب بدل التخمين.

3. النموذج العلاجي الحاكم بعد جميع التعديلات

- يبدأ جميع المرضى من المستوى العلاجي الأول نفسه، ثم يتدرجون طبيعيًا مستوى بعد مستوى.
- كل مستوى يجمع بين الجانب المعرفي والجانب السلوكي التدريبي، ويشاهد المريض النموذج العلاجي البشري قبل بدء أول تدريب.
- تبدأ دورة المستوى من أول تدريب فعلي مكتمل بعد مشاهدة النموذج، ومدتها الدنيا 72 ساعة.
- تقسم الـ 72 ساعة إلى ثلاث فترات متتابعة مدة كل منها 24 ساعة محسوبة من خادم النظام، وليس من الأيام التقويمية.
- يشترط لفتح بوابة العينة: اكتمال 72 ساعة + تدريب فعلي مكتمل واحد على الأقل في كل فترة من الفترات الثلاث.
- الجرعة العلاجية المستهدفة بقوة: 7 تدريبات يوميًا، وكل تدريب لا يقل عن 100 وحدة كلامية، لكنها ليست بوابة تقنية صارمة لفتح العينة.
- إذا كانت إحدى الفترات بلا تدريب، لا يعاد العداد من الصفر؛ يكمل المريض تدريبًا فعليًا بعد الساعة 72 لتعويض شرط النشاط الناقص ثم تفتح البوابة.
- بعد فتح بوابة العينة يستمر المريض في التدريب على المستوى نفسه حتى الإرسال، ثم يستمر أيضًا أثناء انتظار قرار الأخصائي.
- لا يمكن للمريض فتح أو مشاهدة أو التدرب على أي مستوى لاحق قبل موافقة الأخصائي الصريحة ووفق التدرج الطبيعي.

4. حالات التدريب المعتمدة

الحالة	القاعدة
التدريب الأساسي للمستوى النشط	يُحتسب ضمن الجرعة العلاجية ودورة الـ 72 ساعة.

تستمر بعد فتح البوابة ولا تنشئ دورة جديدة.	تدريبات استمرار بعد استحقاق العينة وقبل إرسالها
تستمر على المستوى نفسه حتى قرار الأخصائي.	تدريبات استمرار أثناء انتظار القرار
حق للمريض خارج وقت التدريب الأساسي؛ لا تُحتسب ضمن جرعة المستوى النشط أو فترات الـ 72 ساعة.	مراجعة وتقوية المستويات السابقة

5. العينة الرسمية المتكاملة

- العينة الرسمية عينة واحدة متكاملة بجميع أجزائها، وليست عينات مستقلة.
- يحدد مالك المحتوى قالب كل مستوى: الأجزاء، الترتيب، التعليمات، وما هو إلزامي أو اختياري.
- قد تشمل العينة بحسب المستوى: مقاطع، كلمات مفردة، عبارات، جمل، قراءة، وصف أو حديث. القوائم في المقاطع والكلمات المفردة متشابهة، ويظهر الفرق بصورة أوضح في العبارات والجمل وفق المحتوى المعتمد.
- يرسل المريض أفضل عينة يرى أنها تمثل أفضل أداء استطاع الوصول إليه، وليس شرطاً أن تكون مثالية أو خالية من التلثم.
- الفحص الآلي قبل الإرسال تقني فقط: وجود الصوت، سلامة الملف، قابلية التشغيل، واكتمال الأجزاء الإلزامية لا يجوز للنظام أو الذكاء الاصطناعي منع الإرسال بسبب حكم على جودة الأداء.
- قبل الإرسال النهائي يسأل النظام: «هل هذه أفضل عينة ترغب في إرسالها إلى الأخصائي؟» ثم يستكمل التقييم الذاتي والتوقع المرتبطين بالعينة نفسها.
- لا تظهر العينة للأخصائي إلا بعد نجاح الإرسال النهائي.

6. نظام المحاولات التجريبية

- لكل جلسة إعداد عينة حد أقصى 10 محاولات تسجيل فعلية إجمالاً.
- يمكن الخروج من جلسة الإعداد والعودة إليها مع حفظ المحاولات مؤقتاً، ولا يتجدد الرصيد عند العودة.
- حذف محاولة لا يعيد رصيدها.
- لا تُحتسب المحاولات التجريبية ضمن التدريب الأساسي.
- إذا استنفد المريض 10 محاولات دون اختيار عينة، تُغلق الجلسة بحالة «اكتملت المحاولات دون اختيار عينة»، ويعود للتدريب.
- بعد تدريب فعلي واحد مكتمل على الأقل يمكن فتح جلسة إعداد جديدة برصيد جديد حتى 10 محاولات، دون إعادة دورة 72 ساعة.
- إذا تكرر استنفاد المحاولات مرتين متتاليتين، يظهر تنبيه إرشادي للمريض ومؤشر للإدارة أو الفريق العلاجي دون إيقاف البرنامج تلقائياً.
- بعد إرسال العينة الرسمية، تُحذف المحاولات غير المختارة بعد 72 ساعة وفق سياسة الاحتفاظ المعتمدة.

7. قاعدة العينة الرسمية النشطة

- عينة رسمية نشطة واحدة فقط لكل دورة علاجية في الوقت نفسه.
- بعد إرسال العينة تُغلق بوابة إنشاء عينة رسمية جديدة لذلك المستوى حتى صدور القرار النهائي.
- تدريبات الانتظار لا تنشئ استحقاقاً لعينة ثانية مهما طالمت مدة الانتظار.
- لا يجوز للأخصائي طلب عينة إضافية للمقارنة خارج المسارات المعتمدة.

8. إعادة التسجيل التقني الجزئي

- إذا كان الخلل التقني في جزء واحد أو أكثر، لا يُطلب من المريض إعادة العينة كاملة.

- يحدد الأخصائي الأجزاء غير القابلة للتقييم فقط، ويفتح النظام «إعادة تسجيل جزئي لأسباب تقنية» للأجزاء المتضررة وحدها.
- تبقى الأجزاء السليمة محفوظة ولا تعاد تحت أي ظرف لمجرد وجود خلل في جزء آخر.
- تحصل جلسة الإعادة الجزئية على رصيد جديد يصل إلى 10 محاولات تجريبية.
- تُدمج الأجزاء المعادة مع الأجزاء السليمة تحت المعرّف الرسمي نفسه، مع حفظ تاريخ الإصدارات.
- حتى إذا كانت جميع الأجزاء متضررة تقنيًا، تعاد الأجزاء المطلوبة ضمن المسار التقني دون إنشاء دورة علاجية جديدة أو إعادة 72 ساعة.
- لا يصدر القرار النهائي حتى تصبح جميع الأجزاء الإلزامية قابلة للتقييم.

9. انتظار الأخصائي ومهل الخدمة

- يبدأ عداد انتظار مستقل عند الإرسال النهائي. الهدف التشغيلي لبدء مراجعة العينة هو خلال 24 ساعة.
- إذا لم يحجزها أخصائي خلال 24 ساعة، تتحول إلى «متأخرة دون بدء مراجعة» ويصعد النظام للمشرف أو مدير النظام.
- بعد حجز العينة، يجب على الأخصائي إكمال المراجعة أو اختيار مسار معتمد خلال 48 ساعة كحد أقصى.
- إذا انتهت 48 ساعة دون قرار أو مسار معتمد، ينتهي الحجز وتعود العينة إلى قائمة العينات المتاحة، ولا ينشأ مستحق مالي عن تقييم غير مكتمل.
- يفحص العينة أخصائي واحد فقط، ويمكن أن يكون أي أخصائي مؤهل دون تخصيص مسبق، لضمان الحقوق والجودة والجانب المالي.
- المسودة غير المكتملة تحفظ للتدقيق ولا تظهر للأخصائي الجديد قبل تقييمه المستقل.

10. قرارات الأخصائي المعتمدة

- الانتقال إلى المستوى التالي.
- إعادة المستوى وبدء دورة علاجية جديدة مدتها 72 ساعة بعد اطلاع المريض على التغذية الراجعة.
- إعادة تسجيل جزء أو أجزاء لأسباب تقنية.
- طلب تدخل مباشر قبل القرار، وهو حالة مؤقتة وليس قرار انتقال نهائيًا.

11. التدخل المباشر والاستشارة المجانية

- التدخل المباشر قد يكون لقاءً مرئيًا عن بعد، أو استشارة صوتية، أو رسالة/تعليمات موجهة، أو إجراءً سريريًا معتمدًا.
- للمريض أثناء تطبيق البرنامج استشارة مجانية واحدة فقط، يختار أن تكون مرئية أو صوتية وفق رغبته أو رغبة وليه؛ الاستشارة الصوتية بديل عن المرئية وليست رصيدًا إضافيًا.
- الرسائل متاحة وفق سياسة التواصل ولا تُعد تلقائيًا استهلاكًا لرصيد الاستشارة المجانية.
- إذا اختار الأخصائي التدخل المباشر خلال مهلة الـ 48 ساعة مع سبب سريري موثق، تتوقف مهلة المراجعة الأولى وتبدأ حالة «بانتظار تنفيذ التدخل المباشر».
- إذا لم ينفذ التدخل خلال 7 أيام، يصعد النظام للمشرف دون قرار علاجي آلي.
- بعد توثيق اكتمال التدخل، يبدأ عداد جديد 48 ساعة كحد أقصى لإصدار القرار النهائي.
- يبقى المريض مندرجًا على المستوى نفسه أثناء انتظار التدخل والقرار، ما لم يصدر توجيه سريري موثق بإيقاف التدريب أو تعديله.

12. المسؤولية السريرية ونقلها

- تبقى المسؤولية عن القرار النهائي للأخصائي الذي حجز العينة وبدأ مراجعتها، حتى لو نفذ التدخل أخصائي آخر.
- منفذ التدخل يوثق النتيجة ولا يملك تلقائيًا قرار الانتقال أو الإعادة.

- يجوز للمشرف نقل المسؤولية رسميًا عند التعذر، مع توثيق السبب والوقت وهوية الأخصائي السابق والجديد.
- يجب على الأخصائي الجديد مراجعة العينة الأصلية بنفسه قبل القرار.
- لا يوجد أكثر من أخصائي واحد مسؤول عن القرار النهائي في اللحظة نفسها.
- لا يؤدي نقل المسؤولية إلى مستحقين مالمين كاملين عن مراجعة واحدة.

13. نفاذ القرار وسلوك النظام

- قرار الأخصائي نافذ فور اعتماده النهائي، ولا يتوقف نفاذه على فتح المريض للإشعار.
- مع ذلك، يجب أن يرى المريض القرار والخطوة التالية قبل بدء أي تدريب جديد.
- إذا صدر قرار الانتقال أثناء تدريب أساسي بدأ قبل القرار، يسمح بإكمال ذلك التدريب فقط ثم تعرض النتيجة.
- إذا صدر قرار إعادة المستوى أثناء تدريب جارٍ، يسمح بإكمال التدريب فقط ويصنف ضمن الدورة السابقة، ثم تعرض التغذية الراجعة قبل بدء دورة الإعادة.
- إذا صدر القرار أثناء مراجعة مستوى سابق، يسمح بإكمال المراجعة الجارية فقط، ولا يبدأ نشاط جديد قبل عرض القرار.
- لا يبدأ عداد 72 ساعة للمستوى الجديد أو لدورة الإعادة إلا من أول تدريب فعلي مكتمل في المستوى النشط بعد مشاهدة النموذج/التعليمات المطلوبة.

14. تصحيح القرار المعتمد

- لا يجوز تعديل قرار سريري معتمد تعديلًا صامتًا.
- يستخدم إجراء «تصحيح قرار معتمد» مع حفظ القرار السابق والجديد والسبب ومن طلب واعتمد التصحيح.
- إذا لم يبدأ المريض تدريبًا فعليًا في المستوى الجديد، يمكن تطبيق التصحيح وفق الصلاحية والتوثيق.
- إذا بدأ مسارًا جديدًا فعليًا، تتحول الحالة إلى «تصحيح قرار مؤثر في مسار بدأ تنفيذه» وتتطلب مراجعة سريرية وإدارية موثقة.
- لا تحذف التدريبات التي تمت بين القرارين، بل تحفظ تاريخيًا.

15. إعادة المستوى

- تبدأ دورة إعادة المستوى بعد اطلاع المريض على قرار الأخصائي والتغذية الراجعة.
- تبدأ الـ 72 ساعة الجديدة من أول تدريب فعلي مكتمل بعد الاطلاع.
- تدريبات الاستمرار أثناء انتظار القرار لا تُحتسب بأثر رجعي ضمن دورة الإعادة الجديدة.
- لا تحذف الدورة السابقة أو عينتها أو تقييماها.

16. مراجعة المستويات السابقة

- يحق للمريض مراجعة المستويات السابقة التي اجتازها في أي وقت خارج وقت التدريب الأساسي.
- تظهر واجهتان واضحتان: «تدريبي الحالي» و«مراجعة المستويات السابقة».
- المراجعة لا تخصم من الجرعة الأساسية ولا تحتسب ضمن فترات 72 ساعة ولا تفتح عينة ولا تغير قرار الانتقال.
- المستويات اللاحقة غير المجتازة مغلقة بالكامل.

17. الانقطاع

- يحسب الانقطاع من آخر نشاط علاجي فعلي موثق، لا من آخر تسجيل دخول أو فتح إشعار.
- تشمل الأنشطة العلاجية: التدريب، إرسال العينة، تنفيذ مهمة أو تقييم مطلوب، حضور استشارة مرتبطة بالبرنامج، أو نشاط يعتمد مالمك المحتوى.
- انتظار قرار الأخصائي لا يحسب انقطاعًا على المريض.

- المدة الافتراضية للإغلاق بسبب الانقطاع شهر واحد، قابلة للضبط إداريًا دون أثر رجعي إلا بقرار موثق.
- بعد الإغلاق بسبب الانقطاع والعودة، يبدأ مسار علاجي جديد من المستوى الأول مع الاحتفاظ بالسجل التاريخي وربطه بالمسار الجديد.

18. انتهاء الباقية أثناء مسار سريري قائم

- الحقوق العلاجية التي بدأت بصورة صحيحة أثناء صلاحية الباقية تستكمل حتى نهايتها المنطقية.
- العينة المرسلّة قبل انتهاء الباقية تستمر حتى القرار النهائي، بما في ذلك التدخل وتصحيح القرار.
- إعادة التسجيل التقني حق مستمر لأنه استكمال لخدمة بدأت أثناء الصلاحية.
- بدء دورة علاجية جديدة بعد قرار الانتقال أو إعادة المستوى يخضع لصلاحية الباقية أو التجديد.
- انتهاء الاستحقاق التجاري لا يغلق تلقائيًا المسار السريري الجاري.

19. حالات النظام المطلوبة

- ACTIVE_LEVEL_TRAINING — تدريب المستوى النشط
- SAMPLE_ELIGIBLE — مستحق للعينة مع استمرار التدريب
- SAMPLE_PREPARATION — إعداد العينة
- SAMPLE_SUBMITTED — أرسلت العينة
- WAITING_FOR_SPECIALIST — انتظار الحجز
- UNDER_REVIEW — قيد مراجعة الأخصائي
- DIRECT_INTERVENTION_REQUIRED — تدخل مباشر مطلوب
- WAITING_FINAL_DECISION_AFTER_INTERVENTION — انتظار القرار بعد التدخل
- TECHNICAL_PARTIAL_RERECORD — إعادة تسجيل تقني جزئي
- LEVEL_REPEAT_DECIDED — قرار إعادة المستوى بانتظار اطلاع المريض
- NEXT_LEVEL_APPROVED — الانتقال معتمد بانتظار عرض القرار
- CLOSED_DUE_TO_INACTIVITY — مغلق بسبب الانقطاع
- SUBSCRIPTION_EXPIRED_CLINICAL_FLOW_OPEN — انتهى الاستحقاق التجاري مع مسار سريري قائم

20. نموذج البيانات الأدنى المطلوب

- المريض/ولي الأمر، البرنامج، المسار العلاجي، المستوى، دورة المستوى، جلسة التدريب، نشاط المراجعة الحرة.
- قالب العينة، أجزاء العينة، جلسة إعداد العينة، محاولة التسجيل، العينة الرسمية، إصدارات الأجزاء.
- الحجز السريري، الأخصائي المسؤول، سجل النقل، المراجعة، القرار، تصحيح القرار.
- التدخل المباشر، نوعه، مواعده، منفذه، نتيجته.
- الاستشارة المجانية ورصيدها ونوعها المرئي أو الصوتي.
- الاشتراك والاستحقاق التجاري والحقوق السريرية القائمة.
- الإشعارات والتصعيدات وسجل التدقيق والمستحقات المالية.

21. مؤشرات الجودة والتشغيل

- متوسط زمن انتظار العينة قبل الحجز.
- نسبة العينات التي بدأت مراجعتها خلال 24 ساعة.
- متوسط زمن المراجعة بعد الحجز ونسبة الالتزام بعد 48 ساعة.

- عدد مرات استخدام التدخل المباشر ومدته.
- عدد إعادة التسجيل التقني الجزئي وأسبابها.
- نسبة فجوات الالتزام في فترات الـ 24 ساعة.
- عدد مرات استنفاد 10 محاولات دون اختيار عينة.
- عدد نقل المسؤولية السريرية وحالات ازدواج الاستحقاق الممنوعة.
- معدل الانقطاع والعودة.

22. معايير القبول الحرجة قبل التسليم

- AC-01: لا يفتح أي مستوى لاحق قبل موافقة الأخصائي والتدرج الطبيعي.
- AC-02: لا تفتح بوابة العينة بمجرد مرور الوقت إذا لم يوجد تدريب فعلي في الفترات الثلاث.
- AC-03: يستمر التدريب قبل الإرسال وأثناء انتظار القرار.
- AC-04: لا توجد أكثر من عينة رسمية نشطة للدورة نفسها.
- AC-05: الحد الأقصى للمحاولات 10 تسجيلات فعلية، والحذف لا يعيد الرصيد.
- AC-06: لا يعيد المريض جزءًا سليمًا بسبب تلف جزء آخر.
- AC-07: الأخصائي الواحد يراجع العينة المتكاملة كلها.
- AC-08: يعمل عداد 24 ساعة قبل الحجز و48 ساعة بعد الحجز بصورة مستقلة.
- AC-09: التدخل المباشر يوقف عداد المراجعة الأول ويبدأ مساره ثم 48 ساعة جديدة بعد اكتماله.
- AC-10: الاستشارة المجانية واحدة فقط: مرئية أو صوتية باختيار المريض/الولي.
- AC-11: مراجعة المستويات السابقة لا تؤثر في جرعة المستوى النشط.
- AC-12: كل تغيير سريري أو إداري جوهري مسجل في سجل تدقيق.

23. خطة التنفيذ المطلوبة من كلود

- المرحلة 1: تدقيق الكود الحالي وقاعدة البيانات والملفات والتخزين والصلاحيات وإخراج تقرير فجوات مقابل هذه الوثيقة.
- المرحلة 2: إنشاء نسخة احتياطية وخطة ترحيل بيانات وخريطة أثر قبل أي تغيير كبير.
- المرحلة 3: بناء/تصحيح محرك الحالات والانتقالات أولًا، ثم التدريب، ثم العينات، ثم لوحة الأخصائي.
- المرحلة 4: تنفيذ الإشعارات والتصعيدات والمستحقات وسجل التدقيق.
- المرحلة 5: اختبارات وحدات وتكامل ونهاية-إلى-نهاية لكل معيار قبول.
- المرحلة 6: تسليم قائمة الملفات المعدلة، مخطط قاعدة البيانات، تعليمات التشغيل، نتائج الاختبارات، والمشكلات المتبقية دون إخفائها.

24. سجل التصحيحات الحاكمة الـ 33

- 1. حساب الانقطاع من آخر نشاط علاجي فعلي
- 2. مهلة مراجعة العينة 48 ساعة
- 3. هدف بدء المراجعة خلال 24 ساعة
- 4. نفاذ قرار الأخصائي فور الاعتماد
- 5. إعادة التسجيل التقني برصيد جديد
- 6. تعريف التدخل المباشر
- 7. مسؤولية القرار بعد التدخل

- 8. التوفيق بين 48 ساعة والتدخل المباشر
- 9. استكمال الحقوق السريرية بعد انتهاء الباقية
- 10. أولوية القرارات الأحداث
- 11. تعريف النشاط الفعلي داخل 72 ساعة
- 12. تعريف الفترات الثلاث ذات 24 ساعة
- 13. استمرار التدريب أثناء انتظار القرار
- 14. فصل تدريبات الانتظار عن دورة الإعادة وحق مراجعة المستويات السابقة
- 15. إكمال التدريب الجاري عند قرار الانتقال
- 16. ضبط تصحيح قرار الانتقال
- 17. منع الاطلاع أو التدريب على مستوى لاحق قبل موافقة الأخصائي
- 18. قرار الإعادة أثناء تدريب جارٍ
- 19. قرار الأخصائي أثناء مراجعة مستوى سابق
- 20. منع العينة الرسمية الثانية أثناء انتظار القرار
- 21. استمرار التدريب بعد فتح بوابة العينة
- 22. حفظ جلسة إعداد العينة والحد الأقصى 10 محاولات
- 23. التعامل مع استنفاد المحاولات العشر
- 24. تعريف العينة الجيدة
- 25. اكتمال جميع أجزاء العينة الرسمية
- 26. إعادة الجزء المتضرر تقنيًا فقط
- 27. الاستشارة المجانية المرئية أو الصوتية
- 28. العينة حزمة واحدة بجميع أجزائها
- 29. فحص العينة بواسطة أخصائي مؤهل واحد
- 30. عدم احتساب انتظار الأخصائي انقطاعًا
- 31. التدريب بعد مشاهدة النموذج وبدء أول تدريب
- 32. اعتماد 72 ساعة بدل 3 أيام
- 33. استمرار المسار بالتدرج الطبيعي فقط

25. النص الأساسي التفصيلي المعتمد ذو 125 نقطة

يُدرج أدناه النص التفصيلي الكامل للنسخة المعتمدة ذات 125 نقطة بوصفه الطبقة التنفيذية التفصيلية. عند أي تعارض، تطبق القواعد الحاكمة الواردة في الأقسام 1-24 من هذه الوثيقة.

الوثيقة التنفيذية المتكاملة الفعلية للمنصة العلاجية الرقمية للتلعثم

مرجع واحد للتصميم والبرمجة وإصلاح النظام الحالي واستكمال

حالة الوثيقة: النسخة التنفيذية الموحدة المبنية على وثيقة المتطلبات الأصلية، ومحتوى الجلسات المعرفية، والقرارات العلاجية والتقنية المعتمدة خلال المراجعة.

0. كيفية استخدام هذه الوثيقة

- هذه الوثيقة هي المرجع الحاكم لفهم النظام وإصلاحه وبرمجته. لا يحتاج فريق التطوير إلى الرجوع إلى وصف مختصر آخر لفهم المنطق العلاجي.
- عند وجود تعارض بين منطق قديم في النظام الحالي وبين القواعد الواردة هنا، تُعتمد القواعد العلاجية النهائية الواردة في هذه الوثيقة.
- لا يجوز حذف أو تبسيط عنصر علاجي أو تشخيصي لمجرد تسهيل البرمجة. أي تغيير في المنطق العلاجي يحتاج اعتماد الإدارة العلمية.
- المحتوى، والتعليمات، والفيديوهات، والأسئلة، والقوائم، وقواعد العرض، وقوالب التقارير يجب أن تكون قابلة للإدارة من لوحة التحكم، لا مثبتة داخل الكود.

1. تعريف المنتج والغرض منه

- منصة رقمية لتقديم التشخيص والعلاج والمتابعة لحالات اضطرابات التواصل، ويبدأ نطاقها العلاجي بالتلعثم.
- تحوّل البرنامج العلاجي من نموذج عيادي إلى رحلة رقمية تفاعلية يتفاعل فيها المستفيد مع النظام والمحتوى والنموذج العلاجي والأخصائي.
- تخدم البالغين والمراهقين والأطفال المصاحبين لأولياء أمورهم، مع فروق بسيطة في العرض والتعليمات والقوائم بحسب الفئة العمرية.
- تدعم المستفيد، وولي الأمر عند الحاجة، والأخصائي، والمشرف العلمي، والإدارة، والدعم، والمالية.
- تهدف إلى توسيع الوصول، وخفض التكلفة، ورفع الالتزام، وتمكين المتابعة، ودعم البحث والتطوير، وتنمية مهارات المختصين.

2. المبادئ العلاجية الحاكمة

- يبدأ جميع المرضى من المستوى العلاجي الأول نفسه.
- البرنامج ليس تدريبيًا سلوكيًا فقط؛ كل مستوى يجمع بين جانب معرفي علاجي وجانب سلوكي تدريبي.
- المستفيد يتدرج من الأسهل إلى الأصعب حتى الوصول إلى الكلام الطبيعي ثم التعميم والمتابعة.
- التدريب المكثف يهدف إلى بناء عادة كلامية جيدة قائمة على الطلاقة وإضعاف عادة كلامية سيئة مرتبطة بالتلعثم.
- الجرعة العلاجية تبني المهارة، لكن النتيجة الفعلية هي التي تحكم الانتقال.
- الانتقال قرار سريري للأخصائي، وليس قرارًا آليًا يعتمد على الوقت أو عدد النقرات أو عدد مرات فتح التدريب.
- المستفيد يستطيع الرجوع إلى التدريبات السابقة المفتوحة للتقوية والتدريب الحر دون فقد تقدمه.
- لا يستطيع المستفيد القفز إلى مستوى مستقبلي غير معتمد.

3. رحلة المستفيد الكاملة

1. التعريف بالمنصة والمشكلة والخدمات وطريقة العمل.

2. إنشاء الحساب وتحديد الفئة العمرية والدور والموافقات.

3. مرحلة التقييم والتشخيص: البيانات والتاريخ المرضي والاختبارات والعينات والمقابلة.

4. تجميع النتائج في سجل تشخيصي موحد.

5. إنشاء مسودة تقرير تشخيصي آلي ومراجعتها واعتمادها من الأخصائي.

6. عرض النتيجة وخيارات الاستمرار في البرنامج العلاجي.

7. بدء المستوى الأول للجميع.

8. إكمال الجانب المعرفي للمستوى.

9. مشاهدة النموذج العلاجي البشري وفهم التقنية.

10. التدريب المكثف خلال دورة 72 ساعة.

11. بعد مرور 72 ساعة: إرسال عينة 3 دقائق + تقييم ذاتي + توقع العينة القادمة.

12. مراجعة الأخصائي وإصدار القرار.

13. الانتقال للمستوى التالي أو إعادة دورة 72 ساعة في المستوى نفسه.

14. التدرج إلى الكلام الطبيعي والتعميم في مواقف الحياة.

15. المتابعة والوقاية من الانتكاس.

4. نظام التقييم والتشخيص

4.1 مصادر البيانات

- البيانات الأساسية وبيانات التواصل.
- التاريخ المرضي والنمائي والعلاجي والاجتماعي ذي الصلة.
- المعلومات المقدمة من المستفيد أو ولي الأمر.
- نتائج OASES.
- نتائج مقياس الرضا الكلامي والمقاييس الأخرى المعتمدة.
- نتائج SSI-4 التي يدخلها الأخصائي في جدول منظم بعد تحليل العينة.
- عينة أو عينات الكلام المطلوبة للتشخيص.
- المقابلة الشخصية مع الأخصائي.
- الملاحظات السريرية.

4.2 طريقة العرض للمستفيد

- تعرض الأسئلة تدريجيًا، بسؤال واحد أو مجموعة صغيرة مترابطة، خاصة على الهاتف.
- يدعم النظام المنطق الشرطي، فلا تظهر الأسئلة غير ذات الصلة.
- يدعم الحفظ التلقائي والاستكمال لاحقًا وشرط التقدم.
- تظهر خيارات مثل لا أعرف، لا أتذكر، لا ينطبق، عندما تكون مناسبة علميًا.
- قبل كل اختبار تظهر تهيئة قصيرة: الهدف، المدة، طريقة الإجابة، وما يحتاجه المستفيد.
- الأدوات المقننة تحافظ على بنيتها وقواعدها وحقوق استخدامها.

4.3 اللقاء التشخيصي

- يدعم النظام لقاء المختص في مرحلة التشخيص.
- يرى الأخصائي قبل اللقاء ملخصًا لما جُمع لتقليل تكرار الأسئلة.
- تسجل المقابلة في نموذج منظم بمحاور، مع مساحة للنص الحر.
- أي تعديل على معلومة أصلية يحفظ المصدر والتاريخ ومن قام بالتعديل.

4.4 السجل التشخيصي الموحد والتقارير الآلي

- يستخلص النظام نتائج الاختبارات ويضعها في جداول منظمة.
- يجمع OASES والرضا الكلامي وSSI-4 والتاريخ المرضي والمقابلة والعينات في سجل واحد.
- لكل نتيجة: المجال، المصدر، القيمة، التفسير، التاريخ، حالة المراجعة، ووجود نقص أو تعارض.
- ينشئ النظام مسودة تقرير تشخيصي آلي من البيانات المتاحة فقط.
- لا يخترع النظام معلومات ناقصة.
- يمكن تتبع كل فقرة مهمة في التقرير إلى مصدرها.
- يراجع الأخصائي التقرير ويعدله ويعتمده قبل اعتباره تقريرًا نهائيًا.

5. البنية الفعلية لكل مستوى علاجي

كل مستوى علاجي يتكون من مسارين متكاملين:

5.1 الجانب المعرفي العلاجي

- يتضمن في الأصل مقطعي فيديو معرفيين وأسئلة مرتبطة بهما، وفق محتوى المستوى.
- يحفظ النظام إجابات المستفيد ويستخدمها في تقرير الجلسة والمتابعة.
- الموضوعات المعرفية تشمل - بحسب تسلسل البرنامج - تعريف المشكلة، مراحل تطورها، اكتساب عادة جديدة، التفكير الإيجابي، البطء والروية، التحفيز، الخوف والقلق، التجنب والتفادي، المسؤولية، تقبل الذات، الكشف عن الذات، تغيير التفكير، والتعامل مع النجاح والفشل والتعميم.
- يجب إدخال المحتوى المعرفي كعناصر قابلة للإدارة: فيديو، عنوان، هدف، أسئلة، خيارات، إجابة صحيحة، تفسير، ترتيب، وفئة عمرية.
- لا يجوز اختزال الجانب المعرفي إلى فيديو ترفيهي؛ هو مكوّن علاجي أصيل.

5.2 الجانب السلوكي التدريبي

- يشاهد المستفيد نموذجًا علاجيًا بشريًا حقيقيًا يؤدي المهارة المطلوبة.
- يشاهد أولاً ثم يكرر بعد النموذج.
- ليس من الضروري مشاهدة النموذج في كل مرة تدريبية.
- النموذج يشرح بما يكفي، ثم يعرض الأداء الصحيح بصورة واضحة.
- يمكن أن يكون النموذج المختصر نحو 3 دقائق، مع جعل المدة قابلة للإدارة حسب المستوى.
- يطبق المستفيد التقنيات على قائمة ثابتة لكل مرحلة عمرية.

6. التقنيات وعناصر الأداء

- البطء والتحكم في سرعة الكلام.
 - الإطالة أو الكلام المطول وفق المستوى.
 - تزامن نطق المقطع أو الكلمة أو الجملة مع حركة اليد.
 - مدة التزامن والتوقيت.
 - فتح الفم بصورة واضحة أثناء التدريب.
 - رفع الصوت بصورة واضحة أثناء التدريب، مع تجنب تحويله إلى صراخ.
 - التدرج في تخفيف الأداء المتعمد حتى الوصول إلى الكلام الطبيعي.
 - أي تقنيات أو عناصر إضافية موجودة في تسلسل البرنامج الأصلي تُدار ضمن المستوى ولا تُلغى.
- يجب أن يكون لكل تقنية: تعريف، هدف، شرح، نموذج، مستوى شدة، وحدة كلامية، أخطاء شائعة، معيار مراجعة، وعلاقة بالمستوى.

7. النموذج العلاجي البشري

- النموذج شخص حقيقي، وليس شخصية كرتونية، لأن المستفيد يحتاج رؤية دقيقة لحركة الفم واليد والتوقيت والأداء الصوتي.
- التصوير أمامي وواضح للوجه والجزء العلوي من الجسم واليدين، مع لقطات أقرب عند الحاجة.
- الصوت نقي، والخلفية بسيطة، والإضاءة ثابتة.
- النموذج يعرض الأداء الصحيح، ويمكن إعادة تشغيله.
- مواد النموذج قصيرة وقابلة للربط بالمستوى والفئة العمرية والتقنيات والقائمة.
- المرشد الرقمي - إن استخدم - يشرح ويوجه ويشجع، لكنه منفصل عن النموذج العلاجي البشري.

8. محرك التدريب المكثف ودورة 72 ساعة

- في كل مرة تدريبية يطبق المستفيد التقنية على ما لا يقل عن 100 مقطع أو كلمة أو جملة، حسب المستوى.
- الجرعة المستهدفة 7 مرات يوميًا.
- بين كل مرة والتي تليها توقف لا يقل عن ساعة.
- الهدف من التكرار المكثف هو خلق عادة كلامية جيدة قائمة على الطلاقة والتخلص تدريجيًا من عادة التلعثم.
- عدد مرات التدريب يسجل كمؤشر التزام، لكنه ليس شرطًا تقنيًا للانتقال في النسخة الحالية.
- بوابة إرسال العينة تفتح بعد مرور 72 ساعة من بدء دورة المستوى.
- لا يمنع النظام إرسال العينة بسبب عدم تسجيل 21 تدريبًا.
- يمكن مستقبلًا إضافة حد أدنى للجرعة إذا أثبتت النتائج العلاجية الحاجة إليه، دون إعادة بناء النظام.

9. بوابة العينة بعد 72 ساعة

- بعد مرور 72 ساعة يفتح النظام مهمة إرسال العينة.

- مدة العينة 3 دقائق.

- نوع العينة يختلف حسب المرحلة.

- يرسل المستفيد أفضل عينة مطلوبة وفق تعليمات المرحلة.

- يكمل المستفيد التقييم الذاتي للعينة عبر نموذج منظم يتضمن: درجة الأداء على مقياس 1-9، مدى نجاحه في تطبيق التقنية المستهدفة، مستوى التحكم والبطء، مدى التزامن بين الكلام وحركة اليد عند انطباقه، وضوح فتح الفم، وضوح رفع الصوت، مستوى الرضا عن العينة، وأبرز صعوبة واجهها. تُحفظ كل إجابة كحقل مستقل قابل للمقارنة زمنيًا.

- يسجل المستفيد توقعه للعينة القادمة في نموذج مستقل يتضمن: الدرجة المتوقعة على مقياس 1-9، هل يتوقع أن تكون العينة القادمة أفضل أو مماثلة أو أقل من الحالية، والسبب المختصر لتوقعه. تُحفظ هذه البيانات للمقارنة بين التوقع والنتيجة الفعلية القادمة.

- ترتبط الحزمة بالمستوى والنموذج والقائمة والتقنيات ودورة 72 ساعة.

10. مراجعة الأخصائي وقرار الانتقال

- يرى الأخصائي في شاشة واحدة: المستوى، النموذج، التقنيات، سجل التدريب، العينة الحالية، التقييم الذاتي، توقع العينة القادمة، والعينات السابقة.
- يقارن العينة بالنموذج والعينات السابقة.
- يراجع: تزامن حركة اليد مع الكلام، مدة التزامن، البطء والتحكم، رفع الصوت، وفتح الفم.
- يوثق رأيه ودرجته وملاحظاته.
- القرار إما: انتقال إلى المستوى التالي، أو إعادة المستوى نفسه 72 ساعة، أو تدخل مباشر عند الحاجة.
- إذا لم ينجح المستفيد، يعيد الدورة كاملة بالنموذج والقائمة نفسيهما.
- لا تحذف الدورة السابقة؛ تنشأ دورة جديدة مستقلة للمقارنة الزمنية.

11. الرجوع للخلف والاستشارات

- يمكن للمستفيد الرجوع إلى أي تدريب سابق مفتوح للتقوية والتدريب الحر.
- الرجوع لا يلغي التقدم ولا يعيد ضبط المستوى الحالي.
- الرجوع الحر لا يفتح مسار إرسال عينة مراجعة لذلك المستوى.
- للمستفيد استشارة واحدة مجانية مع الأخصائي خلال البرنامج.
- بعد الاستشارة المجانية، تكون الاستشارات الإضافية مدفوعة وفق سياسة المنصة.

12. التدرج إلى الكلام الطبيعي والتعميم والمتابعة

- البرنامج يتدرج سلوكيًا حتى يصل المستفيد إلى الكلام الطبيعي.
- يخفف الأداء المتعمد أو المبالغ فيه تدريجيًا وفق مستويات البرنامج.
- ينتقل التدريب من الوحدات الكلامية المنظمة إلى مواقف أكثر طبيعية.
- يدعم التعميم في الأسرة، والمكالمات، والمدرسة، والعمل، والغرباء، والمواقف الصعبة بحسب المرحلة.
- بعد الإكمال، يدعم النظام المتابعة الدورية والوقاية من الانتكاس والعينات اللاحقة وفق البروتوكول.
- تُحفظ نتائج القياس قبل العلاج وبعده وفي نقاط المتابعة الزمنية المعتمدة.

13. نظام التعليمات والتوجيه

- قبل المهمة: ماذا ستفعل، لماذا، الوقت المتوقع، وما الذي تحتاجه.
- أثناء المهمة: توجيه قصير مرتبط بالخطوة الحالية.
- عند الطلب: زر مساعدة يعرض نصًا أو صورة أو فيديو.
- عند الخطأ: رسالة تشرح المشكلة والإجراء التالي بلغة مفهومة.
- بعد الإكمال: تأكيد الحفظ والخطوة التالية.
- التعليمات تختلف حسب الطفل والمراهق والبالغ وولي الأمر.
- يدعم النظام النص والصوت والصورة، وإعادة الشرح، وإيقاف الصوت، وتقليل الحركة.

14. إدارة المحتوى من لوحة التحكم

- المستويات وترتيبها وحالتها.
 - الفيديوهات المعرفية وأسئلتها وإجاباتها.
 - النماذج العلاجية البشرية.
 - قوائم المقاطع والكلمات والجمل لكل فئة عمرية.
 - التقنيات وعناصر الأداء المرتبطة بكل مستوى.
 - تعليمات التدريب والعينات والأخطاء.
 - أنواع العينات ومدتها.
 - نماذج التقييم الذاتي والتوقع.
 - قوالب التقارير.
 - قواعد ظهور المرشد الرقمي.
 - الرسائل والإشعارات.
 - سياسات الاستشارات المجانية والمدفوعة.
 - صلاحيات المستخدمين.
- كل محتوى مهم يدعم: مسودة ← معاينة ← اعتماد ← نشر ← إصدار جديد ← سجل تعديلات.

15. الأدوار والصلاحيات

- المستفيد: تنفيذ الرحلة، التدريب، إرسال العينات، الاطلاع على النتائج المسموحة.
- ولي الأمر: دعم الطفل والاطلاع وفق الصلاحيات.
- الأخصائي: التشخيص، مراجعة التقرير، مراجعة العينات، قرارات الانتقال، الاستشارات.
- المشرف العلمي: اعتماد المحتوى والقواعد العلاجية ومراجعة الجودة.
- مدير المحتوى: إدارة المواد دون صلاحية تغيير القرارات السريرية الحساسة إلا إذا كان مخوَّلاً.
- الإدارة: المستخدمون، الاشتراكات، التقارير، الصلاحيات، التشغيل.
- الدعم والمالية: صلاحيات محدودة حسب الحاجة.

16. الإشعارات

- بدء مستوى جديد.
- تذكير بالتدريب دون تحويله إلى شرط نجاح.
- إتاحة التدريب التالي بعد الفاصل الزمني.
- اكتمال 72 ساعة وفتح بوابة العينة.
- استلام العينة.
- وجود قرار جديد من الأخصائي.
- إعادة المستوى أو فتح المستوى التالي.
- موعد استشارة أو طلب دفع.
- متابعة بعد الإكمال.

17. نموذج البيانات الأساسي

User / Profile / AgeGroup / Guardian •

AssessmentEpisode / MedicalHistory / Interview •

Instrument / InstrumentVersion / Response / Score •

SpeechSample / SSI4Record / UnifiedDiagnosticRecord •

DiagnosticReport / ReportVersion / Approval •

Program / Level / LevelVersion •

CognitiveContent / Video / Question / Answer •

BehavioralTechnique / HumanModel / TrainingList / TrainingItem •

TrainingCycle72h / TrainingEvent / AdherenceLog •

SelfEvaluation / NextSamplePrediction •

SpecialistReview / PerformanceCriterion / TransitionDecision •

Consultation / Payment / Notification •

ContentVersion / AuditLog / Permission •

18. قواعد الأعمال الحرجة

- الجميع يبدأ من المستوى الأول.
- كل مستوى يجمع الجانب المعرفي والسلوكي.
- 100 وحدة على الأقل في كل مرة تدريبية.
- 7 مرات يوميًا جرعة مستهدفة وليست بوابة تقنية.
- فاصل ساعة على الأقل بين التدريبات المستهدفة.
- مرور 72 ساعة يفتح بوابة العينة.
- العينة 3 دقائق ونوعها حسب المرحلة.
- الانتقال لا يحدث تلقائيًا.
- قرار الأخصائي هو الذي يفتح المستوى التالي.
- الإعادة تنشئ دورة جديدة بالنموذج والقائمة نفسيهما.
- السجلات السابقة لا تُحذف.
- الرجوع للخلف للتقوية مسموح.
- استشارة واحدة مجانية ثم مدفوعة.
- التقرير الآلي مسودة حتى اعتماد المختص.
- المحتوى قابل للإدارة دون تعديل الكود.

19. معايير القبول الحرجة

- مستخدم جديد لا يستطيع بدء مستوى غير المستوى الأول.
- المستوى يعرض مكوناته المعرفية والسلوكية الصحيحة.
- يمكن للإدارة تغيير فيديو أو سؤال أو قائمة أو تعليمات دون نشر كود جديد.
- تفتح بوابة العينة بعد 72 ساعة حتى لو لم يسجل المستخدم 21 تدريبًا.
- تُحفظ العينة والتقييم الذاتي والتوقع في حزمة واحدة.
- يرى الأخصائي عناصر المراجعة في شاشة موحدة.
- لا يفتح المستوى التالي إلا بقرار مخول.
- قرار الإعادة ينشئ دورة 72 ساعة جديدة ويحفظ القديمة.
- يمكن للمستخدم الرجوع لتدريب سابق دون فقد تقدمه.
- يُنشأ التقرير التشخيصي من السجل الموحد ويمكن تتبع مصادره.
- تعمل المهمة الأساسية حتى عند إخفاء المرشد أو إيقاف الصوت.
- تظهر نسخة المحتوى التي تدرب عليها المستفيد تاريخيًا حتى بعد نشر إصدار جديد.

20. خطة إصلاح النظام الحالي

- المرحلة 1: جرد الشاشات والوظائف الحالية وربط كل شاشة بمتطلب في هذه الوثيقة.
- المرحلة 2: تحديد ما يعمل، وما يعمل جزئيًا، وما هو مفقود، وما هو مخالف للمنطق العلاجي.
- المرحلة 3: إصلاح قاعدة البيانات ومحرك الحالات قبل تحسين الشكل.
- المرحلة 4: تنفيذ التشخيص الموحد والتقارير الآلي.
- المرحلة 5: تنفيذ بنية المستوى المعرفي والسلوكي.
- المرحلة 6: تنفيذ دورة 72 ساعة والعينة ومراجعة الأخصائي.
- المرحلة 7: نقل المحتوى من الكود إلى لوحة الإدارة.
- المرحلة 8: اختبار القبول السريري والتقني على سيناريوهات حقيقية.
- المرحلة 9: إطلاق تجريبي محدود ثم إصلاح النتائج قبل التوسع.

21. أمر التنفيذ المقترح لكلود

تعامل مع هذه الوثيقة باعتبارها المرجع الحاكم للنظام. ابدأ أولاً بتحليل النظام الحالي ومقارنته بنّداً بنّداً بالمتطلبات، ثم أنشئ مصفوفة فجوات توضح: موجود ويعمل، موجود ويحتاج إصلاحاً، مفقود، ومتعارض مع المنطق العلاجي لا تبدأ بإعادة بناء الواجهات قبل تثبيت نموذج البيانات ومحرك الحالات وقواعد الانتقال. حافظ على الكود والوظائف الصالحة، وأصلح ما يمكن إصلاحه بدل إعادة البناء غير الضرورية. لا تثبت المحتوى العلاجي داخل الكود؛ اجعله قابلاً للإدارة والإصدار من لوحة التحكم. لا تنفذ انتقالاً آلياً بين المستويات. بعد كل مرحلة قدم: ما تم، الملفات المعدلة، اختبارات القبول، والمشكلات المتبقية.

22. قرارات نهائية لا تحتاج سؤالاً إضافيًا

- جميع المرضى يبدأون من المستوى الأول.
- لا توجد تقنيات إضافية مطلوبة حاليًا خارج المعتمد.
- قائمة التدريب ثابتة لكل مرحلة عمرية.
- النموذج بشري حقيقي، ويشاهده المستفيد ثم يقلده.
- ليس لازمًا مشاهدة النموذج في كل مرة.
- نوع العينة يختلف حسب المرحلة ومدتها 3 دقائق.
- معايير مراجعة التقليد: التزامن، مدة التزامن، البطء والتحكم، رفع الصوت، وفتح الفم.
- عند عدم النجاح يعاد المستوى نفسه 72 ساعة بالنموذج والقائمة نفسيهما.
- الرجوع للخلف للتقوية فقط.
- التدرج إلى الكلام الطبيعي والتعميم والمتابعة أجزاء أصلية من البرنامج.
- توجد فروق بسيطة بين الأطفال والبالغين.

23. تدقيق الاكتمال والتغطية النهائية

هذا القسم يحول الوثيقة من وصف معماري عام إلى ملف تسليم واحد. تم دمج القرارات العلاجية الحديثة مع المتطلبات الأصلية التفصيلية، وأضيفت الملاحق المصدرة التنفيذية اللازمة حتى لا يحتاج فريق البرمجة إلى الرجوع إلى ملف خارجي لفهم رحلة التشخيص والعلاج.

• التسجيل والحسابات: مغطى — التسجيل، الدخول، استرجاع كلمة المرور، الملف الشخصي، الفئات العمرية والأدوار.

• التشخيص: مغطى — التاريخ المرضي، المقابلة، SSI-4، OASES، LoC، SSRS، الرضا الكلامي، العينات، السجل الموحد.

• التقرير الآلي: مغطى — تجميع النتائج، توليد المسودة، تتبع المصدر، مراجعة واعتماد الأخصائي.

• القياسات الزمنية: مغطى — قبل العلاج، بعد العلاج مباشرة، بعد شهر، بعد ثلاثة أشهر.

• الجلسة الأولى: مغطى — التهيئة، التاريخ، الاختبارات، شرح الخطة، الدافعية، التقنيات المحفزة، الاتفاق على الخطوة التالية.

• الجانب المعرفي: مغطى — فيديوهات، أسئلة، إجابات، موضوعات الجلسات، إدارة المحتوى.

• الجانب السلوكي: مغطى — النموذج البشري، المشاهدة ثم التقليد، التقنيات، القوائم، الجرعة.

• الجرعة: مغطى — 100 وحدة في كل مرة، 7 مرات يوميًا كهدف علاجي، فاصل ساعة، الحكم بالنتائج.

• دورة 72 ساعة: مغطى — فتح العينة بعد 72 ساعة، إعادة الدورة عند عدم النجاح.

• العينة: مغطى — 3 دقائق، النوع حسب المرحلة، التقييم الذاتي، توقع العينة القادمة.

• كميرداون: مغطى — مقياس 1-9، رأي المشارك، رأي المعالج، النتيجة، قرار الانتقال أو الإعادة.

• مراجعة الأخصائي: مغطى — التزامن، مدة التزامن، البطء والتحكم، رفع الصوت، فتح الفم.

• التدرج: مغطى — من الأصوات والمقاطع والكلمات إلى الجمل والحديث المسترسل والكلام الطبيعي.

• التعميم والمتابعة: مغطى — مواقف الحياة والقياسات اللاحقة والوقاية من الانتكاس.

• الرجوع للخلف: مغطى — تدريب حر للتقوية دون فقد التقدم.

• الاستشارات: مغطى — استشارة مجانية واحدة ثم مدفوعة.

• إدارة المحتوى: مغطى — المستويات والفيديوهات والأسئلة والقوائم والتعليمات والقوالب والإصدارات.

• الأدوار والصلاحيات: مغطى — المستفيد، ولي الأمر، الأخصائي، المشرف، الإدارة، الدعم، المالية.

• قواعد البيانات: مغطى — الكيانات الأساسية، الإصدارات، التدقيق، القرارات، العينات، الدورات.

• إصلاح النظام الحالي: مغطى — مصفوفة فجوات، الحفاظ على الصالح، إصلاح الأساس قبل الواجهة، اختبارات القبول.

24. الخريطة العلاجية الأصلية المدمجة

- الجلسة الأولى تعريفية وتشخيصية وتهيئية، ولا تُعامل كجلسة تدريب سلوكي عادية.
- المسار السلوكي الأصلي يتدرج من إطالة الأصوات، إلى الكلمات الحقيقية ذات مقطع ثم مقطعين ثم ثلاثة مقاطع، ثم كلمتين وثلاث كلمات، ثم الجمل المختارة، ثم الجمل الحرة، ثم الحديث المسترسل.
- تستخدم حركة اليد الخطية بالتزامن مع الكلام، ويُضبط الزمن المستهدف بحسب المرحلة.
- تُضاف إلى معايير الأداء المعتمدة حديثًا: فتح الفم بوضوح ورفع الصوت بوضوح أثناء التدريب.
- يُعرض النموذج البشري الحقيقي أولاً، ثم يكرر المستفيد بعده.
- كل مرحلة عمرية تستخدم قائمة ثابتة معتمدة، قابلة للإدارة بالإصدارات من لوحة التحكم.
- لا يحكم عدد التدريبات وحده الانتقال؛ العينة والنتيجة وقرار الأخصائي هي الحاكمة.

25. بطاقة تنفيذ موحدة لكل مستوى علاجي

- معرّف المستوى ورقمه واسمه.
- الفئة العمرية.
- الهدف العلاجي.
- المحتوى المعرفي الأول: الفيديو، النص، السؤال أو الأسئلة، الإجابات، التغذية الراجعة.
- المحتوى المعرفي الثاني: الفيديو، النص، السؤال أو الأسئلة، الإجابات، التغذية الراجعة.
- التقنية أو التقنيات السلوكية المستهدفة.
- النموذج البشري المرتبط.
- مدة النموذج.
- قائمة التدريب الثابتة للمرحلة العمرية.
- نوع الوحدة: صوت / مقطع / كلمة / عبارة / جملة / حديث.
- العدد الأدنى في كل مرة: 100 وحدة.
- الجرعة المستهدفة: 7 مرات يوميًا.
- الفاصل المستهدف: ساعة على الأقل.
- مدة الدورة: 72 ساعة.
- نوع عينة النهاية ومدتها: 3 دقائق.
- نموذج التقييم الذاتي.
- نموذج توقع العينة القادمة.
- معايير مراجعة الأخصائي.
- قرار الانتقال أو الإعادة.
- إصدار المحتوى الذي تدرب عليه المستفيد.

26. نموذج التقييم بعد العينة وقرار الأخصائي

- رأي المشارك: تقييم ذاتي للأداء باستخدام المقياس المعتمد في البرنامج.
- مقياس كمبرداون: من 1 إلى 9 درجات لقياس مستوى أداء المهمة.
- توقع العينة القادمة: يُحفظ كحقل مستقل وفق النموذج المعتمد.
- رأي المعالج: تقييم مستقل.
- النتيجة النهائية: تحفظ منفصلة عن رأي المشارك ورأي المعالج.
- القرار: انتقل إلى الجلسة التالية / أعد الجلسة الحالية.
- في النسخة الحديثة: إذا كان القرار إعادة، تبدأ دورة جديدة مدتها 72 ساعة بالنموذج والقائمة نفسيهما.
- لا تُحذف أي محاولة أو عينة أو قرار سابق.

27. القياسات التشخيصية وقياسات النتائج

- قبل العلاج: SSI-4, OASES, LoC, SSRS — التاريخ، النتيجة، ملاحظات الأخصائي.
- بعد العلاج مباشرة: SSI-4, OASES, LoC, SSRS — التاريخ، النتيجة، ملاحظات الأخصائي.
- بعد شهر: SSI-4, OASES, LoC, SSRS — التاريخ، النتيجة، ملاحظات الأخصائي.
- بعد ثلاثة أشهر: SSI-4, OASES, LoC, SSRS — التاريخ، النتيجة، ملاحظات الأخصائي.
- تُجمع النتائج تلقائيًا في شاشة ملخص واحدة، مع إمكانية المقارنة الزمنية وإدراجها في التقرير.
- يمكن إضافة مقياس الرضا الكلامي والمقاييس المعتمدة الأخرى دون تغيير بنية النظام.

الملحق أ: المتطلبات الأصلية التفصيلية المدمجة

النص التالي مدمج داخل ملف التسليم للحفاظ على التفاصيل الأصلية الخاصة بالاختبارات والجلسات والتعليمات والأمثلة وقواعد التقييم. عند وجود تعارض مع قرار علاجي حديث صريح في الأقسام السابقة، يسود القرار الحديث.

المصدر الأصلي — الصفحة المستخرجة 40

صفحة 49 of 154

Section IV: Quality of Life— القسم الرابع: جودة الحياة

إلى أي مدى تتأثر طريقة حياتك العامة سلباً؟

A. How much is your overall quality of life negatively

?...affected by

يؤثر التلعثم سلبيًا على طبيعة حياتي

...Stuttering negatively affects my quality of life

ليس على

الإطلاق

Not at all

قليل

A Little

بعض الشيء

Some

كثيراً

A Lot

تماماً

Completely

y

تلعثمك

1. Your stuttering

5 4 3 2 1

ردّة فعلك بالنسبة لتلعثمك

2. Your reactions to your stuttering

5 4 3 2 1

ردّة فعل الآخرين بالنسبة لتلعثمك

3. Other people's reactions to your stuttering

5 4 3 2 1

المصدر الأصلي — الصفحة المستخرجة 41

صفحة 50 of 154

لأي مدى يتداخل التلعثم مع رضاك التواصل بشكل عام؟

B. Overall, how much does stuttering interfere with your

?...satisfaction with communication

تداخل التلعثم مع الرضاء التواصل

Stuttering interferes with my communication satisfaction

ليس على

الإطلاق

Not at all

قليل

A Little

بعض الشيء

Some

كثيرا

A Lot

تماما

Completel

y

على وجه العموم

1. In general

5 4 3 2 1

في العمل

2. At work

5 4 3 2 1

في المواقف الاجتماعية

3. In social situations

5 4 3 2 1

في المنزل

4. At home

5 4 3 2 1

لأي مدى يتداخل التلعثم مع علاقاتك الاجتماعية بشكل عام؟

C. Overall, how much does stuttering interfere with

?...your

تداخل التلعثم مع علاقاتي الاجتماعية

...Stuttering interferes with my relationships

ليس على

الإطلاق

Not at all

قليل

A Little

بعض الشيء

Some

كثيرا

A Lot

تماما

Completely

y

العلاقات مع الأسرة

1. Relationships with family

5 4 3 2 1

العلاقات مع الأصدقاء

2. Relationships with friends

5 4 3 2 1

العلاقات مع الأشخاص الآخرين

3. Relationships with other people

5 4 3 2 1

العلاقات الحميمة

4. Intimate relationships

5 4 3 2 1

القدرة على العمل في المجتمع

5. Ability to function in society

5 4 3 2 1

لأي مدى يتداخل التلعثم مع مسيرتك العملية بشكل عام؟

D. Overall, how much does stuttering interfere with

?...your

تداخل التلعثم مع مسيرتي العملية

...Stuttering interferes with my career

ليس على

الإطلاق

Not at all

قليل

A Little

بعض الشيء

Some

كثيرا

A Lot

تماما

Completely

y

القدرة على القيام بعملك

Ability to do your job .1

5 4 3 2 1

الشعور بالرضا مع وظيفتك

Satisfaction with your job .2

5 4 3 2 1

القدرة على المضي قدمًا في حياتك المهنية

Ability to advance in your career .3

5 4 3 2 1

الفرص التعليمية

Educational opportunities .4

5 4 3 2 1

القدرة على الكسب بقدر ما تشعر أنه يجب عليك

Ability to earn as much as you feel you should .5

5 4 3 2 1

لأي مدى يتداخل التلعثم مع حياتك الشخصية بشكل

عام؟

D. Overall, how much does stuttering interfere

?...with your

تداخل التلعثم مع حياتي الشخصية

...Stuttering interferes with my personal life

ليس على

الإطلاق

Not at all

قليل

A Little

بعض الشيء

Some

كثيرا

A Lot

تماما

Completely

الشعور بقيمة الذات أو الثقة بالنفس

1. Sense of self-worth or self-esteem

5 4 3 2 1

النظرة الشاملة للحياة

2. Overall outlook on life

5 4 3 2 1

الثقة بنفسك

3. Confidence in yourself

5 4 3 2 1

الحماس للحياة

4. Enthusiasm for life

5 4 3 2 1

الصحة البدنية والجسدية بشكل عام

5. Overall health and physical well-being

5 4 3 2 1

القدرة على التحمل بشكل عام

Overall stamina or energy level .6

5 4 3 2 1

الشعور بالسيطرة على حياتك

Sense of control over your life .7

5 4 3 2 1

الرفاهية الروحية

Spiritual well-being .8

5 4 3 2 1

انتهى اختبار OASES

الاختبار الرابع: (اختبار الرضا الكلامي) ويسمى اختبار SSRS

تظهر الشاشات التالية للمستخدم

يقوم المطور بعرض الجدول أدناه بطريقة سهلة للمستخدم لأخذ القياس أدناه:

يقوم المشارك بملء مقياس الرضا العام على كلمه والذي يتكون من 11 نقطة، حيث أن نقطة رقم 0 تعني عدم الرضا

التام، ونقطة رقم 11 تعني الرضا التام

The participant judge their overall speech satisfaction on a 11- point self- rating scale, with 0 as the worst possible and 11 as the best possible judgment

اسم المشارك

Participant

المقياس

Scale

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

الرضا قبل

العلاج

Pre

الرضا بعد

العلاج

Post

الرضا بعد شهر

من العلاج

الرضا بعد 3

أشهر من

العلاج

انتهى اختبار SSRS

المصدر الأصلي — الصفحة المستخرجة 46

صفحة 55 of 154

النتيجة Result (تجمع النتائج تلقائيا لاطلاع الاخصائي عليها و يقوم بتعبئة الملاحظات على الاختبارات)

هذه النتيجة ملخص لكافة الاختبارات السابقة

اسم المعالج: اسم المشارك:

اختبارات قبل العلاج – Pre Assessment tests

ملاحظات النتيجة التاريخ الاختبار

SSI-4

OASES

LoC

SSRS

اسم المعالج اسم المشارك:

اختبارات بعد العلاج مباشرة – Immediate Post Assessment tests

ملاحظات النتيجة التاريخ الاختبار

SSI-4

OASES

LoC

SSRS

اسم المعالج اسم المشارك:

اختبارات بعد العلاج بشهر – 1 Month Post Assessment tests

ملاحظات النتيجة التاريخ الاختبار

SSI-4

OASES

LoC

SSRS

اسم المعالج اسم المشارك:

اختبارات بعد العلاج بثلاثة أشهر – 3 Months Post Assessment tests

ملاحظات النتيجة التاريخ الاختبار

SSI-4

OASES

LoC

SSRS

يتم بعد ذلك مقابلة المريض للاخصائي من خلال الفيديو لمدة عشر دقائق للتعرف على الحالة قبل صدور التقرير الطبي .

التقرير الطبي (هو قالب للتقارير التي تصدر من النظام بحيث يتم تعبئة الجزء الناقص باللون الأحمر أدناه من بيانات المريض بشكل آلي وعرضه على الاخصائي. وبراى حصول النظام على هذه البيانات من المستخدم خلال مرحلة التقييم والنتيجة التي يعدها الاخصائي وغيرها من المصادر، ونقصد بغيرها هنا في مرحلة التقييم والتسجيل للمستخدم. ويجب أن يُعتمد التقرير الاخصائي والمشرف قبل ارساله للمريض)

..... :Client name

...

اسم المريض

..... :ID No رقم الهوية

..... :Gender الجنس

..... :Nationality الجنسية

..... :Date of birth تاريخ الميلاد

..... :Occupation المهنة

..... :Place of work جهة العمل

..... :Date of enrolment تاريخ الدخول في البرنامج

..... :Discharge date تاريخ الخروج

Area of Concern

Ahmad is a twenty five year old male.He came to the SHS therapeutic approach for a fluency evaluation/treatment due to his concern over persistent stuttering. Specifically Ahmad was concerned that .the stuttering was becoming worse and frustration was increasing

Background Information

Ahmad was asked to answer a series of questions regarding stuttering which focused on experiences at home, school, and in previous therapy . Ahmad was born with no complications and health and .development appear typical.Stuttering was noticed at age four and was first identified through his mother .The stuttering fluctuated over time and has become much worserecently

Fluency testing

The Stuttering Severity Instrument-Fourth Edition (SSI -4) was administered to determine the frequency, duration, and severity of the stuttering as well as any physical concomitants (e.g., secondary characteristics such as facial tension, body movements, eye blink, etc.) which were present. Two samples of Ahmad's speech (reading and conversational speech) were analyzed and used to determine severity of stuttering. Samples are examined for the number and percentage of syllables stuttered (%SS) and a calculation is made of the average of the 3 longest stuttering events in the samples.

The Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering (OASES)

OASES was administered to determine the extent of impact ratings to which various aspects (General information, Reactions to stuttering, Communication in daily situations, and Quality of life) of the stuttering disorder affect the speaker's life. Impact scores range from 1 to 5 and can be used to determine impact ratings, which are labeled as follows: mild, mild-to-moderate, moderate, moderate-to-severe, and severe.

The speech satisfaction's rating scale (SSRS)

Ahmad was evaluated in relation to his overall speech satisfaction. This is achieved through the implementation of a self-rating scale, utilising 11 points, with 10 = the best judgement and 0 = the worst judgment. Accordingly, the score was made with consideration of various elements of stuttering such as negative emotional and cognitive reactions, reactions of listeners, and stuttering severity.

Summary

A total score of the SSI -4 is calculated based on the subscores. The total score for Ahmad during this evaluation was 43 indicating the presence of severe stuttering. The results are summarized on the following table.

Section of the SSI-4 Findings/observations Task Score

Frequency (%SS) Conversational

Speech Sample

XXXX %SS

XXX

Frequency (%SS) Reading Speech

Sample

XXXX %SS

Duration (average of 3 longest

(stuttering events

XXX seconds XXX

Physical concomitants XXX

Total Overall Score XXX

Percentile XXX-XXX

SSI-4 Severity Rating XXXXXXXXX

The score of SSRS for Ahmadduring this evaluation was 8indicating the presence of dissatisfaction of his .speech

OASES revealed that Ahmad's stuttering has a moderate to severe impact on his general information, and reaction to stuttering. His quality of life and communication in daily situations reaction to his stuttering were found to have a moderate impact on his communication. The table below shows the impact ratings .for Ahmad for the four sections of the OASES instrument, as well as the overall test

Scale Raw

score

Items

answered

Impact

score

Impact rating

General information 73 20 3.65 Moderate to severe

Reactions to stuttering 95 30 3.17 Moderate to severe

Communication in daily situations 73 25 2.92 Moderate

Quality of life 68 25 2.72 Moderate

Overall impact 309 100 3.09 Moderate to severe

Recommendations

Ahmad exhibits severe stuttering as evidenced by fluency testing results, observations, and the client information. It is strongly recommended that Ahmad attend their scheduled speech therapeutic sessions to improve his fluency, social, academic and communication skills

,Sincerely

Clinician name, B.S.c., SLP

Speech Pathologist

Approved By

Supervisor

المصدر الأصلي — الصفحة المستخرجة 51

صفحة 60 of 154

الجلسات العلاجية

تعليمات عامة للمستخدم قبل البدء بكل الجلسات
البند

مشاهدة الرسالة أدنى الجدول قبل كل جلسة ويمكن للمستخدم تخطيها

مشاهدة الفيديو المعرفي بتركيز

الإجابة على الأسئلة التابعة بالفيديو المعرفي

مشاهدة الفيديو السلوكي وبعد ذلك تقليد النموذج التدريبي فيه

الإستعانة بقائمة الأمثلة الخاصة بهذه الجلسة للتدرب عليها قبل حلول موعد الجلسة اللاحقة

وفقا للنموذج التدريبي (سيقوم المطور بإتاحة هذه الامكانية في التطبيق)

القيام بالتدريبات وفق جدول فئات الجلسات أدناه. (سيقوم المطور بإتاحة هذه الامكانية في

التطبيق والموقع بحيث يتأكد من قيامه بعمل التدريبات وفق المخطط له)

بعد مضى 72 ساعة علناالمشترك ارسال أفضل عينة تدريبية له عبر التطبيق والموقع من أجل

تقييمها(سيقوم المطور بإتاحة هذه الامكانية في التطبيق والموقع بحيث يتأكد من قيامه بعمل

التدريبات وفق المخطط له).

في ال 10 جلسات الأولى يرسل المستخدم العينة بعد72 ساعة (3 أيام). من الجلسة 11 إلى 14

ترسل العينة بعد4 أيام) ومن الجلسة 15 إلى 20 ترسل العينة بعد5 أيام) ومن الجلسة 21

إلى 25 ترسل العينة بعد6 أيام) ومن الجلسة 26 إلى 30 ترسل العينة بعد(7 أيام) وبعد ذلك

كل شهر أو أكثر أو أقل وفق ما يقرره مدير النظام ويكون ذلك لمدة 6 أشهر

سوف يقوم الاخصائي بتقييم العينة التي أرسلها المريض لتحديد مدى إتقانه للتدريب ومن ثم

ينقله الى المرحلة التي تليها أو ابقاءه في نفس المرحلة للتدرب أكثر. (سيقوم المطور بإتاحة هذه

الامكانية في التطبيق والموقع)

سيتم تزويد المطور بالفيديوهات المعرفية والفيديوهات السلوكية لعرضها على المستخدم مع ملاحظة أن

حجم الفيديوهات يقارب 5 كيلوبايت

الرسالة: (ويتم عرض الفيديو الخاص بالتعليمات قبل كل جلسة)

. إن برنامج طلبة الكلم الذي أنت بصدد تطبيقه يقوم على نقاط عديدة أهمها:

أ. التركيز على تعلم عادة جديدة للكلم الطلق بدلا من التركيز على حل المشكلة.

ب. اكتساب مهارة الكلم الطلق عبر سلسلة الخطوات الصغيرة تبدأ بالكلم ببطء بالتزامن مع حركة اليد وذلك بالانتقال من التدرب في البداية على المقاطع الصوتية إلى الكلمات ومن ثم الجمل وصولاً إلى الكلم الطبيعي.

ج. سيتم اكتساب العادات الجيدة للتخلص من العادات السيئة عبر المعرفة والتشجيع والمهارة.

د. تطوير الجانب المعرفي من خلل عرض مجموعة من الأفلم من أجل التخلص من الخوف والقلق.

هـ. من المهم أن تؤمن أثناء التدرب أن حدوث الفشل عدة مرات يعد أمراً طبيعياً. المطلوب منك حتى تنجح هو أن تكرر المحاولة تلو المحاولة حتى تنجح. عليك أن تسعد بالفشل.. لأننا نتعلم من الخطأ أكثر من الصواب. عليك أن تتدرب بحماس ومثابرة مع أهمية التركيز على النجاح في المهمة التي تتدرب عليها وتحتفل مع نفسك بهذا الإنجاز دون التفكير في المراحل التالية.

17. الالتزام والمسؤولية والجد والمثابرة؛ عوامل مهمة لنجاح أي برنامج علجي وتسهم بشكل فعال في حل مشكلتك بصورة مرضية.

يطلب من المستخدم الإجابة على هذه الأسئلة بعد اطلاعه على التعليمات أعلاه ويقوم المطور بعرضها كأسئلة متعددة الإجابات وضمها لقائمة النتائج المطلوبة للجلسات

البند م

قبل التدريب على الجانب السلوكي، يجب عليك عمل الاتي:

أ. النوم لمدة 7 ساعات

ب. الاطلاع على النموذج التدريبي وتقليد

ت. مكالمة أحد الأصدقاء

السؤال

الأول

كم عدد مرات التدريب اليومية؟

أ. مرتان

ب. أربع مرات

ت. ثمان مرات

السؤال

الثاني

كم مدة التدريب المطلوبة لكل محاولة؟

أ. ست دقائق

السؤال

الثالث

المصدر الأصلي — الصفحة المستخرجة 54

صفحة 63 of 154

ب. ثمان دقائق

ت. عشر دقائق

ماهي المدة اللازمة المطلوبة بين كل محاولة تدريبية وأخرى

أ. نصف ساعة

ب. ساعة

ت. ساعتين

السؤال

الرابع

ماهي المدة اللازمة للتدريب قبل إرسال العينة التدريبية؟

أ. يوم

ب. ثلاثة أيام

ت. خمسة أيام

السؤال

الخامس

ماهو مستوى جودة العينة التي سوف ترسلها للمختص؟

أ. أفضل عينة يمكنك القيام به

ب. عينة جيدة المستوى

ت. أي عينة قمت بتسجيلها

السؤال

السادس

شاشات الفيديو المعرفي:

شاشات الفيديو السلوكي:

يتم عرض التعليمات التالية للمستخدم قبل بدء الجلسات

تعليمات الجلسات التدريبية من الجلسة 2-15 فقط

1. قلد النموذج الموضح في الفيديو السلوكي

2. أنظر الى اليد أثناء أداء التدريب

3. انتبه للزمن المطلوب في كل جلسة

4. زامن بين حركة اليد والإطالة وأن تكون جميع الأصابع مضمومة إلى بعضها البعض

5. تدرب 8 محاولات، ولكل محاولة 8 دقائق(مثال: المحاولة الواحدة 40 مرة تدريب

6. مع ملاحظة أن بين كل محاولة وأخرى على الأقل ساعة من الزمن

7. قم بالتدريب لمدة ٣ أيام، ثم سجل أفضل محاولة لديك عبر التطبيق والموقع ثم أرسلها

8. ان توقفت عن التدريب لأي سببٍ! سيتطلب منك إعادة التدريب مرة أخرى

الجلسة الأولى: تحتاج توضيح لكيفية عرضها على التطبيق والموقع (هذه الجلسة سيتم تلخيصها من خلال عرض فيديو للمستخدم يقوم المطور بأعداده وسنقوم بتوفير النص الذي سيتم عرضه للمستخدم)

م البند

1 إقامة علاقة جيدة مع المشارك

2 التعريف بالأخصائي

3 أخذ التاريخ المرضي للمشارك

4 عمل الاختبارات المقننة

5 الحديث عن سير وخطة البرنامج- وماذا يجب عليك فعله

6 سؤال المشارك عن: ما حاجتك للعلاج؟ وهل أنت قادر على تحقيقه؟

7 عمل بعض التقنيات المحفزة (Metronome – Shadowing)

8 الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات

9 الاتفاق على موعد قادم لمناقشة النتائج والبدء في العلاج

سيقوم المطور بعرض هذه الصورة للمستخدم لمعرفة خطة سير البرنامج العلاجي وسيكون شرح هذه الخطة كالتالي

0

2

4

6

8

10

12

إطالة بصوت

أ

إطالة بصوت

ي

إطالة بصوت

و

إطالة كلمة

حقيقية ذات

مقطع

إطالة كلمة

حقيقة ذات

مقطعين

إطالة كلمة

حقيقة ذات 3

مقاطع

إطالة كلمتين

حقيقتين ذات

مقطع واحد

إطالة 3

كلمات حقيقية

إطالة جملة

مختارة

إطالة جملة

حسب

اختيارك

إطالة حديث

مسترسل

خطة سيربرنامج التزامن اللفظي مع حركة اليد

الزمن بالثانية Linear (استخدام حركة اليد)

المصدر الأصلي — الصفحة المستخرجة 57

صفحة 66 of 154

الجلسات اللاحقة مفصلة كالتالي

تنقسم الجلسات العلاجية إلى الفئات التالية:

جدول فئات الجلسات:

الفئة الجلسات التمرين فترة التمرين

للكلمة

التعليمات للمستخدم

1 4-2 إطالة

صوت

واحد

منتهي

بحرف علة

5 ثوان قبض اليد وفتحها مع الإطالة في الصوت منتهي بصوت

العلة - النظر إلى اليد أثناء تطبيق والموقع التدريب. الزمن

المطلوب للتدريب 5 ثواني - التدريب المطلوب (8 مرات

يومية/ وكل مرة 8 دقائق) على أن يكون الوقت بين كل محاولة

وأخرى ساعة من الزمن على الأقل. ويكون التمرين لمدة 3

أيام

2 6-5 إطالة

كلمة ذات

مقطع

واحد

5 ثوان قبض اليد وفتحها مع الإطالة في كلمة ذات مقطع واحد -

النظر إلى اليد أثناء تطبيق والموقع التدريب. الزمن المطلوب

للتدريب 5 ثواني - التدريب المطلوب (8 مرات يومية/ وكل مرة

8 دقائق) على أن يكون الوقت بين كل محمول وأخرى ساعة

من الزمن على الأقل. ويكون التمرين لمدة 3 أيام

3 8-7 إطالة

كلمة ذات

مقطعين

8 ثوان قبض اليد وفتحها مع الإطالة في كلمة ذات مقطعين - النظر

إلى اليد أثناء تطبيق والموقع التدريب. الزمن المطلوب للتدريب

8 ثواني- التدريب المطلوب (8 مرات يومية/ وكل مرة 8 دقائق

على أن يكون الوقت بين كل محاول وأخرى ساعة من الزمن
على الأقل. ويكون التمرين لمدة 3 أيام

4 9-10 إطالة

كلمة ذات

ثلاثة

مقاطع

9 ثوان قبض اليد وفتحها مع الإطالة في كلمة ذات 3 مقاطع - النظر

إلى اليد أثناء تطبيق والموقع التدريب. الزمن المطلوب للتدريب

9 ثواني- التدريب المطلوب (8 مرات يوميا/ وكل مرة 8 دقائق

على أن يكون الوقت بين كل محاولة وأخرى ساعة من الزمن

على الأقل. ويكون التمرين لمدة 3 أيام

5 11-12 إطالة

كلمتين

ذات

مقطع

واحد

4 ثوان قبض اليد وفتحها مع الإطالة في كلمتين ذات مقطع واحد -

النظر إلى اليد أثناء تطبيق والموقع التدريب. الزمن المطلوب

للتدريب 4 ثواني- التدريب المطلوب (8 مرات يوميا/ وكل مرة

8 دقائق) على أن يكون الوقت بين كل محاولة وأخرى ساعة

من الزمن على الأقل. ويكون التمرين لمدة 4 أيام

6 13-14 إطالة

كلمتين

6 ثوان قبض اليد وفتحها مع الإطالة في كلمتين - النظر إلى اليد

أثناء تطبيق والموقع التدريب. الزمن المطلوب للتدريب 6 ثواني

- التدريب المطلوب (8 مرات يوميا/ وكل مرة 8 دقائق) على أن

يكون الوقت بين كل محاولة وأخرى ساعة من الزمن على

الأقل. ويكون التمرين لمدة 4 أيام

7 15-16 إطالة ثلث

كلمات

6 ثوان قبض اليد وفتحها مع الإطالة في 3 كلمات (صغيرة - النظر

إلى اليد أثناء تطبيق والموقع التدريب. الزمن المطلوب للتدريب

6 ثواني- التدريب المطلوب (8 مرات يوميا/ وكل مرة 8 دقائق

على أن يكون الوقت بين كل محاولة وأخرى ساعة من الزمن

على الأقل. ويكون التمرين لمدة 5 أيام

8 17-18 إطالة

جملة

5 ثوان قبض اليد وفتحها مع الإطالة في جملة - النظر إلى اليد أثناء

تطبيق والموقع التدريب. الزمن المطلوب للتدريب 5 ثواني-

التدريب المطلوب (8 مرات يوميا/ وكل مرة 8 دقائق) على أن

يكون الوقت بين كل محاولة وأخرى ساعة من الزمن على

الأقل. ويكون التمرين لمدة 5 أيام

9 19-20 إطالة ثلث

كلمات

صغيرة

بدون

حركة اليد

4 ثوان إيقاف حركة اليد وركز على الإطالة فقط -لا يتوجب عليك

النظر إلى اليد أثناء تطبيق والموقع التدريب. الزمن المطلوب

للتدريب 4 ثواني- التدريب المطلوب (8 مرات يوميا/ وكل مرة

8 دقائق) على أن يكون الوقت بين كل محاولة وأخرى ساعة

من الزمن على الأقل. ويكون التمرين لمدة 5 أيام

10 21-24 إطالة

جملة

3 ثوان إيقاف حركة اليد وركز على الإطالة فقط -لا يتوجب عليك

النظر إلى اليد أثناء تطبيق والموقع التدريب

بدون

حركة اليد

الزمن المطلوب للتدريب 3 ثواني- التدريب المطلوب (8 مرات يوميا/ وكل مرة 8 دقائق) على أن يكون الوقت بين كل محاولة وأخرى ساعة من الزمن على الأقل. ويكون التمرين لمدة 6 أيام

11 25-30 حديث

على شكل

جمل

2-3 ثوان إيقاف حركة اليد وركز على الإطالة فقط -لا يتوجب عليك

النظر إلى اليد أثناء تطبيق والموقع التدريب. الزمن المطلوب

للتدريب 2-3 ثواني- التدريب المطلوب (8 مرات يوميا/ وكل

مرة 8 دقائق) على أن يكون الوقت بين كل محاولة وأخرى

ساعة من الزمن على الأقل. ويكون التمرين لمدة 7 أيام

12 كل شهر يقوم المستخدم برفع فيديو لتسجيل له مرة شهريا ولمدة ستة أشهر لتقييم الجلسات

وغلاقها

دورة النشاطات في الجلسة:

- عرض التعليمات الخاصة بكل جلسة

- عرض الفيديو الخاص بالتعليمات

- عرض الأسئلة الخاصة بالتعليمات

- إجابة المريض على الأسئلة الخاصة بالتعليمات

- بعد ذلك يتم بدء عرض فيديو معرفي بحجم لا يزيد عن 5 كيلوبايت للمستخدم وسيتم توفير

الفيديو للمطور .

- عرض الأسئلة المعرفية ذات الأجوبة الاختيارية للإجابة عليها من قبل المستخدم (المرفق رقم 1)

للجلسات العلجية). وستكون الإجابة موضحة للمطور باللون الأزرق حتى يتم تقييم المستخدم.

- عرض الفيديو السلوكي بحجم لا يزيد عن 13 كيلوبايت للمستخدم وسيتم توفير الفيديو للمطور .

وعرض الفيديو للمستخدم لتعريفه بالتعليمات للتدريب على الأمثلة المستخدمة

- يتم عرض كافة الأمثلة في (المرفق رقم 2 للجلسات العلجية) بشكل عشوائي للمستخدم بحيث يقوم

بنطق الأمثلة وفق الفئات الموضحة في جدول فئات الجلسات ثم يقوم المستخدم بتعبئة الجزء

المظلل باللون الأصفر لتقييم تدريبه خلال الأيام المحددة في جدول فئات الجلسات من خلال تكرار

التمرين على الأقل 8 مرات في اليوم ويقوم بعدد لا يقل عن 45 محاولة في المرة الواحدة. كما يقوم

بالتمرين بعدد الأيام الموضحة في جدول فئات الجلسات. ويقوم بتوثيق نتائج التمرين فيمثال الجدول أدناه:

التاريخ المحاولة المهمة المطلوبة الزمن

المطلوب

الزمن

الفعلي

5

النظر

الى اليد

5

التزامن

5

ملحظات

1

اطالة صوت واحد

منتهي بصوت العلة أ

مع التزامن مع حركة

اليد

5 ث

2 5 ث

3 5 ث

.... 5 ث

... 5 ث

39 5 ث

40 5 ث

- بعد إنتهاء التدريب يقوم المريض بتقييمنفسه من خلل التقييم أدناه لبرنامج كمبرداون. ويطلب التطبيق والموقع قيام المستخدم تقييم نفسه مرة أخرى بتوقع ماهو التقييم الذي سوف يحققه في الجلسة القادمة:

o مقياس شدة التلعثم والمفصل كالتالي

▪ 0 تعني لا تلعثم

▪ 1 بسيط جدا

▪ 2-3 بسيط

▪ 4-5 متوسط

▪ 6-7 شديد

▪ 8 شديد جدا

o مقياس برنامج كمبرداون والمقسم إلى 9 درجات 1-9 درجات) لمعرفة مستوى أداء المستخدم للمهمة حيث يقيم المستخدم نفسه حول قدرته على أداء التمارين بنجاح. ويتم هذا التقييم فقط مرة واحدة في نهاية كل تدريب.

- تنبيه: في كل جلسة يتم تذكير المستخدم بأن الانتقال من الجلسة الحالية إلى الجلسة التالية يتم عن طريق الاختصاصي بعد تقييمه النهائي لنتائج الجلسة والفيديو المرسل من قبله.

- بعد ذلك يقوم المستخدم بإرسال عينة الفيديو: بعد مضي فترة التدريب المحددة يقوم المستخدم بإرسال أفضل عينة تدريبية له عبر التطبيق والموقع لفترة لا تزيد عن دقيقتين من أجل تقييمها من قبل الاختصاصي لتحديد مدى إتقان المستخدم للتدريب ومن ثم يتم إناء نقله إلى المرحلة التي تليها أو إبقاءه في نفس المرحلة للتدريب أكثر

-

النتيجة – Result

النتيجة النهائية – Final result رأي المشارك – Client opinion رأي المعالج – SLP opinion

10 / 10 / 10 /

انتقل الى الجلسة التالية أعد الجلسة الحالية

المصدر الأصلي — الصفحة المستخرجة 62

صفحة 71 of 154

مرفقات الجلسات العلاجية :

- الاسئلة التابعة للفيديوهات المعرفية

- الأمثلة التابعة للفيديوهات السلوكية

- التعليمات التي توضح للمستخدم لأخذ عينة الفيديو الذي سيقوم بتسجيله

الاسئلة التابعة للفيديوهات المعرفية

الجدول أدناه توضح الجانب المعرفي ورقم الفيديو المعرفي لدينا (مثال 2A) والاختبار التابع للجانب المعرفي بحيث يمكن لمدير التطبيق والموقع اختيار العدد الذي يريده من هذه الجوانب حسب ما يراه.

الجانب المعرفي مرجع الفيديو الأسئلة والأجوبة

مراحل تطور المشكلة 2A س: برنامج التزامن اللفظي مع حركة اليد يساعدك على تطبيق

والموقع مبدأ

أ. التفكير التقليدي

ب. التفكير السلبي

ت. التفكير الإيجابي

اكتساب عادة جديدة 1 2B س: تبدأ مشكلة التلعثم في سن

أ. 2-3

ب. 3-4

ت. 2-5

ث. 6-7

التحدث ببطء وروية 3A س: يتم اكتساب عادة الكلام الجديدة عبر

أ. الرغبة الصادقة

ب. المعرفة السليمة

ت. التدريب الجاد

ث. جميع ما سبق

اكتساب عادة جديدة 2 3B س: الحديث ببطء يتطلب منك

أ. التركيز

ب. التوتر

ج. التعثر

التحفيز 1 4A س: عدم النجاح في التدريب يعود إلى

أ. قلة التدريب

ب. عدم فهمه جيدا

ج. تطبيقه بصورة خاطئة

د. جميع ما سبق

الفشل والنجاح 23B س: عندما تكون وحدك وتتكلم مع نفسك أو تغني أو ترتل القرآن فإن

كلامك يصبح

أ. أكثر طلاقة

المصدر الأصلي — الصفحة المستخرجة 64

صفحة 73 of 154

ب. أقل طلاقة

ت لا يتغير

التركيز على المهمة 5A

س: نجاحك أو فشلك في سائر أمور الحياة يعتمد

أ. على الآخرين

ب. عليك

المسؤولية 5B 1 س: النجاح يكمن في

أ. التركيز على الخطوة التي تتدرب عليها في البرنامج العلاجي

ب. التركيز على النتيجة النهائية

الخوف 6A 1

سمفهوم تقبل الذات يسعى الى التقدم الحقيقي والتطور في

حالتك؟

أ. نعم

ب لا

التقبل 6B 1 س- الخوف حالة ذهنية قابلة للتغيير.. إذا أقنعنا أنفسنا بذلك؟

أ. نعم

ب لا

الخوف 7A 2

تقبل مشكلة التعلم يعد الركيزة الاولى من اجل الانتقال الى

التحسن والتطور؟

أ. نعم

ب لا

التقبل 7B 2 س: ماأهم عمل يجب عليك فعله الان؟

أ. تتحرر من الخوف الذي بداخلك

ب. مراقبة نفسك

ت لا تتواصل مع الآخرين

الاعتراف بأنك تتلعثم 8A

س: إن توجيه مشاعر اللوم والعتاب للآخرين

أ. مفيد

ب. غير مفيد

ت. يزيد من مشكلتك ومعاناتك

ث. يسهل مشكلتك ومعاناتك

ج. اجابة (ب و ت)

المسؤولية 2 8B س: الاعتراف بمشكلة التلعثم لديك يعد مطلباً مهماً في

أ. الوصول الى الطلاقة في الكلام

ب. النجاح في التواصل

المصدر الأصلي — الصفحة المستخرجة 65

صفحة 74 of 154

ت. التقليل من التوتر والجل والارتباك لديك

ث. جميع ماسبق

المبادرة 9A

س: التدرج بالحديث يعني

أ. التحدث مع أي شخص

ب. التحدث مع الأشخاص السهلين ثم الصعبين

ت. التحدث مع الأشخاص الصعبين ثم السهلين

التدرج بالحديث مع الآخرين 9B س: أن تغيير طريقتك في التفكير تساعدك على الحصول على مشاعر

أفضل

أ. نعم

ب لا

لا أعلم

الخوف 3 10A

س: أهمية علاج التلعثم تنعكس على

أ. زيادة الثقة بالنفس

ب. يعكس صورة ايجابية عنك

ت. يسهل عليك التعامل مع الناس والاختلاط بهم

ث. له تأثير ايجابي على حياتك المهنية

ج. جميع ماسبق

التحفيز 2 10B س: تعود كثير من المخاوف التي تواجهك تجاه التلعثم إلى

أ. تجنب مواقف الكلام

ب. تفادي الزيارات الاجتماعية

ت. تجنب الحديث عبر الهاتف

ث. جميع ماسبق

التحفيز 3 11A

س: عند الكشف عن ذاتك يجب عليك

أ. أن تتوقف عن التظاهر أنك متحدث طبيعي

ب. ألا تخفي حقيقة أن لديك مشكلة حقيقية في الكلام

ث. تقبل تلغثمك على أنه مشكلة وسوف تسعى جاهدا لحلها

ج. جميع ماسبق

الكشف عن الذات 11B س: هل تعتقد ان مشكلة التلعثم قابلة للعلاج؟

أ. نعم

ب لا

المسؤولية 2 12A س: نجاح تطبيق والموقع البرنامج العلاجي يعتمد على

المصدر الأصلي — الصفحة المستخرجة 66

صفحة 75 of 154

أ. الجهد

ب. المثابرة

ت. الوقت الذي تمضيه في التدريب

التركيز على المهمة 12B س: من المسؤول عن شعورك وأحاسيسك

أ. أنا

ب. الآخرون

ت. أنا والآخرون

ث لا أعلم

التقبل 13A 1

س: على قدر اعترافك بالمشكلة، يكون إنجازك أكبر

أ. نعم

ب لا

ت لا أعلم

الاعتراف بأنك تتلعثم 13B 2 س: تقبلك لذاتك يقودك إلى الوصول إلى السلام الداخلي مع النفس

والشعور بالسعادة

أ. نعم

ب لا

ت لا أعلم

التقبل 14A 2

س: هل هي مسؤولية الآخرين أن تشعر بأنك أفضل؟

أ. نعم

ب لا

ت لا أعلم

المبادرة 14B س: عندما تتقبل ذاتك فأنت قد بدأت في تطوير وتحسين نفسك

أ. نعم

ب لا

ت لا أعلم

الخوف 15A 1

س: المحافظة على التواصل البصري تزيد من مقاومة مشاعر

الخوف والعجز؟

أ. نعم

ب لا

ت لا أعلم

المحافظة على التواصل

البصري

15B سهل كل ما أنجزته إلى هذه اللحظة هو نتاج اختياراتك ووعيك

أ. نعم

ب. لا

ت. لا أعلم

الخوف 2 16A

س: أنت لا تستطيع تغيير الآخرين ولكن تستطيع تغيير نفسك

أ. نعم

ب. لا

التدرج بالحديث 16B س: أنت لا تعيش أحلامك بسبب الخوف؟

أ. نعم

ب. لا

ت. لست متأكد

الخوف 3 17A س: التلثم ليس مرضاً أو عيباً أو قصوراً أو نقصاً أو حتى شيئاً

مخجلاً؟

أ. نعم

ب. لا

ت. لست متأكد

التحفيز 1 17B س: تفادي الزيارات الاجتماعية دلالة كبيرة على الخوف؟

أ. نعم

ب. لا

ت. لست متأكد

المسؤولية 2 18A

س: التركيز على التدريب الحالي في البرنامج العلاجي أدعى لانجاز

العملية بنجاح من دون تشتيت الانتباه

أ. نعم

ب. لا

التركيز على المهمة 18B س: مسؤوليتك بأن تشعر أنك أفضل وليس الآخرون

أ. نعم

ب. لا

الفشل والنجاح 19A

س: التواصل الناجح مع الآخرين يعتمد على المحافظة على التواصل

البصري؟

أ. نعم

ب لا

المحافظة على التواصل

البصري

19B س: هل علاج التلعثم سهل؟

أ. نعم

ب. لا

التدرج

بالحديث

20A س: التواصل الناجح مع الآخرين يعتمد على المحافظة على التواصل

البصري؟

أ. نعم

ب. لا

التحفيز 2 20B س: هل علاج التلعثم سهل؟

أ. نعم

ب. لا

المحافظة على

التواصل البصري

21A س: إجابتك تعتمد اختيارك

أ. صحيح

ب. غير صحيح

المبادرة 21B س: قبل أن تبدأ بالكلام لابد أن تتواصل بصريا مع الآخرين

أ. صحيح

ب. غير صحيح

مراقبة طريقة كلمك 22A س: تزداد المسؤولية كلما تقدم سير البرنامج العلاجي

أ. صحيح

ب. غير صحيح

التركيز على المهمة 22B س: مراقبة طريقة كلامك تساعدك على العمل على تغيير ما تقع فيه

من أخطاء

أ. صحيح

ب. غير صحيح

المثابرة 24A س: هل مشكلة التلعثم قابل للعودة بعد العلاج

أ. نعم

ب. لا

ت لا أعلم

المحافظة على النتائج 24B س: هل التلعثم إعاقة عنيدة ولا تستسلم بسهولة؟

أ. نعم

ب لا

ت لا أعلم

الأمثلة التابعة للفيديوهات السلوكية

الجلسة الأولى تعريفية وليس لها أمثلة. والأمثلة التالية يمكن لمدير التطبيق والموقع اختبار الأمثلة التي يراها لعدد الجلسات التي يراها .

أمثلة الجلسة الثانية (الفيديو التوضيحي SENSE1)

۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱

سا ز را ذ دا خ

ع ا ظ ط ض ص ش

ما لى لى كا قا فا غا

يا وها ن

أمثلة الجلسة الثالثة (الفيديو التوضيحي SENSE2)

حورورور جورورور ثورورور تورورور بورورور أاورورور

ســـــو زـــــو رـــــو ذـــــو دـــــو خـــــو

عوووووو ظووووووو طووووووو صووووووو صووووووو شوووووو

موووووووو لوووووووو كوووووووو قووووووو فووووووو غووووووو

..يوووووو وووووووو هوووووووو نوووووووو

أمثلة الجلسة الرابعة (الفيديو التوضيحي SENSE3)

حییییی جییییی ثییییی تییییی یییییی ایییییی

لښتېنږي زېږېدېښتي ريښتېني ذېښتېني دېښتېني خپښتېني

عيسیسی ظیسیسی طیسیسی ضیسیسی صیسیسی شیسیسسی

میتھیمیسی لیبیریسی کیبیسیبی قیبیسیبی فیبیسیبی غیبیسیبی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أمثلة الجلسة الخامسة والسادسة (الفيديو التوضيحي 4-5 SENSE)

ثور جبل ثمن لب مرت بيت بر ستر ثار يخت
حبك كبت ثمر وبر كشت بيض بحر بتر ثلج بخت
سبأ لبن تق جين عنت بكر بط رتب ثيت تحت
حبر قبه ثرى ذبح حت بدر بعد نتج ثغر كنت
صبر حبك ثني ضيع عجت بذر برد كتم ثدي فت
طبل سبأ ثوب شيع نعت بين بصل كي ثوم جت
قبل حبر ثم شبل مات بطن بطل فتل ثلث سرت
خبر متى حبل نيت اخت بفك برق فتح شبر نمت
بات ستة غبي فات صات برج بلح فتن نبط شرت
جثة وثب أنت بوت بقر بوح بلد لثة نثر جية
حمص حلم خرج لجا جن جرح جمر جال يث بحث
حمر حمد فرج وجد حبس جرع جعل جهر رث حت
حيث حرف مرج مجر جيم جرد جهاز جبر قث ورث
حذر حرج حرج هجم جيب جزع جرف جل بعث غث
حبك حجر درج حرث جير جاء جعد جمل ليث عبث
حلب حوض سرح حرق جح جذب جمد جفر حيث غيث
روح بحر راح مدح خيز بخس كحل فحل حار حاد
طاح رحب رجع بلح خبر سخط تحل رحل حسم حش
فاح نحل مسح رح خزف نسل بحر محب حك حام
صرح بحت لمع قرح خص موت رحب بحت حاء حمى

أمثلة الجلسة السابعة والثامنة (الفيديو التوضيحي 6-7SENSE)

رماد داول دانة ينفخ نخلة ديكور صندل صداع عميد رماد
عماد دحرج دجاج بخاخ أخضر دقيق رادار صنفذ عقيد عماد
أحفاد دغدغ دباب مسلخ مخدة دليل هادر سجدة فندق أحفاد
أعداد دائخ دابة اصمخ رخاء دماء صاذف مدحت حدود أعداد
عباد دائم دالية شامخ نفخة دلفين صادق مخدة صندوق عباد
جراد داجن دعسة فراخ مخبأ دقيقة جردل جرادة صوديوم جراد
جماد داكن دهشة صالح مخزن دودة جدال دحج هدهد حميد
بلد دامع دارج بطيخ شخير دوام جدار جديد أدوار معيد
وداد دمار دارس صريخ رخيص دوسة باردة هدير بدور قصيد
مصعد درويش دافع أسياخ مخيم دولت زبدة صديق راديو مفيد
جواد درقية دعوة يبدخ بخير دولة وجدان مدير فيديو جامد
سعاد ديلة دلال بائد يخبز دبوس بدرة رديء جندول وائد
خالد دينا دمار سائد مخيف دكتور وردة جندي بدون زائد
راشد دينار دهان واعد بخور دونات خردة مدريد مردود شديد
مارد دماغ يصيد قائد تخون دمية سعداء وادي سدود ماجد
بارد فارد ويرد عائد مخول دوحة سعدان حديقة هديل وارد
فريد والد شريد حاسد مدريد دوخة شهادة أدريس حديد واحد
يشيد وليد عابد يعيد بعيد دبور عايد معيد قصيد حميد
خالد مويه نايم فايد بيتي نوره شنطة شباك سلسال مرايه
طريق تالي وحده عيادة نفس ي صاخب إحساس نظارة قلمين فلفل

أمثلة الجلسة التاسعة والعاشره (الفديو التوضيحي8-9SENSE)

تنسيقنا انكسار مسطرتين اسراراً مدرسة ذمامون ذهبنا سماعاتهم السداد
استفسار وسيلتهم مرسيدس مسايح اساسياتها ذباحين ذبذبات سماكتكن اسلفنا
تلفزيون بسكوتة شمسيات استقامة غسالات مستغفر اهتزاز سلطاتكم نستعين
الاناناس شركسية باكستان احاسيسكم مكنسات ممتازة الاعتزاز سراديب اساسياتها
الشركس مسطرة المأذنة ذبايحهم مستكبر استفزاز المراكز ستشعرون غسالات
السديس ضرورة المذبحة ذاهيون مستقر الفائز القزاز ستنكران مكنسات
مرسيدس اطروحة الأغذية ذبايتين مستذكر المتميز زرافات سيارات اسراراً
النسناس طريقة الإذاعة ذريتين متسور ربانية زنجيل سبيكات مسطرتين
الابليس عشرون المعذرة ذاكرون مستنصر رحمانية زخرفان سلسلكم مرسيدس
التنفس عشيرة الإعتذار ذوبانهم مستنذر روحانية زمزية سكرابكم شمسيات
اتوبيس فراولة الإحتذاء ذبولهم مستصغر زلازل زيادات سينكرون باكستان
الفانوس حورية الرذيلة ذخيرتهم مستظهر زعفران زراعات سيعودان مسايح
الجاسوس مكرونة الأحذية ذهولهم مستنصر زميرات نزلحهم سبوارتهن استقامة
القاموس تقديرة المحاذير ذواقون مستنشر زيارات طارازان سعوديون احاسيسكم
الجاموس استخرجت مذكورين ذميمون يستخير زبديات أزهاركم أرزاقكم السداد
شرقيتان استبرقت معوذات ذائبون يستشير زنوبات خيزارانة غزلان اسلفنا
باسلوب شراشف دشداشة ذهبنا يستجير شوكلات موزارت مجازفات نستعين
المتسويات شغالاتنا شواياتنا ذبذبات المسؤولين زرزور ملزومة فوايزر شاحناتنا
شمعدانات شمعاتهم عشماوي ذمامون المنسوبون مجزومة الأسئلة وسادات مشكلتهم
شمسيات شرنقتين رشاشات مسكينة المدرسين الرموش مدروسات صالحين انتعاش
القروض لوعاتي صيادون منسوبون الصالحون القروش دينصورات صادقين الوحوش

أمثلة الجلسة الحادية عشر والثانية عشر (الفيديو التوضيحي 10-11 SENSE)

دلع بنت زرع حصد رقة نفس نور ربك بطن بط طلب رزق حضر حمد
جوع شعب من لعب بطل حرب عبد الله سطل ما قصة طفل نام علي
صوغ ذهب قد تم قرا جمل شكل بط شطب اسم متى طاف شرب ماء
صبر رجل أهم درس أمل حياة علة حرف نط حبل طقم ذهب اكل رز
غض بصر هو وهي طفر يد عظم لحم خط حلو طين بني كل ش ي
دقة عود جد جدي ظن سو بحفظ الله لفظ حسن حظ وع ليش لا
بتر قدم شدة عطش ظما طفل عم اخي عاش يوم كتب الذكر أنا قوي
قطع يد اذا مات جد هزل عن وعد عمل جيد حفظ جيد مال شوي
فص ثوم عيش حار جرس قوي نعم نعم عدد جيد بعد نظر نبض قلب
فصل اول دس السم درس صعب جد وجد فخذ فيل شسع نعل لون حلو

أمثلة الجلسة الثالثة عشر والرابعة عشر (الفيديو التوضيحي 12-13 SENSE)

أنا أحب الفوز شخص حقق النجاح توقف بعض الوقت إمنح الفضل لنفسك ليس هناك تحدي
لا بد أغير حياتي السُّقُن ليست آمنة لكن لا تستسلم اغتنم الفرصة دائما حسن وطور ذاتك
الانتصار على الهزيمة افعل شيئا جديدا التدريب أفضل

المعلمين

كن أحد الناجحين مستحيل أن أفشل

من عجائب الحياة إفعل الش يء

الصحيح

أريد أصبح عظيما من أجل التميز تخيل صورة ما

دون مستوى القمة في الوقت الصحيح التميز عنصر نادر الرغبة في المساعدة اجعل النجاح واقع
سفينة بدون دفة توقع العمل الجيد ليس هو المهم أنا أساعد الآخرين يمكنك تحقيق

حلمك

على قيد الحياة كيف وليس الكَم المهم هو ما تبذله المحترم شخص فذ أنا انسان عظيم
إن السعادة مُتعة إتقان العمل أفضل جهد في التدريب إننا نصنع مصائرنا صفة الإنجاز النجاح
أين هو الطريق بُعد المسافة مهم لا تخش ى من التنازل إننا نصبح ما نفعله اختر مهنة تُحبها
سوف تصل للهدف تعلم قواعد اللعبة العثور على التميز افعل شيئا آخر مع العسر يسرا

الخوف أقدم

الأمراض

سوف تنتهي المشكلة رؤيتك انعكاس

لفكرك

كن حرا دوما إن الصفا والمروة

الخوف يدمر

الانسان

التحفيز مطلب

ضروري

إفعل الش يء

الصحيح

تحرر من القلق الحكمة ضالة

المؤمن

الخوف يقتل الاحلم أساعد نفس ي بنفس ي اجعل البعض مُمتنا لا تكن متوترا أتقبل النصح

الصادق

الخوف يفقد الأمل أحافظ على الوقت الصلة كتابا موقوتا اتصل مع الله لا أسعى للكمال

الخوف يزيد

المصاعب

العلم دائما بالتعلم العالم يفسح الطريق افعل كل شيء هكذا تستمر الحياة

الخوف يعيق التقدم سوف تنجلي الغمة أعرف أين تذهب لا تعيش في خوف استفيد من

النصيحة

أتحدث مع الآخرين الإنجاز يحتاج تعاون كون هدفك بسرعة استمر في الحياة أي شيء ضروري

لن يحصل أبدا أحدد الخطط

المستقبلية

كفى مرارة الحياة أجب عن الاتي أكثر من المثابرة

الخوف وهم عظيم أنا فعال ومؤثر السعادة في العطاء أحب غروب الشمس كل شيء طبيعي

الخوف حالة ذهنية رب السموات السبع ربي اغفر لي أبي رجل عظيم كم الساعة الان

أمثلة الجلسة الخامسة عشر والسادسة عشر (الفيديو التوضيحي 14-15 SENSE)

حان وقت الحديث على شكل جمل طويلة بـمد مطول في مدة أقصاها 5 ثوان

الانتصار على الهزيمة افعل شيئاً جديداً التدريب أفضل

المعلمين

كن أحد الناجحين مستحيل أن أفشل

من عجائب الحياة إفعل الشئ

الصحيح

أريد أصبح عظيماً من أجل التميز تخيل صورة ما

حلمك

الخوف أقدم

الأمراض

سوف تنتهي المشكلة رؤيتك انعكاس

لفكرك

كن حراً دوماً إن الصفا والمروءة

الخوف يدمر

الإنسان

التحفيز مطلب

ضروري

إفعل الشئ

الصحيح

تحرر من القلق الحكمة ضالة

المؤمن

الصادق

الخوف يزيد

المصاعب

النصيحة

لن يحصل أبداً أحدد الخطط

المستقبلية

كفى مرارة الحياة أجب عن الآتي أكثر من المثابرة

أمثلة الجلسة السابعة عشر و الثامنة عشر (الفيديو التوضيحي 16-17 SENSE)
حان وقت الحديث على شكل جمل طويلة بمــــد مطول في مدة أقصاها 4 ثوان
الانتصار على الهزيمة افعل شيئا جديدا التدريب أفضل
المعلمين
كن أحد الناجحين مستحيل أن أفشل
من عجائب الحياة إفعل الش يء
الصحيح
أريد أصبح عظيما من أجل التميز تخيل صورة ما
حلمك
الخوف أقدم
الأمراض
سوف تنتهي المشكلة رؤيتك انعكاس
لفكرك
كن حرا دوما إن الصفا والمروة
الخوف يدمر
الانسان
التحفيز مطلب
ضروري
إفعل الش يء
الصحيح
تحرر من القلق الحكمة ضالة
المؤمن
الصادق
الخوف يزيد
المصاعب
النصيحة
لن يحصل أبدا أحدد الخطط
المستقبلية
كفى مرارة الحياة أجب عن الاتي أكثر من المثابرة

أمثلة الجلسة التاسعة عشر والعشرون (الفيديو التوضيحي 18-19 SENSE)

الانتصار على الهزيمة افعل شيئاً جديداً التدريب أفضل

المعلمين

كن أحد الناجحين مستحيل أن أفشل

من عجائب الحياة إفعل الشيء

الصحيح

أريد أصبح عظيماً من أجل التميز تخيل صورة ما

حلمك

الخوف أقدم

الأمراض

سوف تنتهي المشكلة رؤيتك انعكاس

لفكرك

كن حراً دوماً إن الصفا والمروءة

الخوف يدمر

الإنسان

التحفيز مطلب

ضروري

إفعل الشيء

الصحيح

تحرر من القلق الحكمة ضالة

المؤمن

الصادق

الخوف يزيد

المصاعب

النصيحة

لن يحصل أبداً أحدد الخطط

المستقبلية

كفى مرارة الحياة أجب عن الآتي أكثر من المثابرة

المصدر الأصلي — الصفحة المستخرجة 78

صفحة 87 of 154

أمثلة الجلسة الواحد والعشرون حتى الرابعة والعشرون (الفيديو التوضيحي SENSE20)

حان وقت الحديث على شكل جمل طويلة بمسـد مطول في مدة أقصاها 3 ثوان

الانتصار على الهزيمة افعل شيئاً جديداً التدريب أفضل

المعلمين

كن أحد الناجحين مستحيل أن أفشل

من عجائب الحياة إفعل الشـيء

الصحيح

أريد أصبح عظيماً من أجل التميز تخيل صورة ما

حلمك

الخوف أقدم

الأمراض

سوف تنتهي المشكلة رؤيتك انعكاس

لفكرك

كن حراً دوماً إن الصفا والمروءة

الخوف يدمر

الانسان

التحفيز مطلب

ضروري

إفعل الشـيء

الصحيح

تحرر من القلق الحكمة ضالة

المؤمن

الصادق

الخوف يزيد

المصاعب

النصيحة

لن يحصل أبداً أحدد الخطط

المستقبلية

كفى مرارة الحياة أجب عن الاتي أكثر من المثابرة

أمثلة الجلسات الخامسة والعشرون حتى الثلاثون (لا يتطلب فيديو توضيحي)

الحديث على شكل جمل طويلة بمسـد مطول في مدة أقصاها 2-3 ثانية بدون التزامن مع حركة اليد الانتصار على

الهزيمة

افعل شيئاً جديداً التدريب أفضل

المعلمين

كن أحد الناجحين مستحيل أن أفشل

من عجائب الحياة إفعل الشيء

الصحيح

أريد أصبح عظيماً من أجل التميز تخيل صورة ما

حلمك

الخوف أقدم

الأمراض

سوف تنتهي المشكلة رؤيتك انعكاس

لفكرك

كن حراً دوماً إن الصفا والمروة

الخوف يدمر

الإنسان

التحفيز مطلب

ضروري

إفعل الشيء

الصحيح

تحرر من القلق الحكمة ضالة

المؤمن

الصادق

الخوف يزيد

المصاعب

العلم دائماً بالتعلم العالم يفسح الطريق افعل كل شيء هكذا تستمر

الحياة

النصيحة

لن يحصل أبداً أحدد الخطط

المستقبلية

كفى مرارة الحياة أجب عن الاتي أكثر من المُثابرة

أنا أحب الفوز شخص حقق

النجاح

توقف بعض الوقت إمنح الفضل لنفسك ليس هناك تحدي

ملاحظة: في هذا المرحلة، يحق للمستخدم أن يقوم بالتدريب على الجمل أعلاه أو من اختياره في حال

رغبته بذلك (على أن يكون الاختيار مماثل للأمثلة أعلاه)

الملحق ب: قائمة فحص التسليم إلى كلود

□ اقرأ الوثيقة كاملة قبل تعديل الكود.

□ أنشئ مصفوفة فجوات تربط كل متطلب بالشاشة والواجهة البرمجية والجداول الحالية.

□ صُف كل بند: يعمل / يعمل جزئيًا / مفقود / متعارض.

□ لا تحذف وظيفة صالحة.

□ لا تعيد بناء النظام كاملاً قبل إثبات الحاجة.

□ ثبت نموذج البيانات ومحرك الحالات وقواعد الانتقال أولاً.

□ نفذ لوحة إدارة المحتوى قبل اعتبار النظام قابلاً للتوسع.

□ اختبر رحلة كاملة لمستخدم من التسجيل حتى التشخيص والتقرير والعلاج والعينة وقرار الأخصائي.

□ اختبر إعادة دورة 72 ساعة مع حفظ الدورة السابقة.

□ اختبر الرجوع إلى تدريب سابق دون فقد التقدم.

□ اختبر القياسات قبل العلاج وبعده وبعده شهر وبعده ثلاثة أشهر.

□ سلّم تقريرًا بالملفات المعدلة واختبارات القبول والمشكلات المتبقية.

الملحق ج: الأمر النهائي الجاهز للإرسال إلى كلود

اعتبر هذه الوثيقة المرجع الحاكم الوحيد لإصلاح واستكمال منصة كلامي. ابدأ بتحليل النظام الحالي ومقارنته بنذًا بنذًا بهذه الوثيقة، ثم أنشئ مصفوفة فجوات. حافظ على كل جزء صالح، وأصلح الموجود قبل إعادة البناء لا تبدأ بتحسين الشكل قبل تثبيت قاعدة البيانات ومحرك الحالات وقواعد الانتقال لا تثبت المحتوى العلاجي داخل الكود لا تنفذ انتقالًا آليًا بين المستويات لا تعتبر عدد التدريبات وحده شرطًا للنجاح. بعد 72 ساعة تفتح بوابة عينة 3 دقائق، ثم تراجع الأخصائي النتيجة ويقرر الانتقال أو الإعادة. عند الإعادة أنشئ دورة 72 ساعة جديدة بالنموذج والقائمة نفسيهما مع حفظ التاريخ الكامل. في نهاية كل مرحلة سلّم: ما تم، الملفات المعدلة، اختبارات القبول، المشكلات المتبقية، وما يحتاج قرارًا من المالك العلمي.

شهادة التدقيق النهائي قبل التسليم إلى كلود

- ✓ تمت إزالة الإحالات غير التنفيذية إلى «النموذج الموجود في البرنامج» واستبدالها بحقله وقواعد تخزينه.
- ✓ تمت إزالة التكرارات النصية المطابقة داخل الملحق المصدر مع الحفاظ على أول ظهور للمعلومة.
- ✓ تم تثبيت القاعدة العلاجية النهائية: مرور 72 ساعة يفتح بوابة العينة، والنتيجة وقرار الأخصائي يحكمان الانتقال.
- ✓ تم تثبيت الجرعة المستهدفة: 100 وحدة في كل مرة، 7 مرات يوميًا، مع فاصل ساعة على الأقل، بوصفها جرعة علاجية مستهدفة لا شرط انتقال آلي.
- ✓ تم تثبيت العينة: 3 دقائق، ونوعها حسب المرحلة.
- ✓ تم تثبيت إعادة المستوى: دورة 72 ساعة جديدة بالنموذج والقائمة نفسيهما مع حفظ التاريخ السابق.
- ✓ تم تثبيت أن جميع المرضى يبدأون من المستوى الأول.
- ✓ تم تثبيت أن كل مستوى يجمع الجانب المعرفي والجانب السلوكي.
- ✓ تم تثبيت قابلية إدارة المحتوى من لوحة التحكم دون تعديل الكود.
- ✓ تم تثبيت القياسات: قبل العلاج، بعده مباشرة، بعد شهر، وبعد ثلاثة أشهر.
- ✓ تم تثبيت الاستشارة المجانية الواحدة ثم الاستشارات المدفوعة.
- ✓ تم تثبيت الرجوع للتدريبات السابقة للتقوية دون فقد التقدم.

حالة التسليم

هذه النسخة هي النسخة النظيفة المعتمدة للإرسال إلى كلود لتحليل النظام الحالي، إنشاء مصفوفة الفجوات، إصلاح الموجود، واستكمال المفقود. يجب عدم استخدام النسخ السابقة عند وجود تعارض معها.

ملحق اعتماد: لقاء المختص في مرحلة التشخيص

- يدعم النظام لقاء المختص في مرحلة التشخيص بوصفه جزءًا أصيلاً من الرحلة التشخيصية، وليس خدمة منفصلة اختيارية خارج النظام.
- يُفتح اللقاء في النقطة المحددة من مسار التشخيص بعد استكمال البيانات والاختبارات والعينات المطلوبة وفق إعدادات الإدارة.
- يرى الأخصائي قبل اللقاء ملخصًا موحدًا للتاريخ المرضي ونتائج الاختبارات والعينات والمعلومات المتاحة، حتى لا يكرر جمع المعلومات دون حاجة.
- يسجل الأخصائي نتائج المقابلة في نموذج منظم مع مساحة للملاحظات السريرية.
- تدخل معلومات اللقاء في السجل التشخيصي الموحد وتُستخدم في إنشاء مسودة التقرير التشخيصي الآلي.
- يبقى التقرير مسودة حتى يراجع الأخصائي ويعدله ويعتمده.
- يجب حفظ تاريخ اللقاء، الأخصائي، حالة الحضور، الملاحظات، وأي قرار أو طلب معلومات إضافية.
- يجب أن يكون من الممكن ربط اللقاء بموعد، وإشعار المستشفى، وتوثيق اكتماله أو إعادة جدولته.
- حالة المطابقة بعد الإصلاح: تمت معالجة الفجوة الوحيدة التي كشفها تدقيق قرارات المحادثة. هذه النسخة هي المرجع المعتمد للتنفيذ، وتلغي النسخ السابقة عند التعارض.

الإضافة المعتمدة: لقاء المختص في مرحلة التشخيص

يدعم النظام لقاءً مباشرًا بين المستفيد والمختص بوصفه جزءًا أصيلاً من رحلة التشخيص، وليس خدمة منفصلة خارج النظام.

قبل اللقاء، يستطيع المختص الاطلاع على جميع المعلومات التي جُمعت حتى تلك المرحلة، وتشمل: التاريخ المرضي، نتائج الاختبارات، العينات الكلامية، والبيانات والمعلومات الأخرى المتاحة؛ بهدف تكوين صورة أولية عن الحالة وتجنب تكرار الأسئلة دون حاجة.

أثناء اللقاء، يجري المختص المقابلة التشخيصية، ويضيف المعلومات المستخلصة منها في نموذج منظم، مع إمكانية كتابة الملاحظات السريرية الحرة.

بعد انتهاء اللقاء، تُدمج معلومات المقابلة مع:

• التاريخ المرضي.

• نتائج اختبار SSI-4 التي أدخلها المختص في الجدول.

• نتائج OASES.

• نتائج مقياس الرضا الكلامي.

• نتائج الاختبارات والمقاييس الأخرى المعتمدة.

• العينات الكلامية.

• الملاحظات السريرية.

ثم يجمع النظام هذه المعلومات في السجل التشخيصي الموحد، ويستخدمها لإنشاء مسودة التقرير التشخيصي الآلي.

تبقى المسودة قابلة للمراجعة والتعديل، ولا تصبح تقريرًا نهائيًا إلا بعد مراجعة المختص واعتمادها.

يحفظ النظام بيانات اللقاء، بما يشمل: التاريخ والوقت، اسم المختص، حالة الحضور، ملخص المقابلة، الملاحظات السريرية، المعلومات الإضافية المطلوبة، والقرارات الناتجة عن اللقاء.

كما يدعم النظام جدولة اللقاء، وإشعار المستفيد بموعده، وتوثيق إكماله أو إعادة جدولته.

حالة الاعتماد: تم اعتماد هذه الإضافة من مالك البرنامج، وأُضيفت إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ دون إجراء أي تعديل آخر على محتوى الوثيقة.

الإضافات المعتمدة – الدفعة الأولى من التدقيق التفصيلي للمحادثة

1. المدة التدريبية المستهدفة لكل مرة

تستهدف كل مرة تدريبية مدة تقارب 10 دقائق أو أكثر بحسب طبيعة المستوى وسرعة أداء المستفيد، مع بقاء إنجاز ما لا يقل عن 100 وحدة كلامية هو المكوّن التدريبي الأساسي. ولا تُستخدم مدة التدريب وحدها شرطاً آلياً للانتقال، إذ تحكم النتيجة الفعلية وقرار الأخصائي التقدم بين المستويات.

2. الهيكل السريري الأساسي للبرنامج

يتكون المسار السريري الأساسي للبرنامج من 26 وحدة: وحدة تقييم قبلي، و24 وحدة علاجية متدرجة، ووحدة تقييم بعد العلاج. ويعقب البرنامج مسار متابعة مستقل.

3. المتابعة بعد إكمال البرنامج

بعد إكمال البرنامج، يدخل المستفيد مسار المتابعة والوقاية من الانتكاس. تُجرى المتابعة في نقاط زمنية معتمدة بعد شهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، واثنى عشر شهراً، مع تسجيل العينات والقياسات والنتائج وفق متطلبات كل نقطة متابعة.

4. الفصل بين العينة التشخيصية والعينة العلاجية

يجب الفصل تقنياً وسرياً بين العينة التشخيصية والعينة العلاجية. العينة التشخيصية عينة معيارية تُجمع بغرض تطبيق SSI-4 والتقييم التشخيصي، ولا تُعامل كتدريب علاجي ولا تخضع لمنطق دورة الـ72 ساعة. أما العينة العلاجية فترسل بعد دورة التدريب في المستوى، ومدتها 3 دقائق، وهدفها تقييم مدى نجاح المستفيد في تطبيق المهارة المستهدفة واتخاذ قرار الانتقال أو الإعادة.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط الأربع من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ دون تعديل أي قرار سابق. عند وجود تعارض، تُقرأ هذه الإضافات مع القرارات العلاجية الأحدث بوصفها جزءاً من المرجع الحاكم.

الإضافات المعتمدة – الدفعة الثانية من التدقيق التفصيلي للمحاذرة

5. توثيق كل لقاء أو تفاعل سريري

يجب أن يسجل النظام لكل لقاء أو تفاعل سريري: التاريخ والوقت، اسم المختص، الهدف، التدخل أو الإجراء المنفذ، استجابة المستفيد، الملاحظات السريرية، والقرار أو الخطوة التالية. وتُحفظ السجلات تاريخيًا مع سجل التعديلات.

6. حالات التقرير التشخيصي ومنع تعديله دون أثر

يمر التقييم والتقرير التشخيصي بالحالات التالية: مسودة – قيد المراجعة – معتمد. وإذا عُدّل التقرير بعد الاعتماد، يُنشأ تعديل موثق أو إصدار جديد مع حفظ النسخة السابقة، واسم من عُدّل، والتاريخ، وسبب التعديل. ولا يجوز الكتابة فوق التقرير المعتمد أو حذف تاريخه.

8. توثيق التقدم بعد كل مراجعة للأخصائي

بعد كل مراجعة لعينة علاجية، ينشئ النظام سجل تقدم يتضمن: المستوى، رقم دورة الـ 72 ساعة، العينة، التقييم الذاتي، توقع العينة القادمة، تقييم الأخصائي لعناصر الأداء، مقارنة مختصرة بالعينة السابقة، القرار، والمبررات السريرية والخطوة التالية. ولا يُستبدل السجل السابق عند إعادة المستوى.

9. حالات دورة الـ 72 ساعة والعينة

تمر دورة المستوى بالحالات التالية: لم تبدأ – تدريب نشط – اكتملت 72 ساعة وأصبحت العينة متاحة – العينة قيد التسجيل – أرسلت للمراجعة – قيد مراجعة الأخصائي – قرار انتقال أو إعادة. ويجب أن يمنع النظام الانتقالات غير الصحيحة ويحفظ تاريخ كل تغيير في الحالة.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 5 و6 و8 و9 من الدفعة الثانية وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ. لم تُعتمد النقطة 7 الخاصة بالخطة العلاجية الفردية، ولذلك لم تُضاف إلى الوثيقة. لم يُجر أي تعديل آخر على القرارات السابقة.

الإضافات المعتمدة – الدفعة الثالثة من التدقيق التفصيلي للمحادثة

10. الفصل بين تسجيل التدريب وجودة الأداء العلاجي

يُفَرَّق النظام بين الالتزام بالتدريب وجودة الأداء العلاجي. يسجل عدد مرات التدريب، ومدته، والفواصل الزمنية، والوحدات المنجزة بوصفها مؤشرات التزام فقط. أما جودة اكتساب المهارة فلا يحكم عليها النظام من هذه البيانات وحدها، وإنما تُقَيَّم من خلال العينة العلاجية ونتائج الأداء ومراجعة الأخصائي.

11. ضبط إرسال العينات أثناء انتظار قرار الأخصائي

بعد إرسال العينة العلاجية الخاصة بدورة الـ 72 ساعة، تنتقل الدورة إلى حالة «قيد مراجعة الأخصائي»، ولا تُرسل عينة انتقال جديدة للدورة نفسها حتى يصدر القرار. ويستطيع المستفيد الاستمرار في التدريب الحر أثناء الانتظار دون أن يؤدي ذلك إلى إنشاء عينة انتقال إضافية أو تغيير حالة الدورة.

12. ما يراه المستفيد بعد إرسال العينة

بعد إرسال العينة، يعرض النظام للمستفيد تأكيدًا واضحًا باستلامها وحالتها الحالية، مع رسالة تفيد بأنها قيد مراجعة الأخصائي. ويستطيع المستفيد خلال فترة الانتظار مراجعة المحتوى المعرفي والتدريب الحر على المستوى الحالي والمستويات السابقة المفتوحة، دون فتح المستوى التالي أو إعادة ضبط دورة الـ 72 ساعة.

13. مهلة مراجعة الأخصائي للعينة والتنبيه عند التأخر

تسجل المنصة وقت استلام كل عينة علاجية، وتتابع زمن انتظارها للمراجعة. وتتيح الإدارة تحديد المدة التشغيلية المستهدفة لمراجعة العينات. وعند اقتراب تجاوزها أو تجاوزها، يرسل النظام تنبيهًا للأخصائي ثم للمشرف وفق قواعد التصعيد المعتمدة. ولا يصدر النظام قرار انتقال أو إعادة تلقائيًا بسبب التأخر.

14. التغذية الراجعة للمستفيد بعد مراجعة العينة

عند اعتماد مراجعة العينة، يتلقى المستفيد نتيجة واضحة تتضمن: قرار الانتقال أو الإعادة، وتغذية راجعة مختصرة ومفهومة حول نقاط الأداء الجيدة وما يحتاج إلى تحسين، وتعليمات الخطوة التالية. ولا تظهر للمستفيد الملاحظات السريية الداخلية التي يحددها الأخصائي أو النظام بأنها خاصة بالفريق العلاجي.

15. المقارنة الزمنية للعينات أمام الأخصائي

توفر لوحة الأخصائي عرضًا زمنيًا للعينات العلاجية يتيح مقارنة العينة الحالية بالعينة السابقة والعينات المختارة، مع إظهار: المستوى، رقم دورة الـ 72 ساعة، التاريخ، تقييم المستفيد، توقعه السابق، تقييم الأخصائي، القرار، وعناصر الأداء المستهدفة. ولا يُستخدم الذكاء الاصطناعي لإصدار قرار الانتقال بدل الأخصائي.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 كاملة من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ دون تعديل أي قرار سابق. وبالنسبة للنقطة 11، تم اعتماد منع إرسال عينة انتقال جديدة للدورة نفسها أثناء انتظار قرار الأخصائي، مع السماح بالتدريب الحر خلال فترة الانتظار.

الإضافات المعتمدة – الدفعة الرابعة من التدقيق التفصيلي للمحاذرة

16. عدم إرسال العينة بعد فتحها والانقطاع القصير

بعد مرور 72 ساعة تصبح العينة العلاجية متاحة للمستفيد، ويُمنح المستفيد يومين إضافيين لإرسال العينة.

إذا لم يرسل العينة خلال اليومين الإضافيين، يبدأ النظام بإرسال التذكيرات وفق القواعد التي يحددها مسؤول النظام.

عند الانقطاع، يبقى البرنامج مفتوحًا للمستفيد حتى المرحلة التي وصل إليها فقط لمدة شهر واحد، ويستطيع خلال هذه المدة العودة إلى البرنامج والتدريب على المحتوى والمراحل المفتوحة له.

بعد انتهاء مدة الشهر، يُغلق البرنامج أمام المستفيد، ولا يستطيع استكمالها مباشرة.

تكون جميع هذه القواعد قابلة للتحكم من مسؤول النظام، بما يشمل: مدة الفرصة الإضافية بعد فتح العينة، وتوقيت التذكيرات وعددها، ومدة بقاء البرنامج مفتوحًا بعد الانقطاع، وإجراء الإغلاق وإعادة التفعيل.

لا يعتبر النظام عدم إرسال العينة نجاحًا أو رسوبًا، ولا ينقل المستفيد تلقائيًا إلى المستوى التالي.

17. الانقطاع الطويل والعودة إلى البرنامج

إذا تجاوز المستفيد مدة الانقطاع المسموح بها وأغلق البرنامج، ثم عاد لاحقًا إلى العلاج، فإنه يبدأ البرنامج العلاجي من جديد من المستوى الأول، ولا يستكمل من المستوى الذي توقف عنده.

يحتفظ النظام بجميع بيانات البرنامج السابق وسجلات التدريب والعينات والتقييمات وقرارات الأخصائي لأغراض التتبع والمقارنة، لكنها لا تُستخدم لفتح المستويات السابقة تلقائيًا في الدورة العلاجية الجديدة.

ينشئ النظام عند العودة دورة علاجية جديدة مستقلة مرتبطة بالسجل التاريخي السابق للمستفيد.

يتحكم مدير النظام في قواعد الانقطاع والعودة، ويملك الصلاحية المخولة لإعادة تفعيل البرنامج أو تطبيق قاعدة البدء من جديد وفق السياسة المعتمدة.

18. فشل رفع العينة أو انقطاع الإنترنت

يحفظ النظام تسجيل العينة محليًا أو مؤقتًا بصورة آمنة حتى يكتمل الرفع، ويعرض تقدم الرفع وحالته. إذا انقطع الاتصال، يستطيع المستفيد استكمال الرفع دون إعادة التسجيل متى كان ذلك ممكنًا تقنيًا. ولا تنتقل الدورة إلى «أُرسلت للمراجعة» إلا بعد اكتمال رفع الملف والتحقق من سلامته وتسجيل الاستلام. وعند فشل الملف أو تلفه، تظهر تعليمات واضحة لإعادة المحاولة دون فقد بيانات دورة الـ 72 ساعة.

19. فحص جودة العينة تقنيًا قبل إرسالها

قبل الإرسال النهائي، يتحقق النظام تقنيًا من أن العينة قابلة للمراجعة، مثل وجود صوت، واكتمال المدة المطلوبة، وعدم تلف الملف. ويتيح للمستفيد الاستماع إلى العينة وإعادة تسجيلها قبل الإرسال. هذا الفحص تقني فقط، ولا يحكم على جودة تطبيق المهارة العلاجية ولا يتخذ قرار الانتقال.

20. تصحيح قرار الأخصائي إذا صدر بالخطأ

لا يُحذف قرار الأخصائي بعد اعتماده. إذا اكتُشف خطأ، يستخدم المختص المخول إجراء «تصحيح قرار» مع تسجيل القرار السابق، والقرار المصحح، وسبب التصحيح، واسم من أجره، وتاريخه. وإذا كان القرار السابق قد فتح مستوى جديدًا أو أنشأ دورة جديدة، يعالج النظام الآثار المترتبة وفق صلاحيات محددة دون حذف التاريخ السري.

21. اختصاص أخصائي واحد فقط بفحص العينة

لا يسمح النظام بفحص العينة العلاجية الواحدة إلا بواسطة أخصائي واحد فقط.

عند إسناد العينة إلى أخصائي، تصبح محجوزة له للمراجعة، ولا يستطيع أي أخصائي آخر فتحها بغرض التقييم أو إدخال تقييم أو إصدار قرار عليها.

يسجل النظام اسم الأخصائي المسؤول عن العينة، ووقت الإسناد، ووقت بدء المراجعة، ووقت اعتماد القرار.

إذا تعذر على الأخصائي إكمال المراجعة، فلا تنتقل العينة إلى أخصائي آخر إلا من خلال إعادة إسناد رسمية ينفذها المستخدم المخول، مع حفظ اسم الأخصائي السابق والجديد وسبب إعادة الإسناد وتاريخه.

في جميع الأحوال، يكون للعينة تقييم سريري نهائي واحد وقرار نهائي واحد.

22. الموافقات على استخدام التسجيلات والبيانات

يفصل النظام بين الموافقة اللازمة لاستخدام البيانات والعينات في تقديم الخدمة العلاجية، وأي موافقة اختيارية مستقلة لاستخدام البيانات أو التسجيلات في البحث أو التدريب أو تطوير النظام. رفض الاستخدام الاختياري لا يمنع المستفيد من الحصول على العلاج. وتُحفظ نسخة الموافقة وتاريخها وإصدارها، مع إمكانية سحب الموافقة الاختيارية وفق السياسة المعتمدة.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 كاملة من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ. واعتمدت النقاط 16 و17 و21 بالصياغة المعدلة وفق قرارات مالك البرنامج: يومان إضافيان لإرسال العينة، وبقاء البرنامج مفتوحًا لمدة شهر بعد الانقطاع مع تحكم المسؤول، والبدء من المستوى الأول بعد الانقطاع الطويل وفق صلاحيات مدير النظام، ومنع فحص العينة إلا بواسطة أخصائي واحد مع إعادة إسناد رسمية عند الحاجة. لم يُجر أي تعديل آخر على القرارات السابقة.

الإضافات المعتمدة – النقاط 23 إلى 25

23. التدريب خلال دورة الـ 72 ساعة

خلال دورة الـ 72 ساعة يكون النشاط تدريبيًا وممارسة فقط، ولا يُطلب من المستفيد تسجيل أي عينة أثناء التدريبات اليومية. يتدرب المستفيد على ما لا يقل عن 100 وحدة في كل مرة تدريبية، وبجرعة مستهدفة قدرها 7 مرات يوميًا، مع فاصل لا يقل عن ساعة بين كل مرة وأخرى.

24. بدء التسجيل بعد اكتمال 72 ساعة فقط

لا يفتح النظام خاصية تسجيل العينات قبل اكتمال مدة الـ 72 ساعة. بعد اكتمالها، ينتقل المستفيد إلى مرحلة التسجيل، ويسجل من 3 إلى 5 محاولات، ولا يُطلب منه تسجيل الوحدات المائة التي تدرب عليها.

25. اختيار أفضل عينة وإرسالها للأخصائي

بعد تسجيل 3 إلى 5 محاولات، يراجع المستفيد محاولاته ويختار أفضل عينة واحدة فقط، مدتها 3 دقائق، ثم يستكمل التقييم الذاتي وتوقع العينة القادمة ويرسل الحزمة إلى الأخصائي. المحاولات الأخرى لا تُعامل كعينات انتقال مستقلة، ولا يصدر عليها قرار منفصل. وتبقى جودة الأداء وقرار الانتقال أو إعادة المستوى من اختصاص الأخصائي.

حالة الاعتماد

تم اعتماد الصياغة النهائية للنقاط 23 و 24 و 25 من مالك البرنامج. وتلغي هذه الصياغة أي تفسير سابق يوجي بتسجيل عينات أثناء دورة الـ 72 ساعة أو تسجيل 100 عينة. القاعدة المعتمدة هي: تدريب فقط خلال 72 ساعة، ثم تسجيل 3 إلى 5 محاولات، ثم اختيار أفضل عينة واحدة مدتها 3 دقائق وإرسالها للأخصائي.

الإضافة المعتمدة – النقطة 26: إدارة قوائم التدريب بحسب نوع الوحدة والمرحلة العمرية

تُدار قوائم التدريب من لوحة التحكم وفق المستوى العلاجي ونوع الوحدة التدريبية.

في مستويات المقاطع والكلمات المفردة، تكون القوائم متشابهة أو مشتركة بين الفئات العمرية بحسب المحتوى العلاجي المعتمد، ولا ينشئ النظام اختلافًا مصطنعًا بين الأطفال والبالغين إذا لم يكن هناك اختلاف علاجي فعلي.

يبدأ الاختلاف المرتبط بالعمر بصورة أوضح في مستويات العبارات والجمل؛ حيث تُعد القوائم بما يتناسب مع عمر المستفيد، ولغته، ومواقف حياته، وقدرته على الفهم والاستخدام.

يدعم النظام الأنماط التالية للقوائم:

1. قائمة مشتركة بين الفئات العمرية، وتستخدم خصوصًا في المقاطع والكلمات المفردة.

2. قائمة مخصصة لفئة عمرية، وتستخدم عند الحاجة في العبارات والجمل.

3. قائمة مشتركة مع بدائل عمرية لبعض العناصر عند الحاجة.

لكل قائمة إصدار مستقل وتاريخ اعتماد ونشر. وإذا نُشر إصدار جديد، فلا تتغير القائمة المرتبطة بدورة علاجية بدأت بالفعل، ويحتفظ النظام بالإصدار الفعلي الذي تدرب عليه المستفيد.

قاعدة حاكمة مصححة

القوائم في المقاطع والكلمات المفردة متشابهة أو مشتركة، بينما تظهر الفروق المرتبطة بالعمر بصورة أساسية في العبارات والجمل.

حالة الاعتماد

تم اعتماد هذه الصياغة من مالك البرنامج. وتلغي هذه القاعدة أي صياغة سابقة تفترض أن جميع قوائم المقاطع والكلمات المفردة مختلفة بالضرورة لكل مرحلة عمرية. لم تُعتمد بعد النقاط 27 و28 و29 و30، ولذلك لم تُضف في هذه الخطوة.

الإضافات المعتمدة – النقاط 27 إلى 30

27. تثبيت محتوى دورة الـ 72 ساعة بعد بدئها

عند بدء دورة الـ 72 ساعة، يثبت النظام إصدار جميع العناصر العلاجية المرتبطة بها، وتشمل: النموذج البشري، قائمة التدريب، التقنية أو التقنيات المستهدفة، والتعليمات.

لا تتغير هذه العناصر داخل الدورة النشطة، حتى لو نشرت الإدارة إصدارًا جديدًا أثناء الـ 72 ساعة.

تطبق الإصدارات الجديدة على الدورات اللاحقة وفق قواعد النشر التي يحددها مسؤول النظام.

إذا قرر الأخصائي إعادة المستوى، يعيد المستفيد دورة جديدة باستخدام النموذج والقائمة نفسيهما اللذين تدرب عليهما في الدورة السابقة، تطبيقًا للقرار العلاجي المعتمد.

28. مشاهدة النموذج قبل أول تدريب في المستوى

عند دخول المستوى لأول مرة، يشاهد المستفيد النموذج العلاجي البشري قبل بدء التدريب.

بعد المشاهدة الأولى، لا يشترط النظام إعادة مشاهدة النموذج في كل مرة من مرات التدريب اليومية، ويظل النموذج متاحًا للمستفيد للرجوع إليه متى احتاج.

يسجل النظام إكمال المشاهدة الأولى بوصفها خطوة تهيئة للمستوى، ولا يعتبر مجرد مشاهدة النموذج دليلًا على إتقان المهارة أو نجاح المستوى.

29. تكرار إعادة المستوى أكثر من مرة

يسمح النظام بإعادة دورة المستوى أكثر من مرة عند عدم تحقق النتيجة المطلوبة، مع حفظ كل دورة وعينتها وتقييمها وقرار الأخصائي بصورة مستقلة.

يتيح النظام لمدير النظام تحديد عدد الإعادات المتتالية الذي عنده يظهر تنبيه للأخصائي أو المشرف لمراجعة الحالة.

لا ينقل النظام المستفيد تلقائيًا إلى المستوى التالي، ولا يعيده تلقائيًا إلى بداية البرنامج، ولا يوقف علاجه لمجرد وصوله إلى عدد معين من الإعادات. أي قرار سريري لاحق يصدر عن الشخص المخول.

عدد الإعادات الذي يؤدي إلى التنبيه قابل للتحكم من إدارة النظام ولا يثبت داخل الكود.

30. حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في النظام

يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المختص في تنظيم البيانات، واستخلاص نتائج الاختبارات المسموح باستخلاصها آليًا، وتلخيص المعلومات، وإعداد مسودات التقارير، وعرض المقارنات والمؤشرات الداعمة.

لا يجوز للذكاء الاصطناعي منفردًا اعتماد التشخيص النهائي، أو اعتماد التقرير التشخيصي النهائي، أو إصدار قرار النجاح العلاجي، أو نقل المستفيد إلى المستوى التالي، أو إعادة المستوى، أو إنهاء البرنامج العلاجي، أو تغيير قرار الأخصائي.

تبقى جميع القرارات السريرية النهائية للمختص المخول، ويجب أن يكون واضحًا في النظام ما أنشأه الذكاء الاصطناعي بوصفه مسودة أو دعمًا للقرار وما اعتمده المختص فعليًا.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 27 و 28 و 29 و 30 كاملة من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ دون تعديل أي قرار سابق. وبذلك أصبحت النقاط 23 إلى 30 المعروضة في الدفعة الخامسة والسادسة معتمدة بعد التصحيحات والتوضيحات التي قررها مالك البرنامج.

تصحيح معتمد وحاكم – النقاط 23 و24 و25 و31

23. التدريب خلال دورة الـ72 ساعة

خلال دورة الـ72 ساعة يكون النشاط تدريبيًا وممارسة فقط، ولا يُطلب من المستفيد تسجيل أي عينة أثناء التدريبات اليومية.

يتدرب المستفيد على ما لا يقل عن 100 وحدة تدريبية في كل مرة، وفق محتوى المستوى: مقاطع، كلمات، عبارات، جمل، أو غيرها.

الجرعة المستهدفة هي 7 مرات يوميًا، مع فاصل لا يقل عن ساعة بين كل مرة وأخرى.

لا يُستخدم عدد التدريبات أو مدتها وحدهما للحكم على جودة الأداء أو الانتقال؛ إذ تحكم النتيجة الفعلية للعينة ومراجعة الأخصائي.

24. فتح مرحلة التسجيل بعد انتهاء 72 ساعة

لا يفتح النظام خاصية تسجيل العينة العلاجية قبل اكتمال 72 ساعة من التدريب.

بعد اكتمال المدة، تفتح مرحلة تسجيل عينة علاجية واحدة متكاملة، ولا يُطلب من المستفيد تسجيل 100 وحدة أو تسجيل عدة عينات مستقلة.

25. بنية العينة العلاجية المتكاملة

تتكون العينة العلاجية من عدة أجزاء ومهام كلامية داخل عينة واحدة، وفق متطلبات المستوى العلاجي.

قد تشمل، بحسب المرحلة: نطق 3 مقاطع، وكلمات، وعبارات، وجمل، وغيرها من المهام الكلامية المحددة للمستوى.

يجمع النظام جميع الأجزاء المطلوبة في عينة واحدة متكاملة مدتها الإجمالية 3 دقائق.

يؤدي المستفيد الأجزاء المطلوبة، ويحرص على أن يكون الأداء المسجل جيدًا ويمثل أفضل تطبيق ممكن للمهارة العلاجية المستهدفة.

تختلف مكونات العينة ونوع المهام بحسب المستوى العلاجي، وتكون قابلة للإدارة من لوحة التحكم دون تعديل الكود.

31. إرسال العينة المتكاملة للأخصائي

بعد إكمال جميع أجزاء العينة العلاجية المتكاملة، يستكمل المستفيد التقييم الذاتي وتوقعه للعينة القادمة، ثم يراجع ملخص الإرسال ويؤكد إرسال العينة الواحدة الكاملة ومدتها 3 دقائق إلى الأخصائي.

يراجع الأخصائي العينة بجميع أجزائها بوصفها وحدة تقييم واحدة، ثم يقيم مدى نجاح المستفيد في تطبيق المهارة المستهدفة ويتخذ قرار الانتقال أو إعادة المستوى.

لا توجد في هذا المسار قاعدة «تسجيل 3-5 عينات ثم اختيار أفضل عينة»، وتُلغى أي صياغة سابقة تتعارض مع هذه القاعدة.

القاعدة الحاكمة النهائية للعينة العلاجية

72 ساعة تدريب فقط – فتح التسجيل – عينة واحدة متكاملة من عدة أجزاء – مدتها الإجمالية 3 دقائق – تقييم ذاتي وتوقع للعينة القادمة – إرسالها إلى أخصائي واحد للمراجعة.

حالة الاعتماد

تم اعتماد هذا التصحيح من مالك البرنامج. وتلغى هذه الصياغة أي نص سابق يفيد بتسجيل 3 إلى 5 محاولات أو عينات، أو اختيار أفضل عينة من بينها. لم يُجر أي تعديل آخر على القرارات المعتمدة.

الإضافات المعتمدة – النقاط 32 إلى 38

32. تكوين العينة العلاجية بحسب المستوى

يكون لكل مستوى علاجي قالب عينة معتمد يحدد مكونات العينة وترتيبها والمهام الكلامية المطلوبة داخلها. وقد تشمل المكونات: مقاطع، كلمات، عبارات، جمل، قراءة، وصف، أو حديثاً وفق متطلبات المرحلة.

لا يشترط أن تحتوي كل عينة في جميع المستويات على المكونات نفسها. ويحدد مالك المحتوى العلاجي مكونات كل عينة من لوحة الإدارة دون تعديل الكود.

تبقى المدة الإجمالية المستهدفة للعينة المتكاملة 3 دقائق.

33. رحلة تسجيل العينة المتكاملة

بعد اكتمال 72 ساعة، تظهر للمستفيد شاشة توضح مكونات العينة المطلوبة قبل بدء التسجيل.

تكون الرحلة بالترتيب التالي: عرض التعليمات ← عرض أجزاء العينة المطلوبة ← بدء التسجيل ← تنفيذ جميع الأجزاء داخل العينة الواحدة ← مراجعة التسجيل ← التقييم الذاتي ← توقع العينة القادمة ← مراجعة ملخص الإرسال ← الإرسال للأخصائي.

لا تُرسل أجزاء العينة منفصلة، بل تصل إلى الأخصائي بوصفها عينة علاجية واحدة متكاملة.

34. إعادة تسجيل العينة قبل إرسالها

بعد تسجيل العينة المتكاملة، يستطيع المستفيد الاستماع إليها أو مراجعتها قبل الإرسال. وإذا رأى أنها لا تمثل أداءً جيداً، يستطيع حذف التسجيل وإعادة تسجيل العينة كاملة قبل الإرسال النهائي.

بعد تأكيد الإرسال، تُقفل العينة ولا يستطيع المستفيد استبدالها أو حذفها.

أي إجراء استثنائي بعد الإرسال يتم بواسطة مستخدم مخول، مع توثيق السبب والإجراء.

35. التقييم المستقل للأخصائي قبل رؤية تقييم المستفيد

عند فتح الأخصائي للعينة، يستمع إليها ويقيمها أولاً دون رؤية التقييم الذاتي للمستفيد أو توقعه للعينة القادمة.

بعد حفظ تقييم الأخصائي الأولي، تظهر له إجابات المستفيد، ثم يستطيع استكمال ملاحظاته واتخاذ القرار النهائي.

36. شاشة مراجعة العينة لدى الأخصائي

تعرض شاشة الأخصائي في مكان واحد: المستوى العلاجي، رقم دورة الـ 72 ساعة، تاريخ بداية الدورة ونهايتها، النموذج البشري المستخدم وإصداره، قائمة التدريب وإصدارها، التقنية أو التقنيات المستهدفة، مؤشرات الالتزام بالتدريب، العينة العلاجية المتكاملة، ومكونات العينة المطلوبة.

تعرض الشاشة كذلك تقييم عناصر الأداء: تزامن حركة اليد مع الكلام، مدة التزامن، البطء والتحكم، رفع الصوت، وفتح الفم، بحسب انطباق كل عنصر على المستوى.

كما تعرض العينة السابقة والقرار السابق للمقارنة، ثم يظهر التقييم الذاتي وتوقع المستفيد بعد حفظ تقييم الأخصائي الأولي وفق القاعدة المعتمدة في النقطة 35.

بعد ذلك يسجل الأخصائي القرار والمبررات والتغذية الراجعة.

37. إعادة تسجيل العينة لأسباب تقنية

إذا كانت العينة غير قابلة للتقييم بسبب مشكلة تقنية، مثل غياب الصوت، أو تلف الملف، أو انقطاع التسجيل، أو عدم اكتمال أجزاء جوهرية منها، فلا يصدر الأخصائي قرار «انتقال» أو «إعادة مستوى».

يستخدم الأخصائي حالة مستقلة هي «إعادة تسجيل العينة لأسباب تقنية».

تفتح للمستفيد إعادة تسجيل العينة المتكاملة دون إعادة دورة الـ 72 ساعة، لأن سبب الإعادة تقني وليس فشلاً في تطبيق المهارة.

يُحفظ سبب طلب إعادة التسجيل وتاريخه.

38. إعادة المستوى لأسباب علاجية

إذا كانت العينة مكتملة وقابلة للتقييم، لكن أداء المستفيد لا يحقق المستوى المطلوب، يصدر الأخصائي قرار «إعادة المستوى».

يبدأ النظام دورة علاجية جديدة مدتها 72 ساعة باستخدام النموذج والقائمة نفسيهما، وفق القاعدة المعتمدة، مع حفظ الدورة والعينة والقرار السابق كاملاً.

يجب ألا يخلط النظام بين: إعادة تسجيل لأسباب تقنية ← لا تعيد الـ 72 ساعة. إعادة المستوى لأسباب علاجية ← تبدأ دورة 72 ساعة جديدة.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 كاملة من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ دون تعديل أي قرار سابق. وتشمل الموافقة اعتماد التقييم المستقل للأخصائي قبل إظهار التقييم الذاتي للمستفيد وتوقعه.

الإضافات المعتمدة – النقاط 39 إلى 46

39. تقييم كل جزء من أجزاء العينة المتكاملة

يراجع الأخصائي العينة العلاجية المتكاملة بوصفها وحدة واحدة، مع إمكانية تقييم كل جزء من أجزائها المطلوبة بصورة منظمة.

يعرض النظام مكونات العينة وفق قالب المستوى، ويسجل الأخصائي ملاحظاته على كل جزء عند الحاجة، ثم يصدر تقييمًا نهائيًا واحدًا للعينة كاملة.

لا يصدر قرار انتقال مستقل لكل جزء؛ القرار النهائي يخص المستوى بوصفه وحدة علاجية واحدة.

40. إظهار معايير التقييم المناسبة فقط لكل مستوى

يحدد مالك المحتوى العلاجي من لوحة الإدارة معايير الأداء التي تنطبق على كل مستوى.

عند مراجعة العينة، يعرض النظام للأخصائي المعايير المرتبطة بذلك المستوى فقط، بدل فرض جميع المعايير على جميع المستويات.

تشمل مكتبة المعايير الأساسية: تزامن حركة اليد مع الكلام، مدة التزامن، البطء والتحكم، رفع الصوت، فتح الفم، وأي معيار علاجي يضاف لاحقًا من خلال إدارة المحتوى.

41. عدم تحويل معايير الأداء إلى قرار نجاح آلي

يجوز للنظام تنظيم درجات ومعايير الأداء وعرضها للأخصائي، لكنه لا يحولها تلقائيًا إلى قرار نجاح أو رسوب ما لم يعتمد مالك البرنامج لاحقًا قاعدة سريرية محددة لذلك.

في النسخة الحالية، تبقى النتيجة الكلية ومراجعة العينة والحكم السريري للأخصائي هي الأساس في قرار الانتقال أو إعادة المستوى.

42. منع اعتماد القرار قبل إكمال تقييم العينة

لا يسمح النظام للأخصائي باعتماد قرار الانتقال أو إعادة المستوى قبل استكمال الحقول الإلزامية المحددة لقالب تقييم ذلك المستوى.

تشمل الحقول الإلزامية، بحسب المستوى: تقييم عناصر الأداء المطلوبة، القرار، والمبررات السريرية المختصرة.

يمكن حفظ التقييم كمسودة والعودة إليه لاحقًا دون إصدار قرار نهائي.

43. الفصل بين الملاحظات الداخلية والتغذية الراجعة للمستفيد

يفصل النظام بين الملاحظات السريرية الداخلية، التي يراها الفريق المخول فقط ولا تظهر للمستفيد، والتغذية الراجعة للمستفيد، وهي رسالة مختصرة ومفهومة توضح ما أتقنه وما يحتاج إلى تحسينه والخطوة التالية.

لا ينسخ النظام الملاحظات السريرية الداخلية تلقائيًا إلى رسالة المستفيد.

44. ما يحدث بعد قرار الانتقال وبداية دورة الـ 72 ساعة الجديدة

عند اعتماد الأخصائي قرار الانتقال، يُغلق المستوى الحالي بوصفه مستوى مجتازًا، مع الاحتفاظ بجميع دوراته وعيناته وتقييماته وقراراته.

يفتح النظام المستوى التالي للمستفيد، ويعرض تعليماته ومحتواه المعرفي والنموذج العلاجي المخصص له.

لا يبدأ عداد الـ 72 ساعة بمجرد فتح المستوى الجديد أو دخول المستفيد إليه.

يجب على المستفيد أولاً مشاهدة النموذج العلاجي البشري وفق القاعدة المعتمدة. وبعد مشاهدة النموذج وبدء أول تدريب فعلي في المستوى، تبدأ دورة الـ 72 ساعة ويُسجل وقت بدايتها رسميًا.

إذا فتح المستفيد المستوى أو شاهد التعليمات أو المحتوى المعرفي فقط دون بدء أول تدريب فعلي، فلا يبدأ عداد الـ 72 ساعة.

بعد بدء أول تدريب، تثبت عناصر الدورة وفق القواعد المعتمدة، بما يشمل النموذج والقائمة والتقنيات والتعليمات وإصداراتها.

التسلسل الحاكم: قرار انتقال ← فتح المستوى التالي ← التعليمات والمحتوى المعرفي ← مشاهدة النموذج ← بدء أول تدريب فعلي ← بدء عداد 72 ساعة وتثبيت محتوى الدورة.

45. ما يحدث بعد قرار إعادة المستوى

عند اعتماد قرار إعادة المستوى، يتلقى المستفيد التغذية الراجعة وتعليمات الإعادة.

ينشئ النظام دورة 72 ساعة جديدة مستقلة للمستوى نفسه، باستخدام النموذج والقائمة نفسيهما، مع الاحتفاظ بالدورة السابقة كاملة.

لا تُدمج سجلات الدورة الجديدة مع القديمة، ويظهر للأخصائي بوضوح رقم كل دورة وتسلسلها.

46. إشعار الأخصائي عند عدم فتح المستفيد للقرار

يسجل النظام ما إذا كان المستفيد قد فتح نتيجة مراجعة العينة واطلع على قرار الأخصائي.

إذا لم يفتح النتيجة خلال المدة التي تحددها الإدارة، يرسل النظام تذكيرًا للمستفيد، ويمكن إظهار الحالة للأخصائي أو المشرف.

تكون مدة التذكير وقواعد التصعيد قابلة للتحكم من مسؤول النظام.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 كاملة من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ. واعتمدت النقطة 44 بصيغتها المعدلة لا يبدأ عداد الـ 72 ساعة في المستوى الجديد إلا بعد مشاهدة النموذج وبدء أول تدريب فعلي. لم يُجرَ أي تعديل آخر على القرارات السابقة.

الإضافات المعتمدة – النقاط 47 إلى 54

47. الفصل الوظيفي بين الجانب المعرفي والجانب السلوكي

يتكون كل مستوى علاجي من مسارين مترابطين: المسار المعرفي العلاجي والمسار السلوكي التدريبي. لكل مسار مكوناته وسجلاته وحالة إكماله، مع ظهورهما للمستفيد ضمن رحلة علاجية واحدة متكاملة. لا يُعامل المحتوى المعرفي بوصفه محتوى تثقيفيًا إضافيًا، بل جزءًا أصليًا من البرنامج العلاجي.

48. مقطع الفيديو المعرفي في كل جلسة

يتضمن الجانب المعرفي في كل جلسة أو وحدة علاجية مقطعي فيديو وفق المحتوى العلاجي المعتمد. تكون الفيديوهات قابلة للإدارة من لوحة التحكم، بما يشمل العنوان، والترتيب، والنسخة، والفئة المستهدفة، والأسئلة المرتبطة بها، وحالة النشر.

لا يجوز حذف فيديو أو استبداله في جلسة بدأها المستفيد بطريقة تغير سجله التاريخي.

49. الأسئلة المرتبطة بالفيديوهات

بعد المحتوى المعرفي، يعرض النظام الأسئلة المعتمدة المرتبطة بالفيديو أو بالجلسة.

تحفظ إجابات المستفيد وتاريخها ومحاولاته، وتكون الأسئلة وأنواع الإجابات وقواعد عرض التغذية الراجعة قابلة للإدارة من لوحة التحكم دون تعديل الكود.

لا يفترض المبرمج أن جميع الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد؛ يجب أن تدعم البنية أنواعًا مختلفة وفق المحتوى الأصلي للبرنامج.

50. قاعدة الانتقال من الجانب المعرفي إلى الجانب السلوكي

يشاهد المستفيد المحتوى المعرفي ويجب عن الأسئلة وفق البروتوكول العلاجي المعتمد.

لا تُفرض في النظام نسبة نجاح ثابتة أو عتبة اجتياز من اجتهد المبرمج. إذا لم ينص المحتوى العلاجي الأصلي على درجة نجاح محددة، فيكفي إكمال المحتوى والإجابة عن الأسئلة للانتقال إلى الجانب السلوكي.

تظل قواعد الإكمال أو النجاح، إن وُجدت في أي وحدة، قابلة للإدارة من لوحة التحكم وفق البروتوكول المعتمد دون تعديل الكود.

51. توقيت الجانب المعرفي بالنسبة لدورة الـ 72 ساعة

يعرض المحتوى المعرفي الخاص بالمستوى قبل بدء التدريب السلوكي وفق ترتيب البرنامج.

مشاهدة الفيديوهات والإجابة عن الأسئلة لا تبدأ عداد الـ 72 ساعة.

يبدأ العداد فقط وفق القاعدة المعتمدة: بعد مشاهدة النموذج العلاجي وبدء أول تدريب فعلي.

52. حفظ تقدم المستفيد داخل الجانب المعرفي

يحفظ النظام تقدم المستفيد داخل الجانب المعرفي، بما يشمل الفيديو الذي شاهده، وموضع التوقف عند الحاجة، والأسئلة التي أجاب عنها، وحالة إكمال الوحدة.

إذا خرج المستفيد من النظام، يستطيع العودة إلى موضعه دون فقد الإجابات أو إعادة الوحدة كاملة، ما لم تفرض القاعدة العلاجية المعتمدة خلاف ذلك.

53. إعادة مشاهدة المحتوى المعرفي

بعد إكمال المحتوى المعرفي، يظل متاحًا للمستفيد للرجوع إليه وإعادة مشاهدته للتقوية.

إعادة المشاهدة لا تعيد ضبط المستوى، ولا تعيد دورة الـ 72 ساعة، ولا تُحتسب جلسة علاجية جديدة، لكنها تُسجل في بيانات الاستخدام والتحليل.

54. إدارة المحتوى المعرفي بالكامل من لوحة الإدارة

يجب ألا يكون المحتوى المعرفي مثبتًا داخل الكود. يستطيع المستخدم الإداري المخول إنشاء الوحدات المعرفية وتعديلها وترتيبها وربطها بالمستويات والفئات المستهدفة.

تشمل الإدارة: الفيديوهات، والنصوص، والتعليمات، والأسئلة، والإجابات، والتغذية الراجعة، وترتيب العرض، والإصدارات، والنشر والإيقاف.

تحفظ المنصة الإصدار الذي تلقاه المستفيد فعليًا، ولا تغير التعديلات اللاحقة سجله السابق.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 جميعًا من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ. وفي النقطة 50، لا تُفرض نسبة نجاح ثابتة من اجتهاد المبرمج؛ ويكون الانتقال وفق البروتوكول العلاجي الأصلي، ويكفي إكمال المحتوى والإجابة عن الأسئلة إذا لم توجد عتبة نجاح معتمدة. لم يُجرَ أي تعديل آخر على القرارات السابقة.

الإضافات المعتمدة – النقاط 55 إلى 62

55. معنى 7 مرات يوميًا داخل النظام

تكون الجرعة العلاجية المستهدفة خلال دورة التدريب 7 مرات تدريبية في اليوم، ويتضمن كل تدريب ما لا يقل عن 100 وحدة كلامية وفق المستوى.

يعرض النظام للمستفيد تقدمه اليومي بوضوح: عدد التدريبات المكتملة والمتبقي من الهدف اليومي.

لا يحول النظام عدم إكمال السبع مرات في يوم واحد إلى قرار رسوب أو إعادة تلقائية؛ بل يسجلها بوصفها بيانات التزام، بينما يبقى الانتقال محكومًا بالعينة والنتيجة ومراجعة الأخصائي.

56. تطبيق شرط الساعة بين التدريبات

بعد إكمال تدريب فعلي، يبدأ النظام فترة فاصلة مدتها الافتراضية ساعة واحدة على الأقل قبل احتساب التدريب التالي ضمن الجرعة اليومية.

يستطيع المستفيد خلال فترة الانتظار مراجعة المحتوى والنموذج والتدريبات السابقة المتاحة، لكن لا يحتسب النظام تدريبًا جديدًا ضمن الجرعة العلاجية قبل انتهاء الفاصل.

تكون مدة الفاصل قابلة للتحكم من إدارة النظام وفق البروتوكول العلاجي.

57. ما يحدث عند دخول يوم جديد

يحتفظ النظام بسجل مستقل لكل يوم داخل دورة التدريب، ويعرض عدد التدريبات المنجزة في ذلك اليوم.

عند بدء يوم جديد، يبدأ عداد الجرعة اليومية الجديدة، دون حذف أو تصفير السجل التاريخي للأيام السابقة.

لا تنتقل التدريبات غير المكتملة من يوم سابق تلقائيًا لُحُتسب ضمن اليوم الجديد، ولا يطلب النظام من المستفيد تعويضها آليًا إلا إذا نص البروتوكول لاحقًا على ذلك.

58. الحد الأدنى للتدريب قبل فتح العينة

لا تُفتح مرحلة تسجيل العينة العلاجية إلا بعد إكمال حد أدنى قدره 3 أيام من التدريب.

تبدأ الأيام الثلاثة من وقت بدء أول تدريب فعلي بعد مشاهدة النموذج، وفق القاعدة المعتمدة.

خلال هذه الأيام، تكون الجرعة العلاجية المستهدفة 7 مرات تدريبية يوميًا، وفي كل مرة ما لا يقل عن 100 وحدة كلامية، مع فاصل لا يقل عن ساعة بين التدريبات المحتسبة.

لا يكفي مرور 72 ساعة تقويميًا دون ممارسة التدريب لفتح العينة. يجب أن يكون المستفيد قد دخل فعليًا في دورة التدريب لمدة ثلاثة أيام.

بعد إكمال الحد الأدنى الزمني البالغ 3 أيام، تفتح مرحلة تسجيل العينة العلاجية الواحدة المتكاملة، وفق القواعد المعتمدة.

تبقى بيانات عدد التدريبات المنجزة والجرعة اليومية مؤشرات التزام مهمة، لكنها لا تتحول وحدها إلى حكم على جودة الأداء أو قرار نجاح؛ فجودة الأداء وقرار الانتقال يحددهما تقييم العينة ومراجعة الأخصائي.

التسلسل الحاكم: مشاهدة النموذج – بدء أول تدريب فعلي – ثلاثة أيام من التدريب – فتح العينة المتكاملة – تسجيل عينة مدتها 3 دقائق – التقييم الذاتي والتوقع – إرسالها للأخصائي.

59. إثبات إكمال تدريب الـ 100 وحدة

يعتبر التدريب مكتملاً من ناحية الجرعة بعد مرور المستفيد على ما لا يقل عن 100 وحدة تدريبية ضمن المسار المعتمد للمستوى.

لا يطلب النظام تسجيل الوحدات صوتيًا أو مرئيًا، ولا يدّعي التحقق آليًا من جودة نطق كل وحدة.

يسجل النظام إكمال المسار بوصفه مؤشر التزام فقط، وتبقى جودة الأداء محكومة بالعينة العلاجية.

60. إيقاف التدريب في المنتصف والعودة إليه

إذا خرج المستفيد قبل إكمال التدريب، يحفظ النظام موضعه وتقدمه، وتبقى المرة في حالة «غير مكتملة».

عند العودة، يستطيع استكمال التدريب نفسه من حيث توقف.

لا تبدأ فترة الساعة الفاصلة، ولا تحتسب المرة ضمن الجرعة اليومية، إلا بعد إكمال الحد الأدنى المعتمد لذلك التدريب.

61. منع فتح تدريبين متوازيين

لا يسمح النظام للمستفيد ببدء أكثر من تدريب فعلي نشط في الوقت نفسه.

إذا كان لديه تدريب غير مكتمل، يعرض عليه استكمالها قبل بدء تدريب جديد، ما لم توجد صلاحية إدارية استثنائية موثقة.

يمنع ذلك تضارب العدادات واحتساب الجرعة بصورة غير صحيحة.

62. ما يراه المستفيد أثناء دورة التدريب

تعرض واجهة المستفيد بصورة مبسطة: المستوى الحالي، والوقت المتبقي حتى استكمال الحد الأدنى الزمني، وهدف اليوم وهو 7 تدريبات، وعدد التدريبات المكتملة اليوم، وحالة الفاصل الزمني ووقت إتاحة التدريب التالي، وزر استكمال التدريب غير المكتمل عند وجوده، والوصول إلى النموذج والمحتوى المعرفي والمستويات السابقة المفتوحة للتحقق.

لا تعرض الواجهة مؤشرات معقدة قد توهي للمستفيد بأن عدد التدريبات وحده يعني النجاح العلاجي.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 جميعًا من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ. واعتمدت النقطة 58 بصيغتها المعدلة: الحد الأدنى قبل فتح العينة هو ثلاثة أيام من التدريب الفعلي تبدأ من أول تدريب بعد مشاهدة النموذج، ولا يكفي مرور 72 ساعة تقويمًا دون ممارسة. لم يُجرَ أي تعديل آخر على القرارات السابقة.

تصحيح معتمد وحاكم – استخدام مصطلح 72 ساعة

يُعتمد في جميع متطلبات البرنامج مصطلح «72 ساعة» بدلاً من «3 أيام» عند وصف الحد الأدنى الزمني لدورة التدريب.

تبدأ مدة الـ 72 ساعة من لحظة بدء أول تدريب فعلي بعد مشاهدة النموذج العلاجي، ولا تبدأ بمجرد فتح المستوى أو مشاهدة التعليمات أو المحتوى المعرفي.

لا يكفي مرور 72 ساعة تقويمياً دون ممارسة التدريب. يجب أن يكون المستفيد قد دخل فعلياً في دورة التدريب خلال هذه المدة، وفق الجرعة العلاجية المستهدفة: 7 مرات تدريبية يومية، وفي كل مرة ما لا يقل عن 100 وحدة كلامية، مع فاصل لا يقل عن ساعة بين التدريبات المحتسبة.

بعد استكمال الحد الأدنى البالغ 72 ساعة وفق القواعد المعتمدة، تفتح مرحلة تسجيل العينة العلاجية الواحدة المتكاملة ومدتها الإجمالية 3 دقائق.

القاعدة الحاكمة: مشاهدة النموذج ← بدء أول تدريب فعلي ← 72 ساعة من دورة التدريب ← فتح العينة المتكاملة
← تسجيل عينة مدتها 3 دقائق ← التقييم الذاتي والتوقع ← إرسالها للأخصائي.

حالة التصحيح

يلغي هذا التصحيح استخدام عبارة «3 أيام» في النقطة 58 وفي أي موضع آخر يقصد به الحد الأدنى الزمني لدورة التدريب، ويستبدلها بعبارة «72 ساعة». ولا يغير هذا التصحيح بقية القواعد العلاجية المعتمدة.

الإضافات المعتمدة – النقاط 63 إلى 71

63. الاستشارة المجانية الواحدة أثناء البرنامج

يحق للمستفيد طلب استشارة واحدة مجانية مع الأخصائي أثناء تطبيق البرنامج العلاجي.

تظهر الاستشارة المجانية في حساب المستفيد بوصفها رصيدًا واحدًا متاحًا للاستخدام أثناء البرنامج، ولا تتجدد تلقائيًا عند الانتقال من مستوى إلى آخر أو عند إعادة المستوى أو تكرار دورة الـ 72 ساعة.

بعد استخدام الاستشارة المجانية، تخضع أي استشارة إضافية للقواعد والأسعار التي تحددها الإدارة.

64. عدم الخلط بين مراجعة العينة والاستشارة المجانية

لا تُحتسب مراجعة الأخصائي للعينة العلاجية، أو قرار الانتقال أو إعادة، أو التغذية الراجعة المرتبطة بالعينة، من رصيد الاستشارة المجانية.

الاستشارة المجانية خدمة مستقلة يطلبها المستفيد عند حاجته إلى مناقشة مشكلة أو استفسار أو صعوبة علاجية تتجاوز المراجعة المعتادة للعينة.

65. طريقة طلب الاستشارة المجانية

يتيح النظام للمستفيد زرًا واضحًا لطلب الاستشارة، مع بيان أن لديه استشارة مجانية واحدة أثناء تطبيق البرنامج.

عند الطلب، يحدد المستفيد سبب الاستشارة من قائمة قابلة للإدارة، ويكتب وصفًا مختصرًا عند الحاجة.

تُرسل الطلبات إلى المسار التشغيلي المعتمد، وتظهر للمستفيد حالة الطلب: تم الطلب – جارٍ التنسيق – تم تحديد الموعد – مكتملة – ملغاة.

66. قنوات الاستشارة والتواصل مع الأخصائي

يدعم النظام ثلاث قنوات للتواصل المهني بين المستفيد والأخصائي:

1. اللقاء المرئي المباشر عن بُعد: وهو الشكل الأساسي للاستشارة المجانية الواحدة والاستشارات المدفوعة الإضافية. يكون بموعد محدد، مع عرض التاريخ والوقت والمدة وزر آمن للدخول إلى اللقاء.

2. الاستشارة الصوتية: يتيح النظام التواصل الصوتي مع الأخصائي وفق القواعد والمواعيد والصلاحيات التي تحددها الإدارة.

3. الرسائل: يتيح النظام إرسال واستقبال الرسائل بين المستفيد والأخصائي داخل المنصة، وفق ضوابط الاستخدام وأوقات الاستجابة التي تحددها الإدارة.

يفصل النظام تقنيًا بين هذه القنوات، ولا يفترض أن الرسالة أو التواصل الصوتي يستهلك تلقائيًا الاستشارة المجانية المرئية.

تحدد الإدارة لكل قناة ما إذا كانت مشمولة ضمن البرنامج أو مجانية أو مدفوعة، وعدد مرات استخدامها ومدتها وسعرها وأوقات الإناحة وقواعد التصعيد.

تُوثق اللقاءات المرئية والاستشارات الصوتية والرسائل ذات الأهمية العلاجية في السجل السريري، مع الفصل بين الملاحظات الداخلية وما يظهر للمستفيد.

67. الاستشارات المدفوعة بعد استهلاك المجانية

بعد استخدام الاستشارة المجانية، يستطيع المستفيد طلب استشارات إضافية مدفوعة.

يعرض النظام السعر والمدة ونوع الاستشارة قبل تأكيد الطلب والدفع.

لا يخصم النظام أي مبلغ ولا يؤكد الحجز قبل إتمام خطوات الموافقة والدفع وفق نظام المدفوعات المعتمد.

تكون الأسعار والمدد والضرائب والعروض قابلة للإدارة دون تعديل الكود.

68. عدم استخدام الاستشارة لتجاوز قواعد المستويات

لا تؤدي الاستشارة المجانية أو المدفوعة بذاتها إلى فتح مستوى أو تجاوز دورة الـ 72 ساعة أو إلغاء متطلبات العينة. إذا نتج عن الاستشارة قرار سريري يؤثر في مسار العلاج، يجب أن يصدر القرار من المختص المخول، ويوثق في السجل السريري مع سببه وأثره.

لا يسمح النظام بتغيير المسار العلاجي بطريقة غير موثقة من خلال المحادثة أو الموعد فقط.

69. توثيق الاستشارة في السجل السريري

بعد إتمام الاستشارة، ينشئ النظام سجلاً يتضمن: التاريخ والوقت، ونوع الاستشارة، والمختص، وسبب الطلب، وملخص ما نوقش، والتوصيات، وأي خطوة تالية.

يفصل النظام بين الملاحظات السريرية الداخلية والملخص الذي يظهر للمستفيد.

تحفظ الاستشارة ضمن الخط الزمني السريري للمستفيد ولا تستبدل أي سجل سابق.

70. الإلغاء وعدم الحضور وإعادة الجدولة

تتيح الإدارة تحديد قواعد إلغاء الاستشارة وإعادة جدولتها وعدم الحضور.

لا تثبت هذه القواعد داخل الكود، بل تكون قابلة للضبط بحسب نوع الاستشارة المجانية أو المدفوعة.

يسجل النظام حالات الموعد وتاريخ التغييرات، ولا يعتبر الاستشارة المجانية مستخدمة تلقائيًا عند الإلغاء إلا وفق السياسة التي تعتمدها الإدارة.

71. مدة صلاحية الاستشارة المجانية

يحق للمستفيد استشارة واحدة مجانية فقط أثناء تطبيق البرنامج العلاجي.

تكون الاستشارة المجانية متاحة من وقت بدء البرنامج العلاجي وحتى انتهاء تطبيقه، ويمكن للمستفيد استخدامها في الوقت الذي يراه مناسبًا خلال هذه الفترة.

لا تتجدد الاستشارة المجانية عند الانتقال بين المستويات، أو عند إعادة المستوى، أو عند تكرار دورة الـ 72 ساعة.

تنتهي صلاحية الاستشارة المجانية بانتهاء تطبيق البرنامج إذا لم يستخدمها المستفيد، ولا تتحول إلى رصيد لاحق ولا تمتد تلقائيًا إلى مرحلة المتابعة بعد انتهاء البرنامج.

لا تُحتسب مراجعة العينات العلاجية، أو التغذية الراجعة، أو قرارات الانتقال وإعادة المستوى ضمن هذه الاستشارة المجانية.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 63 إلى 71 جميعًا من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ. القاعدة الحاكمة: للمستفيد استشارة واحدة مجانية أثناء تطبيق البرنامج؛ الشكل الأساسي لها لقاء مرئي مباشر عن بُعد، مع إتاحة الاستشارة الصوتية والرسائل داخل النظام وفق القواعد التي تحددها الإدارة. تنتهي صلاحية الاستشارة المجانية بانتهاء تطبيق البرنامج إذا لم يُستخدم، ولا تُحتسب مراجعة العينات أو التغذية الراجعة أو قرارات الانتقال وإعادة منها.

الإضافات المعتمدة – النقاط 72 إلى 80

72. الفصل بين الرسائل والاستشارة

يفصل النظام بين ثلاث خدمات مستقلة: اللقاء المرئي، والاستشارة الصوتية، والرسائل لا تتحول الرسالة تلقائيًا إلى استشارة، ولا تُخصم من الاستشارة المجانية الواحدة. وإذا رأى الأخصائي أن موضوع الرسالة يحتاج مناقشة سريرية موسعة، يستطيع توجيه المستفيد إلى طلب استشارة مرئية أو صوتية وفق القواعد المعتمدة.

73. نطاق استخدام الرسائل

تستخدم الرسائل للاستفسارات المختصرة المتعلقة بتطبيق البرنامج، مثل فهم التعليمات، أو صعوبة الوصول إلى محتوى، أو استفسار قصير عن التدريب لا تستخدم الرسائل بديلًا عن مراجعة العينة الرسمية، ولا يصدر من خلالها قرار انتقال أو إعادة مستوى بصورة غير موثقة. وإذا تضمنت الرسالة معلومة علاجية مهمة، يستطيع الأخصائي تحويلها إلى ملاحظة موثقة في السجل السريري.

74. عدم اشتراط الرد الفوري على الرسائل

يوضح النظام للمستفيد أن الرسائل ليست قناة استجابة فورية. تحدد الإدارة وقت الاستجابة المتوقع، وأيام العمل، وحالة توفر الخدمة، ويظهر ذلك للمستفيد قبل إرسال الرسالة لا يعرض النظام للأخصائي أو للمستفيد وعدًا زمنيًا ثابتًا غير معتمد من الإدارة.

75. من يجب عن الرسائل

تُوجّه الرسائل العلاجية افتراضيًا إلى الأخصائي المسؤول عن الحالة. ويمكن للإدارة السماح لفريق دعم غير سريري بالرد على المشكلات التقنية والإدارية فقط لا يجب المستخدم غير السريري عن الأسئلة العلاجية، ولا يطلع على معلومات سريرية أكثر مما تسمح به صلاحياته.

76. الاستشارة الصوتية

تكون الاستشارة الصوتية خدمة مستقلة يمكن حجزها وفق المواعيد والمدد والأسعار والقواعد التي تحددها الإدارة لا تعتبر المكالمات الصوتية بديلًا تلقائيًا عن الاستشارة المجانية المرئية، ولا تخصص منها إلا إذا قررت الإدارة صراحة السماح للمستفيد باختيار نوع الاستشارة المجانية. توثق الاستشارة الصوتية في السجل السريري وفق القواعد المعتمدة.

77. الملفات المرفقة في الرسائل

يمكن للنظام دعم المرفقات المسموح بها وفق سياسة الإدارة، مثل الصور أو المستندات ذات الصلة لا تُرسل العينات العلاجية الرسمية من خلال الرسائل؛ بل تستخدم مسار العينة المعتمد. تخضع الملفات للفحص الأمني، وحدود الحجم والنوع، وصلاحيات الوصول والحفظ.

78. عدم استخدام الرسائل لإرسال عينات بديلة

لا يسمح النظام باعتبار تسجيل صوتي أو مرئي مرسل عبر الرسائل عينة علاجية رسمية للانتقال بين المستويات. العينة الرسمية يجب أن تسجل وترسل من خلال مسار العينة المتكاملة المعتمد، حتى ترتبط بالمستوى ودورة الـ 72 ساعة والتقييم الذاتي وتوقع العينة القادمة ومراجعة الأخصائي.

79. إغلاق المحادثات وأرشفتها

يحفظ النظام بسجل المحادثات وفق سياسة الحفظ المعتمدة، ويتيح إغلاق المحادثة عند انتهاء موضوعها. إغلاق المحادثة لا يحذفها ولا يغير السجل التاريخي. يمكن للمستفيد بدء موضوع جديد عند الحاجة وفق قواعد الخدمة، وتظهر المحادثات السابقة للمستخدمين المخولين فقط.

80. الحالات العاجلة أو غير المناسبة للرسائل

تظهر للمستفيد رسالة واضحة بأن الرسائل والاستشارات داخل المنصة ليست مخصصة للحالات الطارئة أو العاجلة. إذا اختار المستفيد موضوعًا يدل على مشكلة عاجلة، يعرض النظام التوجيه المعتمد من الإدارة بدل الاكتفاء بإرسال رسالة عادية وانتظار الرد. لا يحاول الذكاء الاصطناعي إصدار تشخيص أو قرار طارئ مستقل.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 72 إلى 80 جميعًا من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ. وتشمل الموافقة النقطة 76 بصيغتها المعروضة: الاستشارة الصوتية خدمة مستقلة، ولا تعد بديلًا تلقائيًا عن الاستشارة المجانية المرئية ولا تخصم منها إلا إذا قررت الإدارة صراحة السماح باختيار نوع الاستشارة المجانية. لم يُجرَ أي تعديل آخر على القرارات السابقة.

تصحيح معتمد وحاكم – نوع الاستشارة المجانية

القاعدة المصححة

يحق للمستفيد استشارة واحدة مجانية أثناء تطبيق البرنامج العلاجي، ويختار المستفيد أو ولي أمره نوعها وفق رغبته: لقاء مرئي مباشر عن بُعد أو استشارة صوتية.

تصحيح النقطة 66 – قنوات الاستشارة والتواصل

تُتاح الاستشارة المجانية الواحدة في أحد شكلين بديلين: لقاء مرئي مباشر عن بُعد أو استشارة صوتية. ويكون اختيار نوع الاستشارة للمستفيد أو ولي أمره.

استخدام أحد النوعين يستهلك رصيد الاستشارة المجانية الواحدة، ولا يحق للمستفيد الحصول على استشارة مجانية مرئية وأخرى صوتية ضمن الرصيد نفسه.

تبقى الرسائل قناة تواصل مستقلة، ولا تُحتسب تلقائيًا من رصيد الاستشارة المجانية.

تصحيح النقطة 76 – الاستشارة الصوتية

الاستشارة الصوتية بديل كامل عن الاستشارة المجانية المرئية، ويختار المستفيد أو ولي أمره بين الاستشارة المرئية والاستشارة الصوتية وفق رغبته.

تخضع الاستشارة المختارة للمواعيد والمدد وقواعد الحجز والإلغاء وإعادة الجدولة والتوثيق المعتمدة.

بعد استخدام الاستشارة المجانية، تكون أي استشارات إضافية مرئية أو صوتية خاضعة للقواعد والأسعار التي تحددها الإدارة.

حالة التصحيح

يلغي هذا التصحيح أي صياغة سابقة تنص على أن الاستشارة الصوتية ليست بديلًا عن الاستشارة المجانية المرئية، أو أنها لا تخصم من رصيدها. القاعدة الحاكمة هي: استشارة مجانية واحدة أثناء تطبيق البرنامج، يختار المستفيد أو ولي أمره أن تكون مرئية أو صوتية. لم يُجرَ أي تعديل آخر على القرارات المعتمدة.

الإضافات المعتمدة – النقاط 81 إلى 89

81. تحديد صاحب الحساب والمستفيد الفعلي

يفرق النظام بين صاحب الحساب والمستفيد من البرنامج العلاجي. في حالة البالغ القادر على إدارة حسابه، يمكن أن يكون الشخص نفسه صاحب الحساب والمستفيد. وفي حالة الطفل أو من يحتاج إلى إشراف ولي أمر، يكون ولي الأمر صاحب الصلاحية الإدارية على الحساب، بينما يحتفظ المستفيد بملف علاجي مستقل وسجل سريري مستقل.

82. حساب ولي الأمر وإدارة أكثر من مستفيد

يستطيع ولي الأمر، عند الحاجة، إدارة أكثر من مستفيد من حساب واحد، مع وجود ملف مستقل تمامًا لكل مستفيد. لا تختلط المستويات أو العينات أو الاختبارات أو الرسائل أو المواعيد أو المدفوعات أو التقارير بين المستفيدين. ويجب أن يظهر اسم المستفيد الحالي بوضوح في جميع الشاشات الحساسة لتقليل احتمال تنفيذ إجراء على الملف الخطأ.

83. من ينفذ التدريب فعليًا

التدريب العلاجي والعينة الكلامية يخصان المستفيد نفسه، حتى إذا كان ولي الأمر هو من يدير الحساب أو يساعد في تشغيل النظام. يجوز لولي الأمر مساعدة الطفل في الدخول، وفهم التعليمات، وتشغيل النموذج، وتنظيم مواعيد التدريب، لكنه لا ينفذ المهمة الكلامية أو العينة بدلًا عن المستفيد. تعرض التعليمات بوضوح من المطلوب منه أداء كل خطوة: المستفيد أو ولي الأمر أو كلاهما.

84. دور ولي الأمر أثناء التدريب

يستطيع البرنامج، بحسب العمر والمستوى، تقديم تعليمات خاصة لولي الأمر حول كيفية مساعدة المستفيد دون التدخل بطريقة تفسد الهدف العلاجي. تكون تعليمات ولي الأمر منفصلة بصريًا عن تعليمات المستفيد، وقابلة للإدارة من لوحة المحتوى. ولا يفترض النظام أن جميع الأطفال يحتاجون الدرجة نفسها من مساعدة ولي الأمر.

85. التقييم الذاتي في حالة الطفل

يكون التقييم الذاتي وتوقع العينة القادمة موجّهين إلى المستفيد متى كانت قدرته العمرية والمعرفية تسمح بذلك. ويتيح النظام، وفق قالب المرحلة العمرية، أن تكون الإجابة من المستفيد نفسه، أو ولي الأمر، أو المستفيد وولي الأمر بصورة منفصلة. يجب أن يحفظ النظام بوضوح هوية من قدّم كل تقييم، ولا يدمج تقييم ولي الأمر مع تقييم المستفيد على أنهما مصدر واحد.

86. من يطلب الاستشارة المجانية

يمكن طلب الاستشارة المجانية من المستفيد البالغ أو من ولي أمر المستفيد القاصر. ويختار المستفيد أو ولي أمره أن تكون الاستشارة مرئية أو صوتية وفق القاعدة المعتمدة. يحدد النظام بوضوح من طلب الاستشارة ومن حضرها، ويمكن أن يحضر المستفيد وولي الأمر معًا إذا كان ذلك مناسبًا للحالة.

87. الرسائل في حساب الطفل

تكون الرسائل العلاجية الخاصة بالمستفيد القاصر خاضعة لنموذج الصلاحيات الذي تعتمده الإدارة. افتراضيًا، يدير ولي الأمر الرسائل المتعلقة بالبرنامج، مع إمكانية تصميم تجربة مناسبة للمستفيد الأكبر سنًا وفق العمر والسياسة المعتمدة. يسجل النظام هوية مرسل كل رسالة، ولا ينسب رسالة ولي الأمر إلى الطفل.

88. الموافقات والقبول في حالة القاصر

تُحفظ موافقة ولي الأمر أو الممثل النظامي على الاشتراك والعلاج واستخدام المنصة وفق المتطلبات المعتمدة. وتفصل المنصة بين الموافقات الضرورية لتقديم الخدمة والموافقات الاختيارية، مثل البحث أو تطوير النظام، وفق القاعدة المعتمدة سابقًا. يسجل النظام نسخة نص الموافقة التي تم قبولها وتاريخها وهوية من وافق عليها.

89. انتقال المستفيد من إدارة ولي الأمر إلى إدارة حسابه بنفسه

يدعم النظام مستقبلاً نقل صلاحية إدارة الحساب إلى المستفيد نفسه عندما يصبح مؤهلاً لذلك، وفق القواعد النظامية والتشغيلية المعتمدة. لا يؤدي انتقال الصلاحية إلى إنشاء سجل علاجي جديد أو فقد التاريخ السابق. تحفظ المنصة أثر عملية نقل الصلاحية وتاريخها والأطراف المرتبطة بها.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 81 إلى 89 جميعاً من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ، بما في ذلك النقطة 85 بصيغتها المعروضة: يمكن أن يكون التقييم من المستفيد أو ولي الأمر أو كليهما بصورة منفصلة وفق العمر والقدرة، مع حفظ هوية مصدر كل تقييم وعدم دمج المصدرين. لم يُجرَ أي تعديل آخر على القرارات السابقة.

الإضافات المعتمدة – النقاط 90 إلى 98

90. متى يُعد المستفيد قد أكمل البرنامج؟

لا يُعد البرنامج مكتملاً بمجرد إنهاء آخر محتوى أو مرور مدة زمنية معينة. تتحقق حالة «أكمل البرنامج العلاجي» بعد اجتياز آخر مستوى وفق البروتوكول، واعتماد الأخصائي النتيجة النهائية، وإكمال المتطلبات الختامية المحددة للبرنامج. يحفظ النظام تاريخ الإكمال، وآخر مستوى، وقرار الأخصائي، والنتائج النهائية.

91. القياسات الختامية بعد العلاج

عند الوصول إلى نهاية البرنامج، يفتح النظام القياسات والاختبارات الختامية المحددة في البروتوكول، بما يسمح بمقارنة النتائج قبل العلاج وبعده. يعرض النظام نتائج الاختبارات المنظمة، مثل OASES والرضا الكلامي، والبيانات المستخلصة من SSI-4، إلى جانب المؤشرات العلاجية والعينات ذات الصلة لا يغيّر النظام الاختبارات أو يضيف مقياسًا من عنده؛ بل تكون البطارية الختامية وفق البروتوكول المعتمد.

92. المقارنة الآلية بين خط الأساس والنتائج النهائية

ينشئ النظام مقارنة منظمة بين نتائج ما قبل العلاج ونتائج ما بعد العلاج، ويعرض مقدار التغير لكل مقياس أو مؤشر متاح. يجوز للذكاء الاصطناعي تلخيص اتجاهات التحسن وإعداد مسودة تفسيرية، لكنه لا يعلن «الشفاء» أو «نجاح العلاج» بصورة مستقلة. يعتمد الأخصائي التفسير والنتيجة السريرية النهائية.

93. التقرير العلاجي النهائي الآلي

بعد اكتمال البيانات النهائية، ينشئ النظام مسودة تقرير علاجي نهائي آلي اعتمادًا على التاريخ المرضي والمقابلة والاختبارات الأولية والنهائية ومسار المستفيد داخل البرنامج والعينات والقرارات السريرية. تعرض المسودة للأخصائي للمراجعة والتعديل والاعتماد. ولا يصح التقرير نهائيًا ولا يظهر للمستفيد قبل اعتماد المختص المخول. يحتفظ النظام بنسخة المسودة والنسخة النهائية المعتمدة وسجل التعديلات.

94. عدم إعلان النتيجة من اختبار واحد

لا يبنى النظام النتيجة النهائية على درجة SSI-4 أو OASES أو الرضا الكلامي أو أي مقياس منفرد. تعرض النتيجة بوصفها حصيلة متكاملة تشمل القياسات الموضوعية، وتجربة المستفيد، والعينات الكلامية، والمسار العلاجي، والحكم السريري للأخصائي لا يثبت المبرمج معادلة نهائية للنجاح أو الشفاء دون اعتماد سريري صريح من مالك البرنامج.

95. خطة ما بعد إنهاء البرنامج

بعد اعتماد إكمال البرنامج، ينتقل المستفيد إلى مرحلة ما بعد العلاج وفق البروتوكول الأصلي الموجود في الوثيقة. تعرض له التعليمات والمواد والمهام المقررة للمحافظة على النتائج والتعامل مع التحديات اللاحقة لا يختار المبرمج برنامج متابعة جديدًا، بل ينفذ محتوى المتابعة وقواعدها كما يعتمدها مالك البرنامج.

96. ظهور بوادر تراجع أو انتكاس

إذا ظهرت لدى المستفيد بوادر تراجع بعد إنهاء البرنامج، يتيح النظام المسار المعتمد للإبلاغ عنها وتقييمها لا يعيد النظام المستفيد تلقائيًا إلى مستوى سابق ولا يبدأ العلاج من جديد بقرار آلي. تُراجع الحالة وفق البروتوكول، ويصدر القرار من المختص المخول، مع توثيق سبب القرار والمسار التالي.

97. الوصول إلى التدريبات السابقة بعد إنهاء البرنامج

خلال تطبيق البرنامج، يستطيع المستفيد الرجوع إلى التدريبات السابقة للتقوية والتدريب الحر وفق القاعدة المعتمدة. أما بعد إنهاء البرنامج، فتحدد الإدارة مدة ونطاق استمرار الوصول إلى المحتوى السابق وفق نموذج الاشتراك والمتابعة لا يؤدي الرجوع إلى المحتوى السابق إلى تغيير حالة المستوى أو إنشاء دورة 72 ساعة جديدة أو فتح عينة رسمية إلا من خلال مسار علاجي معتمد.

98. العودة بعد الانقطاع الطويل أثناء البرنامج

إذا انقطع المستفيد، يبقى البرنامج مفتوحًا حتى المرحلة التي وصل إليها لمدة شهر وفق الإعدادات المعتمدة، مع تطبيق مهلة اليومين والتذكيرات حسب القواعد السابقة. بعد تحقق «الانقطاع الطويل» وفق المدة التي يحددها مدير النظام، لا يستأنف المستفيد من المستوى الذي توقف عنده؛ بل يبدأ البرنامج من جديد من المستوى الأول. يحتفظ النظام بالسجل السابق كاملاً، لكنه ينشئ مسارًا علاجيًا جديدًا مستقلًا. ويظل تعريف الانقطاع الطويل وقواعد الاستثناء خاضعًا لتحكم مدير النظام.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 90 إلى 98 جميعًا من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ دون تعديل أي قرار سابق. وتشمل هذه الدفعة قواعد إكمال البرنامج، والقياسات الختامية، والمقارنة قبل العلاج وبعده، والتقارير العلاجي النهائي، وخطة ما بعد العلاج، والتعامل مع التراجع أو الانتكاس، والوصول إلى التدريبات السابقة، والعودة بعد الانقطاع الطويل.

الإضافات المعتمدة – النقاط 99 إلى 107

99. محرك إشعارات مركزي قابل للإدارة

يجب ألا تكون رسائل التذكير ومواعيدها مثبتة داخل الكود. يدعم النظام محرك إشعارات مركزيًا تستطيع الإدارة من خلاله تحديد نوع الحدث، والمستلم، والقناة، وتوقيت الإرسال، وعدد مرات التكرار، ووقت التوقف. تحفظ المنصة سجلًا لكل إشعار: سبب الإرسال، ووقته، وقناته، وحالة التسليم والفتح عند توفرها.

100. تذكيرات التدريب اليومي

أثناء دورة الـ 72 ساعة، يرسل النظام تذكيرات تساعد المستفيد على الوصول إلى الجرعة المستهدفة: 7 تدريبات يوميًا، مع مراعاة الفاصل الزمني المعتمد لا يرسل النظام تذكيرًا لبدء تدريب جديد قبل أن يصبح التدريب التالي متاحًا، ولا يستمر في تذكير المستفيد بتدريب اكتمل بالفعل. تكون أوقات التذكير وعددها قابلة للضبط، مع تجنب الإزعاج أو التكرار المفرط.

101. إشعار فتح مرحلة العينة

عند استكمال متطلبات دورة الـ 72 ساعة وفتح مرحلة العينة، يرسل النظام إشعارًا واضحًا بأن المستفيد أصبح جاهزًا لتسجيل العينة العلاجية المتكاملة. يوضح الإشعار أن العينة واحدة، مدتها الإجمالية 3 دقائق، وتتكون من الأجزاء المحددة للمستوى لا يرسل النظام هذا الإشعار قبل تحقق شروط فتح العينة.

102. مهلة اليومين بعد استحقاق العينة

إذا لم يرسل المستفيد العينة بعد فتح مرحلة التسجيل، يمنحه النظام مهلة إضافية مقدارها يومان. خلال هذه المهلة تبقى مرحلة التسجيل مفتوحة، وترسل التذكيرات وفق القواعد التي تحددها الإدارة. بعد انتهاء اليومين دون إرسال، ينتقل النظام إلى حالة «تأخر في إرسال العينة» ويطبق مسار التذكير والمتابعة المعتمد، دون إصدار قرار علاجي آلي.

103. إشعار الأخصائي بوصول العينة

عند إرسال العينة العلاجية رسميًا، يرسل النظام إشعارًا إلى الأخصائي الوحيد المسند إليه فحص العينة. تظهر العينة في قائمة عمله بحالتها وتاريخ وصولها ومدة الانتظار لا ترسل العينة نفسها إلى أكثر من أخصائي للمراجعة المتوازية، تطبيقًا للقرار المعتمد بأن العينة يفحصها أخصائي واحد فقط.

104. التذكير بالأعمال المتأخرة لدى الأخصائي

إذا بقيت عينة أو تقرير أو مهمة سريرية دون مراجعة خلال المدة التشغيلية التي تحددها الإدارة، يرسل النظام تذكيرًا إلى الأخصائي. إذا تجاوز التأخير حدًا آخر تحدده الإدارة، يمكن تصعيد الحالة إلى المشرف أو مدير النظام دون نقل المسؤولية السريرية تلقائيًا إلى أخصائي آخر. أي إعادة إسناد تتم بإجراء رسمي موثق.

105. إشعار المستفيد بصدور القرار

عند اعتماد الأخصائي قرار الانتقال أو إعادة المستوى أو إعادة تسجيل العينة لأسباب تقنية، يتلقى المستفيد إشعارًا مناسبًا لا يكشف الإشعار الخارجي معلومات سريرية حساسة؛ بل يوجه المستفيد إلى الدخول الآمن للمنصة لقراءة النتيجة والتغذية الراجعة والخطوة التالية. يسجل النظام وقت فتح القرار والاطلاع عليه وفق القاعدة المعتمدة سابقًا.

106. تذكيرات المواعيد والاستشارات

يرسل النظام تذكيرات بالاستشارة المجانية أو المدفوعة، سواء اختار المستفيد أو ولي أمره لقاءً مرئيًا أو صوتيًا. تحدد الإدارة توقيتات التذكير وقنواته، ويُلغى التذكير أو يتغير تلقائيًا عند إلغاء الموعد أو إعادة جدولته لا ترسل تذكيرات لموعد لم يعد قائمًا.

107. تفضيلات الإشعارات وعدم تعطيل التنبيهات الحرجة

يستطيع المستفيد ضبط بعض تفضيلات الإشعارات غير الحرجة وقنواتها وفق ما تسمح به الإدارة. أما الإشعارات الأساسية المرتبطة بقرار سريري، أو موعد مؤكد، أو إجراء مطلوب لاستمرار البرنامج، فلا تُعامل كرسائل تسويقية

ولا تختفي بسبب إلغاء الاشتراك في الرسائل الترويجية. يفصل النظام بين الإشعارات العلاجية والتشغيلية والتسويقية.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 99 إلى 107 جميعًا من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ دون تعديل أي قرار سابق. وتشمل هذه الدفعة محرك الإشعارات المركزي، وتذكيرات التدريب، وفتح مرحلة العينة، ومهلة اليومين، وإشعار الأخصائي بوصول العينة، وتصعيد الأعمال المتأخرة، وإشعار المستفيد بالقرار، وتذكيرات الاستشارات، والفصل بين الإشعارات العلاجية والتشغيلية والتسويقية.

تصحيح معتمد وحاكم – آلية فحص العينة العلاجية

القاعدة الحاكمة

لا تُسند العينة مسبقًا إلى أخصائي محدد. تكون العينة متاحة للأخصائيين المؤهلين والمخولين، ويقوم بفحصها أخصائي واحد فقط. عند بدء أول أخصائي المراجعة الفعلية، تُحجز العينة له ويُمنع أي أخصائي آخر من فحصها أو تقييمها في الوقت نفسه.

تهدف هذه القاعدة إلى حفظ حقوق الأخصائي، وضمان الجودة، ومنع ازدواجية العمل أو تضارب القرارات، وضبط المستحقات المالية المرتبطة بفحص العينة.

تصحيح النقطة 103 – إشعار الأخصائيين ووصول العينة

عند إرسال العينة العلاجية رسميًا، تدخل في قائمة العينات المتاحة للمراجعة، وتظهر للأخصائيين المؤهلين والمخولين وفق قواعد النظام.

لا تُسند العينة مسبقًا إلى أخصائي بعينه، ولا يشترط أن يكون فاحصها هو الأخصائي الذي راجع عينات المستفيد السابقة.

عند بدء أول أخصائي المراجعة الفعلية، تختفي العينة من قائمة العينات المتاحة، أو تظهر لبقية الأخصائيين بوصفها غير متاحة، وتُقفّل للمراجع الأول وحده.

113. إتاحة العينة لأخصائي واحد بنظام من يبدأ المراجعة يملكها

بعد إرسال المستفيد للعينة العلاجية، تدخل العينة في قائمة العينات المتاحة للمراجعة، ويستطيع أي أخصائي مؤهل ومخول في النظام البدء في مراجعتها.

عند قيام أول أخصائي بفتح العينة لبدء المراجعة الفعلية، يحجزها النظام له ويمنع أي أخصائي آخر من فحصها أو تقييمها في الوقت نفسه.

تصبح العينة بعد ذلك في حالة «قيد المراجعة لدى أخصائي واحد».

يسجل النظام هوية الأخصائي الذي حجز العينة، ووقت بدء المراجعة، ووقت إكمالها، والقرار الصادر عنها، والمستحق المالي المرتبط بها عند تطبيق النموذج المالي.

لا يستطيع أخصائي ثانٍ إصدار تقييم أو قرار على العينة ما دامت محجوزة للأخصائي الأول.

تصحيح النقطة 114 – عدم إكمال الأخصائي للمراجعة

إذا حجز الأخصائي العينة ثم لم يكمل مراجعتها خلال المدة التشغيلية التي تحددها الإدارة، لا تبقى العينة محتجزة إلى أجل غير محدد.

تطبق قواعد إدارية لإلغاء الحجز وإعادة العينة إلى قائمة العينات المتاحة للمراجعة.

يحفظ النظام اسم الأخصائي السابق، ووقت بدء الحجز، ومدته، والمسودة إن وجدت، وسبب إلغاء الحجز وإعادة الإثارة.

لا تتحول المسودة السابقة إلى قرار سريري، ولا يعتمد عليها الأخصائي الجديد تلقائيًا. يصدر القرار النهائي باسم الأخصائي الذي أكمل المراجعة واعتمدها.

حالة الاعتماد

تم اعتماد هذه التعديلات من مالك البرنامج. وهي تلغي أي صياغة سابقة تفترض إسناد العينة مسبقًا إلى أخصائي محدد. القاعدة النهائية: العينة متاحة لأي أخصائي مؤهل، لكن لا يفحصها ولا يعتمد عليها إلا أخصائي واحد؛ ومن يبدأ المراجعة الفعلية تُحجز له العينة، مع توثيق الحقوق والجودة والمستحقات المالية. لم يتم اعتماد بقية النقاط 108 إلى 116 ضمن هذا التصحيح.

الإضافات المعتمدة - النقاط 108 إلى 116

108. الأدوار والصلاحيات داخل النظام

يعتمد النظام صلاحيات قائمة على الأدوار، ولا يحصل جميع المستخدمين الإداريين أو السريريين على الصلاحيات نفسها. تشمل الأدوار الأساسية، مع قابلية التوسع: المستفيد، ولي الأمر، الأخصائي، المشرف السريري، الدعم الفني أو الإداري، مدير النظام، ومالك المحتوى العلاجي. تحدد الصلاحيات ما يستطيع كل دور مشاهدته أو إنشاؤه أو تعديله أو اعتماده، وفق مبدأ أقل قدر ضروري من الوصول.

109. الفصل بين الصلاحية الإدارية والقرار السريري

لا يمنح كون المستخدم مديرًا للنظام صلاحية إصدار قرار سريري تلقائيًا. يفصل النظام بين إدارة الحسابات والمحتوى والإعدادات من جهة، وبين مراجعة العينات واعتماد الانتقال وإعادة المستوى والتقارير السريية من جهة أخرى. لا ينفذ القرار السريري إلا مستخدم يملك الصلاحية المهنية المعتمدة.

110. الاستثناءات الإدارية لا تمحو القاعدة الأصلية

يستطيع المستخدم المخول تنفيذ استثناءات محددة عندما توجد حاجة تشغيلية أو سريرية معتمدة، مثل تمديد الوصول، أو إعادة فتح إجراء، أو إعادة إسناد مهمة. لا يغير الاستثناء القاعدة العامة للنظام، ولا يطبق على الحالات الأخرى تلقائيًا. يجب تسجيل من نفذ الاستثناء، ومتى، وعلى أي حالة، وما السبب، وما القيمة السابقة والجديدة.

111. التعديلات الحساسة تحتاج سببًا إلزاميًا

عند تنفيذ تعديل حساس يؤثر في المسار العلاجي أو السجل السريري أو الوصول إلى البرنامج، يطلب النظام سببًا إلزاميًا قبل الحفظ. تشمل الأمثلة: إعادة فتح عينة بعد الإرسال، تمديد مدة الوصول، تغيير الأخصائي المسؤول عند وجود مسؤولية محددة، إعادة فتح مستوى، تجاوز قفل، أو تصحيح سجل سريري. لا يسمح بحذف أثر التعديل من سجل التدقيق.

112. عدم الحذف النهائي للسجلات السريية

لا تُحذف العينات أو التقييمات أو القرارات أو التقارير أو الاستشارات أو الملاحظات السريية حذفًا نهائيًا من خلال الاستخدام المعتاد للنظام. عند وجود خطأ، يتم التصحيح بطريقة تحفظ السجل الأصلي، والتعديل اللاحق، وهوية من عدّل، ووقت التعديل وسببه. أي معالجة استثنائية للبيانات تخضع للسياسات النظامية المعتمدة ولا تكون وظيفة حذف عادية للمستخدم.

113. إتاحة العينة لأخصائي واحد بنظام من يبدأ المراجعة يملكها

بعد إرسال المستفيد للعينة العلاجية، تدخل العينة في قائمة العينات المتاحة للمراجعة، ويستطيع أي أخصائي مؤهل ومخول في النظام البدء في مراجعتها. لا تُسند العينة مسبقًا إلى أخصائي بعينه. عند قيام أول أخصائي ببدء المراجعة الفعلية، يحجزها النظام له ويمنع أي أخصائي آخر من فحصها أو تقييمها في الوقت نفسه. تصبح العينة في حالة «قيد المراجعة لدى أخصائي واحد». يسجل النظام هوية الأخصائي، ووقت بدء المراجعة، ووقت إكمالها، والقرار الصادر عنها، والمستحق المالي المرتبط بها عند تطبيق النموذج المالي. تهدف القاعدة إلى حفظ الحقوق، وضمان الجودة، ومنع ازدواجية العمل أو تضارب القرارات، وضبط الجانب المالي.

114. عدم إكمال الأخصائي للمراجعة

إذا حجز الأخصائي العينة ثم لم يكمل مراجعتها خلال المدة التشغيلية التي تحددها الإدارة، لا تبقى العينة محتجزة إلى أجل غير محدد. تطبق قواعد إدارية لإلغاء الحجز وإعادة العينة إلى قائمة العينات المتاحة للمراجعة. يحفظ النظام اسم الأخصائي السابق، ووقت بدء الحجز، ومدته، والمسودة إن وجدت، وسبب إلغاء الحجز وإعادة الإتاحة. لا تتحول المسودة السابقة إلى قرار سريري، ولا يعتمد عليها الأخصائي الجديد تلقائيًا. يصدر القرار النهائي باسم الأخصائي الذي أكمل المراجعة واعتمدها.

115. تجميد إصدار المحتوى أثناء دورة الـ 72 ساعة

عند بدء أول تدريب فعلي وبدء دورة الـ 72 ساعة، يثبت النظام إصدار النموذج وقائمة التدريب والتعليمات والمعايير المرتبطة بتلك الدورة. إذا عدلت الإدارة المحتوى لاحقًا، لا يتغير محتوى الدورة الجارية بصورة صامتة. يطبق الإصدار الجديد على الدورات الجديدة وفق قواعد النشر، مع الاحتفاظ بمعرفة الإصدار الذي استخدمه كل مستفيد.

116. سجل تدقيق موحد للأحداث الحساسة

يحتفظ النظام بسجل تدقيق غير قابل للتلاعب للاستخدامات الحساسة، مثل الدخول إلى السجلات، وإرسال العينات، وفتحها، وحجزها، وتقييمها، وإصدار القرارات، وتعديل المحتوى، وتغيير الصلاحيات، وتنفيذ الاستثناءات، وإلغاء حجز العينة وإعادة إتاحتها. يسجل الحدث، والمستخدم، والتاريخ والوقت، والحالة أو السجل المتأثر، والبيانات السابقة والجديدة عند انطباق ذلك لا يظهر سجل التدقيق لجميع المستخدمين، بل للمخولين فقط وفق الصلاحيات والسياسات المعتمدة.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 108 إلى 116 جميعًا من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ. واعتمدت النقطتان 113 و114 بصيغتهما المصححة الأخيرة لا تُسند العينة مسبقًا إلى أخصائي محدد؛ تكون متاحة لأي أخصائي مؤهل، ويقوم بفحصها أخصائي واحد فقط، ومن يبدأ المراجعة الفعلية تُحجز له العينة. وإذا لم يكملها ضمن المدة التشغيلية، يمكن إلغاء الحجز وإعادتها إلى قائمة العينات المتاحة مع حفظ السجل الكامل. تلغي هذه الصياغة أي نص سابق متعارض.

117. حالات المستفيد داخل البرنامج

يعتمد النظام حالات واضحة للمستفيد، مثل: لم يبدأ، في المحتوى المعرفي، جاهز لبدء التدريب، في دورة الـ 72 ساعة، جاهز لتسجيل العينة، متأخر في إرسال العينة، العينة بانتظار المراجعة، العينة قيد المراجعة، بانتظار القرار، إعادة تسجيل لأسباب تقنية، إعادة المستوى، انتقل للمستوى التالي، منقطع مؤقتًا، مغلق بسبب الانقطاع، أكمل البرنامج. لا ينتج كل جزء من النظام حالة المستفيد بطريقته؛ بل توجد حالة مركزية تحكم ما يظهر له وما يستطيع فعله.

118. محرك انتقالات يمنع القفز غير المشروع بين الحالات

لا يسمح النظام بالانتقال بين الحالات إلا وفق انتقالات معتمدة. فلا يمكن مثلاً الانتقال من دورة الـ 72 ساعة مباشرة إلى المستوى التالي دون عينة وقرار أخصائي، ولا من «العينة قيد المراجعة» إلى «إعادة المستوى» دون قرار موثق. أي تجاوز استثنائي يتطلب صلاحية وسببًا ويسجل في سجل التدقيق.

119. منع الإجراءات المكررة بسبب الضغط أو ضعف الاتصال

يجب أن تكون العمليات الحساسة محمية من التكرار، مثل إرسال العينة، وحجزها للمراجعة، واعتماد القرار، والدفع، وحجز الموعد، واستخدام رصيد الاستشارة المجانية. إذا ضغط المستخدم الزر أكثر من مرة أو انقطع الاتصال وأعاد المحاولة، لا ينشئ النظام عينتين أو قرارين أو حزين أو عمليتي دفع.

120. التعامل مع انقطاع الإنترنت أثناء التدريب أو التسجيل

إذا انقطع الاتصال أثناء التدريب، يحفظ النظام التقدم الممكن استعادته ولا يحتسب التدريب مكتملاً قبل تحقق شروط الإكمال. وإذا انقطع الاتصال أثناء تسجيل العينة قبل الإرسال النهائي، لا تصل عينة ناقصة إلى الأخصائي بوصفها عينة رسمية. يعرض النظام حالة واضحة للمستفيد ويتيح الاستكمال أو إعادة التسجيل بحسب المرحلة، دون إصدار قرار علاجي آلي.

121. اختبار الجهاز قبل تسجيل العينة والاستشارة

قبل بدء تسجيل العينة، يفحص النظام جاهزية الميكروفون والصوت والأذونات الأساسية، ويطلب من المستفيد تجربة قصيرة للتأكد من أن التسجيل قابل للاستخدام. وقبل اللقاء المرئي أو الصوتي، يتيح اختبار الكاميرا والميكروفون والسماعة والاتصال. هذا الفحص تقني فقط، ولا يعد تقييمًا علاجيًا ولا جزءًا من العينة الرسمية.

122. حفظ المسودة والاستعادة الآمنة

في العمليات الطويلة، مثل التقييم السريري والتقرير النهائي والنماذج، يدعم النظام الحفظ التلقائي للمسودة. عند عودة المستخدم، يستعيد آخر نسخة محفوظة دون تحويل المسودة إلى قرار أو تقرير معتمد. يظهر بوضوح الفرق بين: مسودة، مكتمل، معتمد.

123. عدم اعتبار تحليلات الاستخدام دليلاً سريريًا مستقلاً

يستطيع النظام تحليل الالتزام، وعدد التدريبات، وأوقات الاستخدام، وإعادة مشاهدة النموذج، والتأخر في إرسال العينات. تستخدم هذه البيانات لدعم المتابعة وتحسين البرنامج، لكنها لا تعد وحدها دليلاً على الطلاقة أو نجاح العلاج أو فشله. لا يصدر الذكاء الاصطناعي قرارًا سريريًا اعتمادًا على سلوك الاستخدام وحده.

124. معايير القبول قبل إطلاق أي إصدار

لا يعد الإصدار جاهزًا للإطلاق بمجرد اكتمال البرمجة. يجب اجتياز اختبارات القبول التي تشمل المسار الكامل من التسجيل إلى نهاية البرنامج، ودقة قواعد الـ 72 ساعة، والتدريبات السبعة، والفواصل الزمنية، والعينة المتكاملة، وقفل العينة لأخصائي واحد، والقرارات، والاستشارة المجانية، والانقطاع، والصلاحيات، وسجل التدقيق. يجب اختبار السيناريوهات الطبيعية والاستثنائية والفشل التقني، ولا يعتمد الإصدار إلا بعد قبول مالك البرنامج أو من يفوضه.

125. سجل قرارات حاكم وألوية النصوص

تنشأ للمنصة وثيقة حاكمة موحدة تسمى «سجل القرارات التنفيذية المعتمدة». عند وجود تعارض، تكون الأولوية بالترتيب: آخر قرار صريح اعتمده مالك البرنامج ← التصحيحات الحاكمة ← المتطلبات التنفيذية النهائية ← الوثيقة الأصلية فيما لم يعدل ← أي تصور أو مسودة أقدم لا يختار المصمم أو المبرمج بين نصين متعارضين من عنده، بل يرفع التعارض للحسم قبل التنفيذ. يجب أن تحمل كل نسخة نهائية رقم إصدار وتاريخًا وحالة اعتماد.

حالة الاعتماد

تم اعتماد النقاط 117 إلى 125 جميعًا من مالك البرنامج وإضافتها إلى النسخة المعتمدة للتنفيذ. وبذلك أُغلق سجل الإكمال الوظيفي عند 125 قرارًا تنفيذيًا معتمدًا، مع بقاء التصحيحات الحاكمة اللاحقة هي المرجع الأعلى عند أي تعارض. تبدأ بعد ذلك مرحلة المراجعة الشاملة: مطابقة القرارات مع الوثيقة الأصلية وسجل المحادثة، وكشف النقص والتعارض والتكرار، ثم عرض التصحيحات على مالك البرنامج للتعميد قبل إنتاج الوثيقة التنفيذية النهائية المتكاملة.